



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE REDE DE CUIDADOS JULHO/2026

O presente Relatório de Atividades da Coordenação de Rede de Cuidados apresenta uma síntese estruturada dos resultados, avanços operacionais e desafios identificados nos municípios de Santa Maria Madalena, Cachoeiras de Macacu, Arraial do Cabo, São Gonçalo, Saquarema, Cordeiro e Quissamã ao longo de julho de 2026. A análise consolida evidências produzidas pelas equipes, permitindo compreender a evolução dos principais indicadores, a efetividade dos fluxos assistenciais e o desempenho das linhas de cuidado em cada território.

A atuação das Coordenações tem sido direcionada pela padronização de processos, pela gestão proativa da produção, e pela organização da Rede de Atenção orientada às necessidades reais da população. Esse movimento tem incorporado práticas de monitoramento contínuo, análise crítica de dados, pactuação de metas e intervenções de melhoria com foco no acesso, resolutividade e continuidade do cuidado.

Considerando a heterogeneidade territorial, epidemiológica e operacional entre municípios — que variam desde regiões rurais de difícil acesso até ambientes urbanos de alta complexidade — a Coordenação tem adotado estratégias personalizadas, garantindo que cada linha de cuidado opere com fluidez, responsividade e foco no usuário. Esta abordagem tem fortalecido a integração assistencial e ampliado a capacidade de resposta dos serviços, especialmente nas áreas de atenção primária, especializada, urgência e emergência, materno-infantil, saúde mental e reabilitação.

Reafirma-se assim o compromisso institucional com a melhoria dos desfechos em saúde, com a eficiência na aplicação dos recursos públicos e com a promoção da equidade no acesso, em total alinhamento às diretrizes do SUS e aos instrumentos de planejamento municipal e regional.

Assunto: Números qualitativos do mês de julho de 2026

De: Departamento Assistencial
Para: Departamento Financeiro

Em atendimento ao Comunicado Interno de 29 de julho de 2024 e conforme disposto no item 7.2.1 do Manual de Rateio de Despesas de Gestão, encaminhamos a seguir a planilha com os dados qualitativos e os documentos necessários para o cálculo dos indicadores referentes ao mês de julho de 2026.

Gostaríamos de destacar que as informações foram coletadas e analisadas de acordo com as diretrizes descritas no manual, assegurando a precisão e a conformidade dos dados.

INDICADORES QUALITATIVOS - PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE		
NÚMERO DO CONTRATO DE GESTÃO / ANO	Monitoramento	
	QTD de Atendimentos	%
Contrato de Gestão 033/03/2025 - Santa Maria Madalena	4.409	1,8%
Contrato de Gestão 006/2021 - Cachoeiras de Macacu	11.997	4,8%
Contrato de Gestão 033/2021 - Saquarema Hospitalar	34.753	13,9%
Contrato de Gestão 001/2021 - UMPA Pacheco	11.797	4,7%
Contrato de Gestão 002/2021 - UMPA Nova Cidade	13.049	5,2%
Contrato de Gestão 081/2023 - Arraial do Cabo	52.464	21,1%
Contrato de Gestão 068/2024 - Quissamã	6.131	2,5%
Contrato de Gestão 196/2024 - Cordeiro	4.635	1,9%
Contrato de Gestão 005/2025 - Saquarema Ambulatorial	51.898	20,8%
Contrato de Gestão 006/2025 - Saquarema Atenção Primária	58.024	23,3%
Total	249.157	100%

Além das informações apresentadas na planilha, anexamos os documentos comprobatórios pertinentes conforme exigido pelo item 8 do Manual de Rateio, para validação e auditoria dos dados fornecidos e os relatórios das Coordenações Assistenciais.

Agradecemos a atenção e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Rio Bonito, 31 de agosto de 2026.

RAFAELA OLIVEIRA
FERREIRA:082153297
99

Assinado de forma digital por
RAFAELA OLIVEIRA
FERREIRA:08215329799
Dados: 2026.09.04 08:42:23 -03'00'

Rafaela Oliveira Ferreira
Gerente Assistencial

1. Contrato de Gestão 033/03/2025 - Santa Maria Madalena

Contrato de Gestão 033/03/2025 - Santa Maria Madalena	
Atendimento de emergência	947
Atendimento ambulatorial	634
Atenção Básica e ESF	1.803
Centro de Atenção Psicossocial	1.025

Hospital Municipal Basileu Estrela - Atendimento de emergência

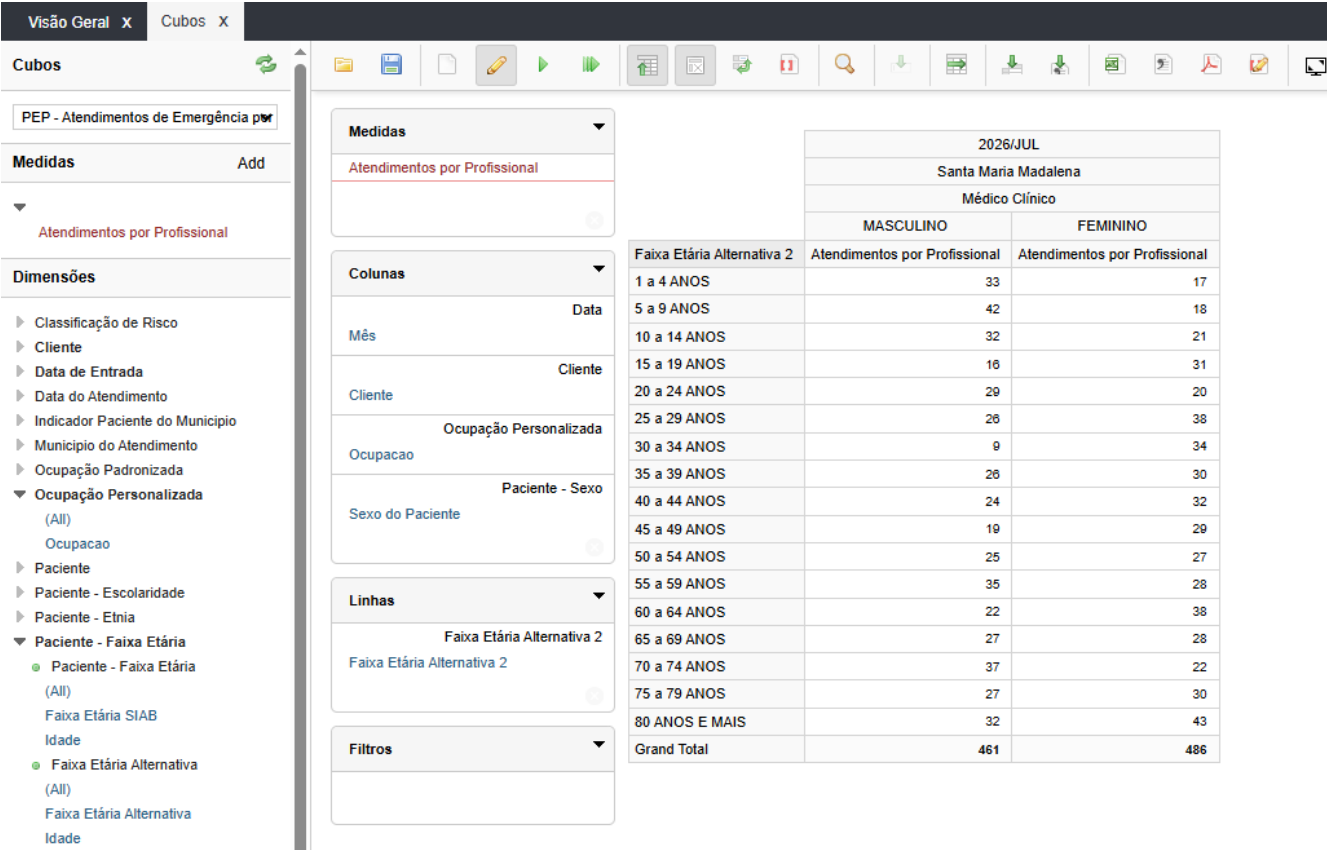


Figura 1 - Número de atendimentos Médicos - Hospital Basileu Estrela - Fonte: B.I - Data da Extração: 10/08/2026



Hospital Municipal Basileu Estrela - Atendimento ambulatorial

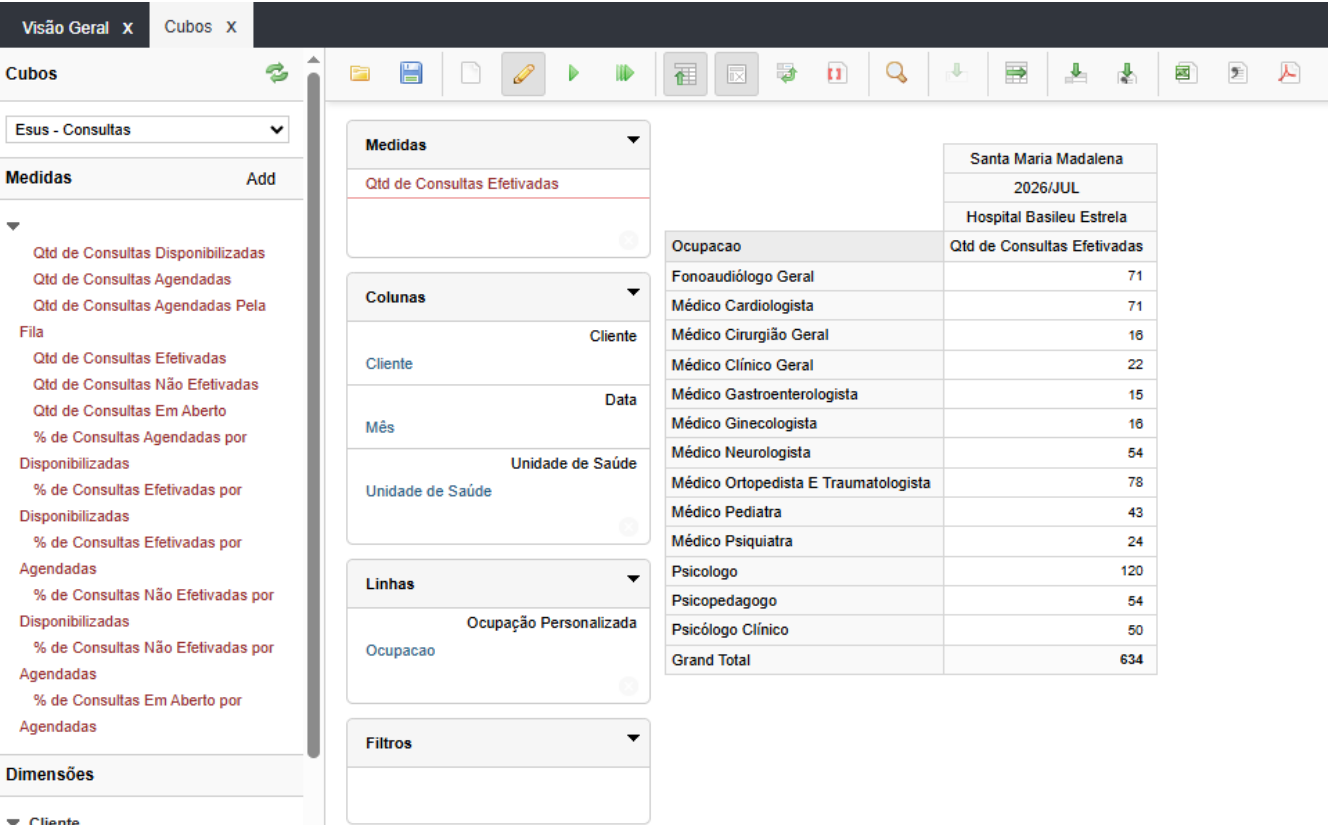


Figura 2 - Número de consultas efetivadas - Fonte: B.I - Data da Extração: 04/08/2026

Atenção Básica e ESF

Atendimento cirurgião dentista

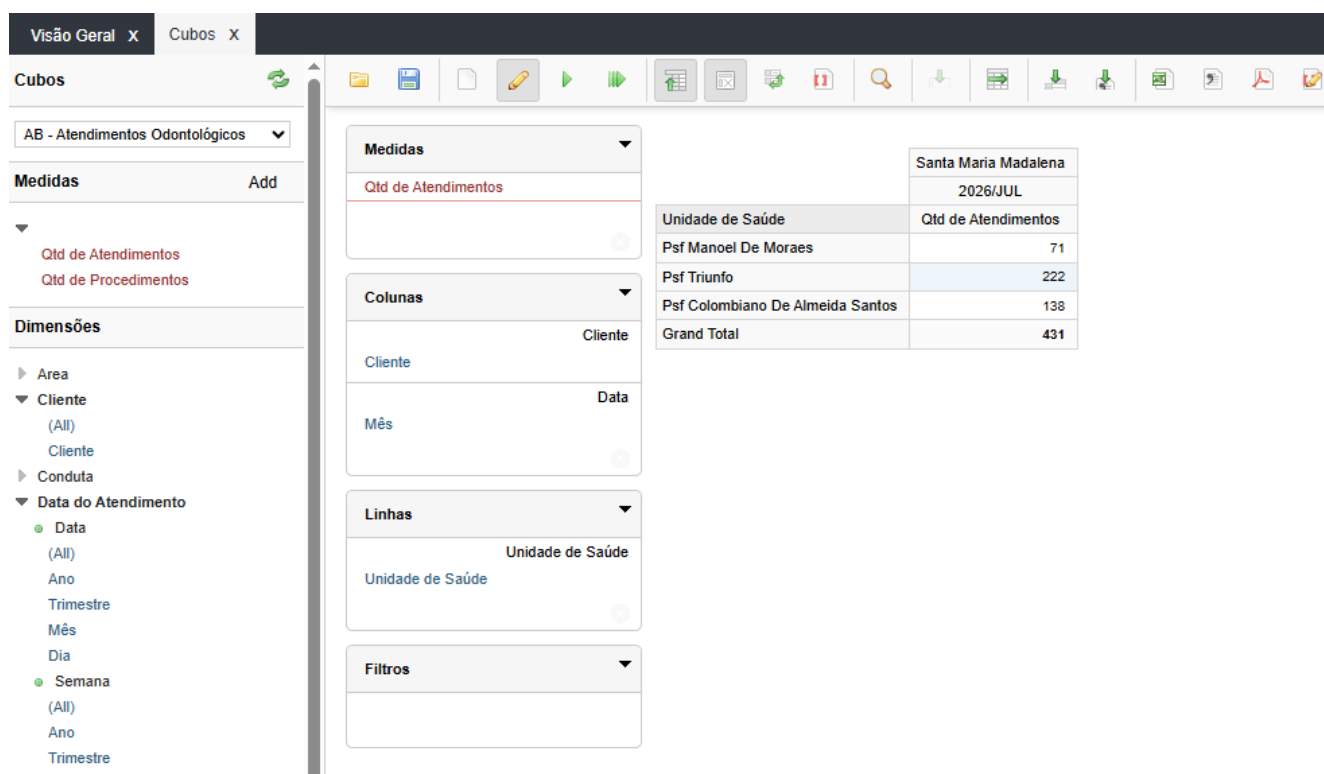


Figura 3 – Número de Atendimentos efetivados pelo Cirurgião Dentista da Estratégia de saúde da Família no prontuário eletrônico.
Fonte: B.I - Data da Extração: 04/08/2026

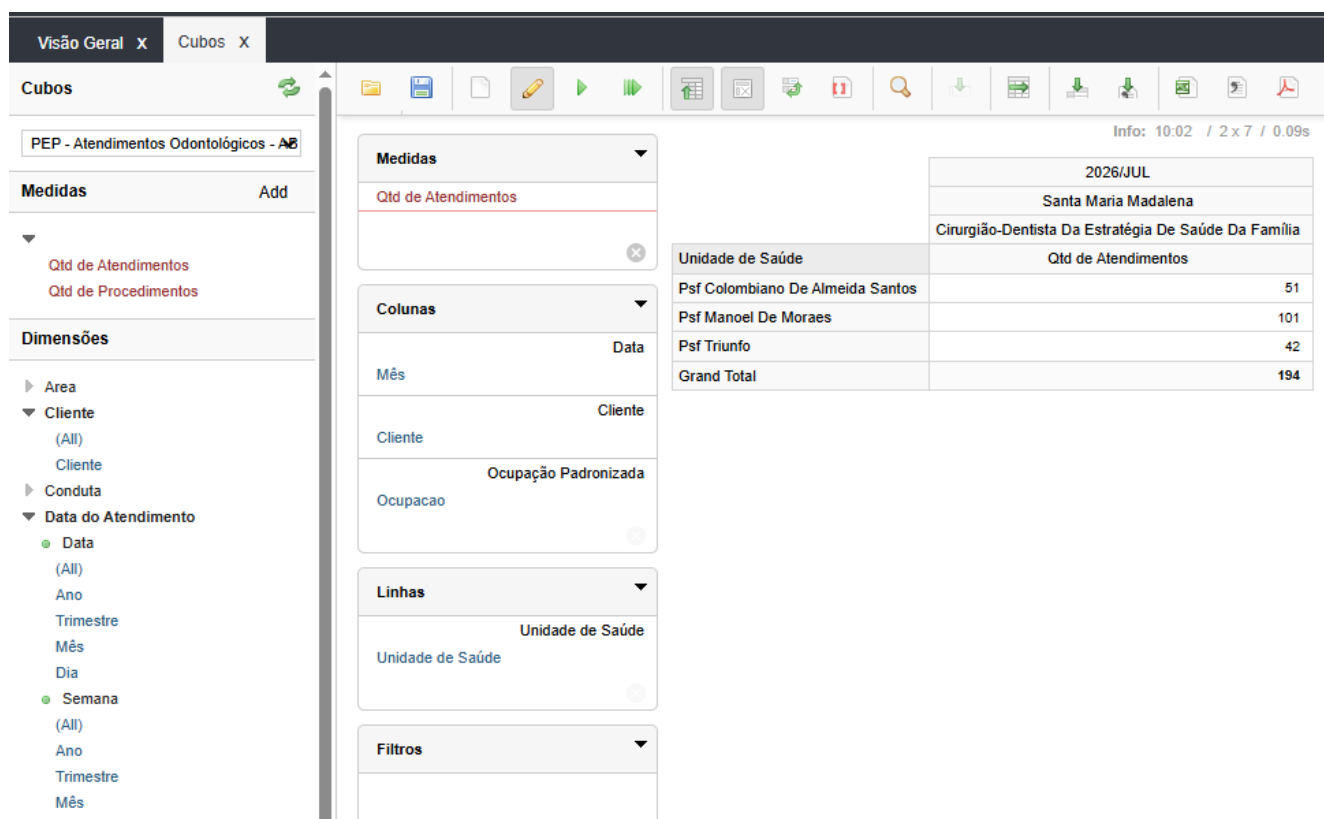


Figura 4 - Número de Atendimentos odontológicos no sistema de Atenção Básica. Fonte: B.I - Data de extração: 10/08/2026

Atendimento Médico e de Enfermeiro

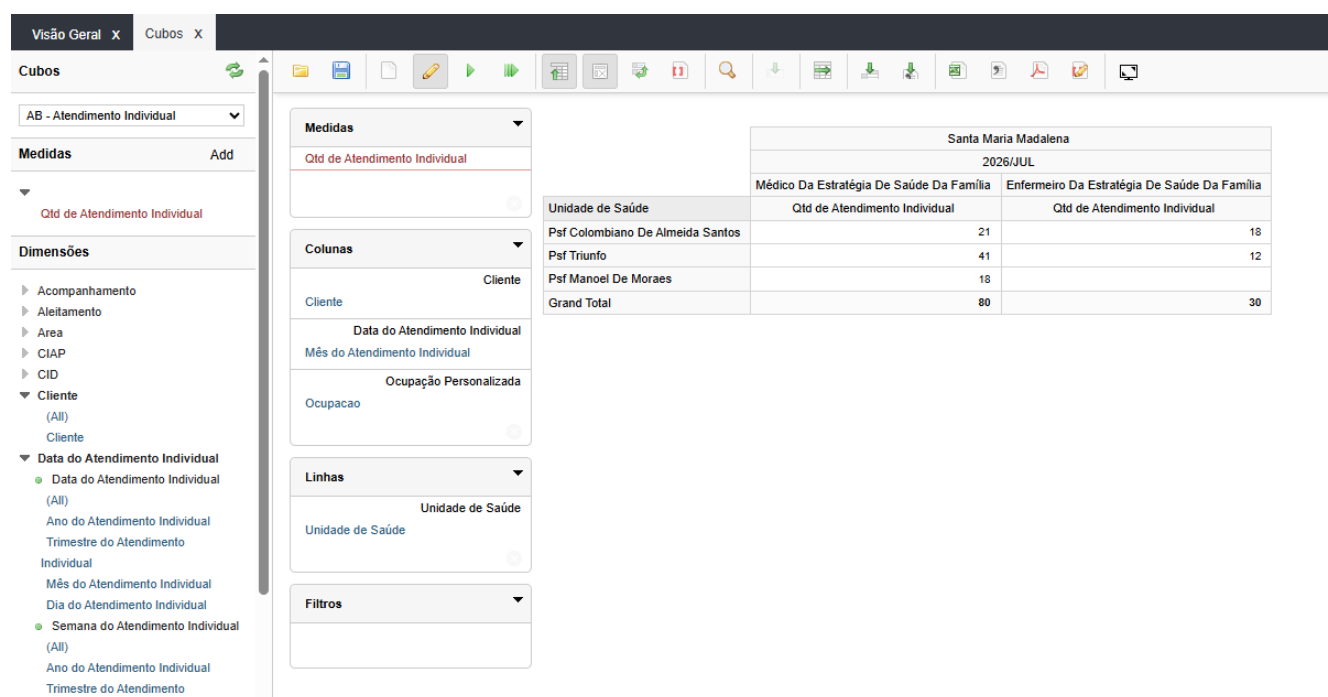


Figura 5 - Número de atendimentos individuais de Médicos e enfermeiros no sistema de atenção básica. Fonte: B.I - Data da Extração: 04/08/2026

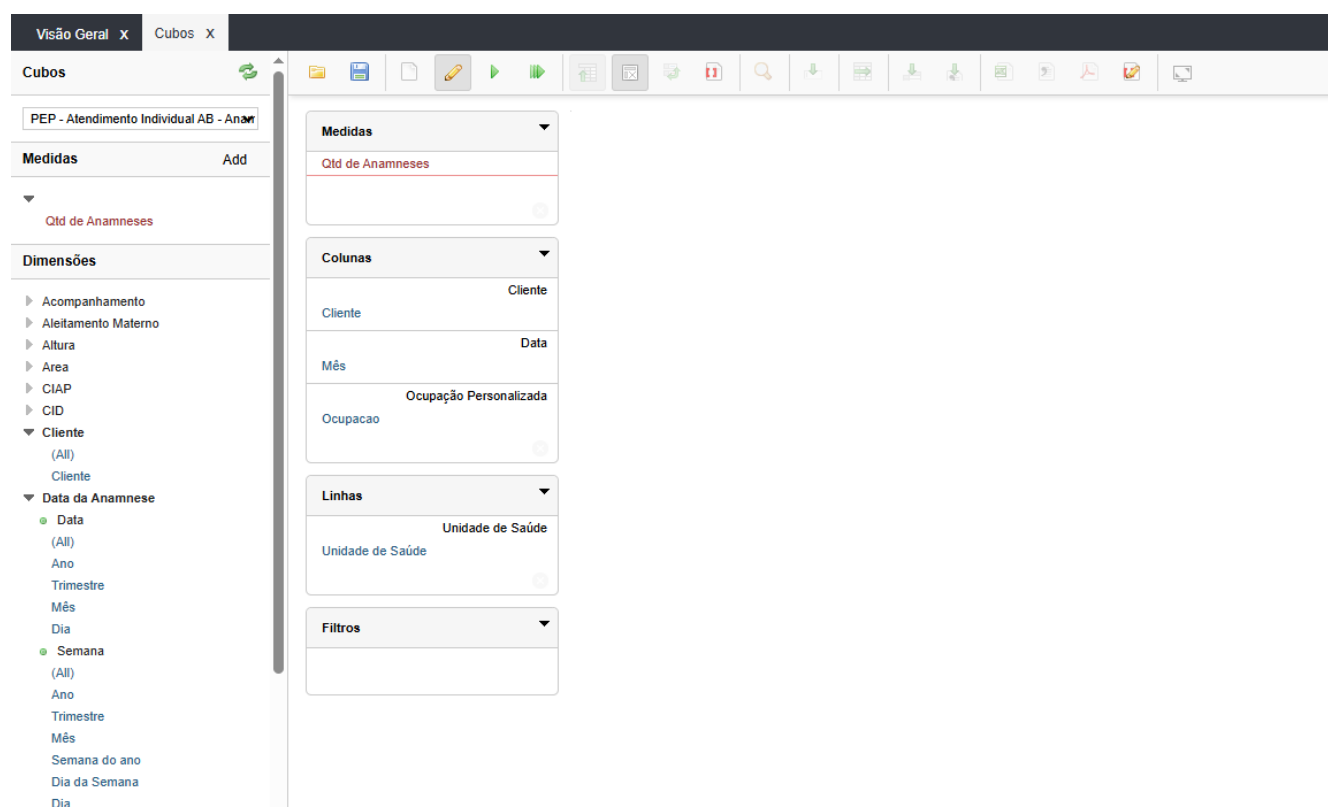


Figura 6 - Número de atendimentos individuais de Médicos e enfermeiros no sistema de prontuário eletrônico. Fonte: B.I - Data da Extração: 04/08/2026

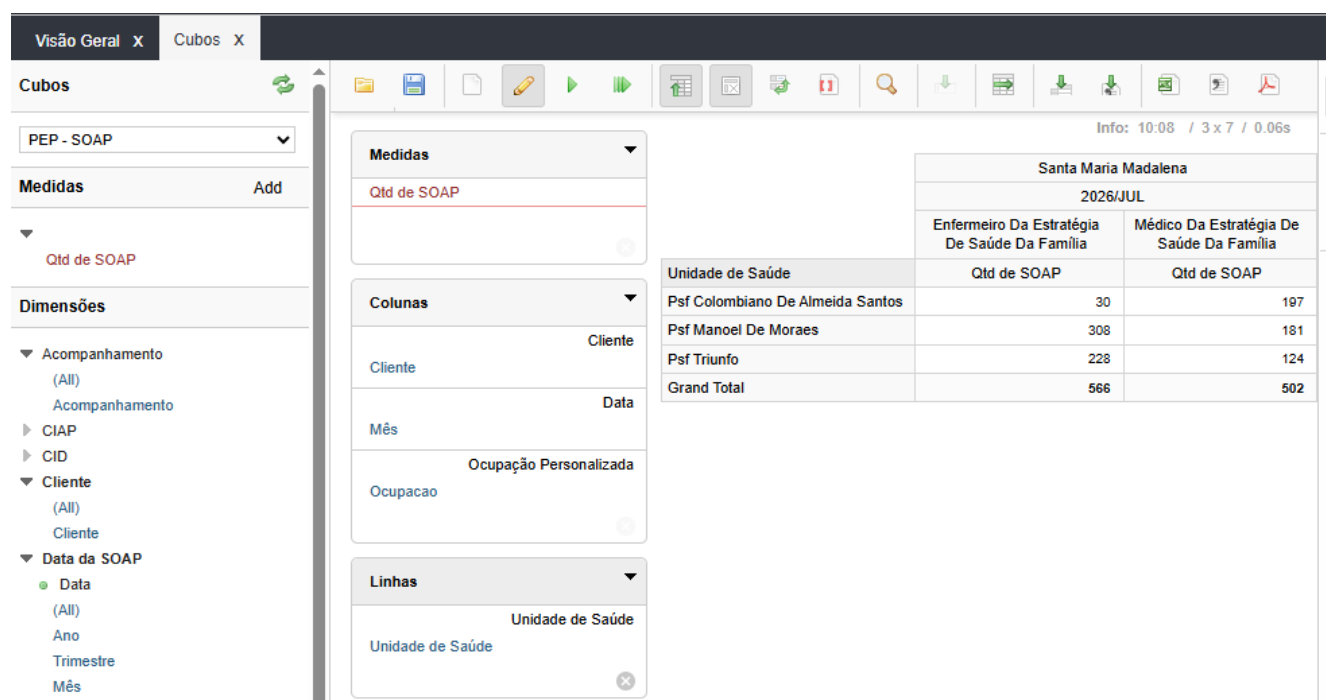


Figura 7 - Número de atendimentos individuais de Médicos e enfermeiros no sistema de prontuário eletrônico. Fonte: B.I - Data da Extração: 10/08/2026

Centro de Atenção Psicossocial

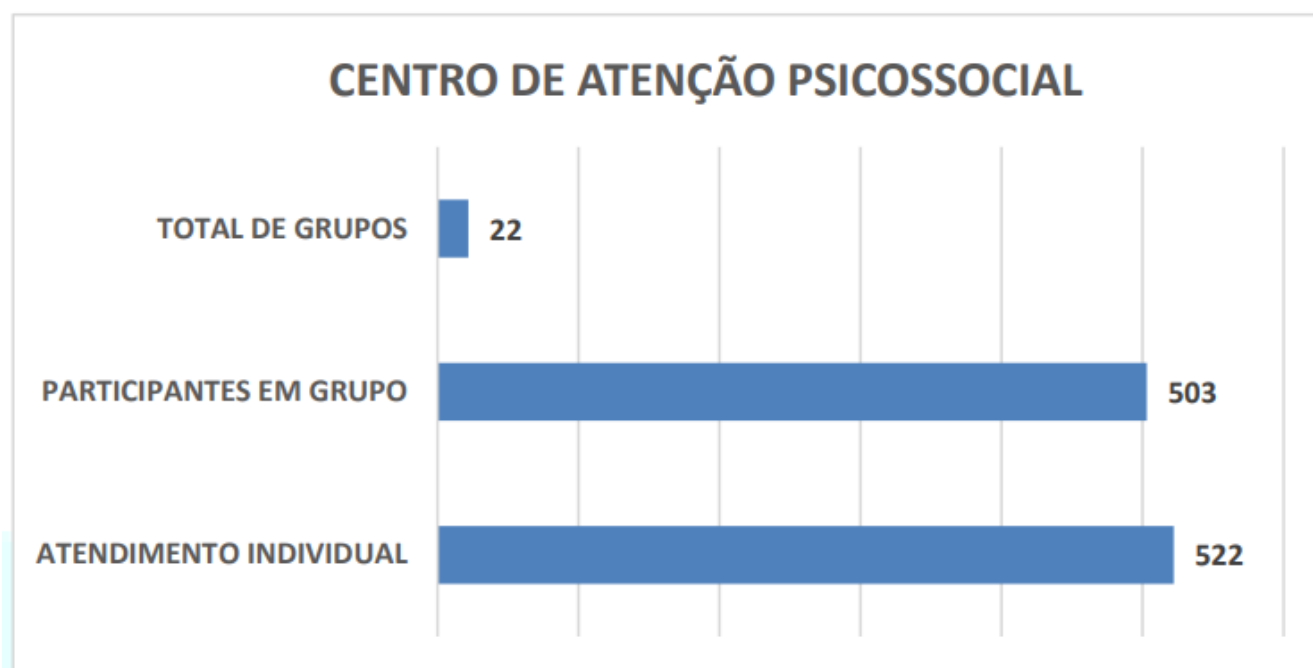


Figura 8- Atendimentos no CAPS: total de grupos se refere à quantidade de grupos realizados, atendimento em grupo se refere a quantidade de participantes totais nos grupos e atendimento individual. Fonte: E-mail - Data da Extração: 06/08/2026

2. Contrato de Gestão 006/2021 - Cachoeiras de Macacu

Contrato de Gestão 006/2021 - Cachoeiras de Macacu	
Atendimento de emergência (HMCM)	6.517
Atendimento de emergência (UPA)	5.480

Atendimento de emergência (HMCM)

Atendimentos por Ocupação Julho 2026

Unidade de Saúde: HOSPITAL DR. CELSO MARTINS

Ocupao	Classificados	Não Classificados	Total
Clínico Geral	4	0	4
Médico Ginecologista E Obstetra	249	3	252
Médico Cirurgião Geral	180	42	222
Médico Clínico	4.215	232	4.447
Médico Ortopedista E Traumatologista	514	49	563
Médico Pediatra	1.025	4	1.029
Total	6.187	330	6.517

Figura 3 - Número de atendimentos de emergência. Fonte: B.I - Data da Extração: 03/08/2026

Atendimento de emergência (UPA)

Atendimentos por Ocupação Julho 2026

Unidade de Saúde: UPA PREFEITO RUY COELHO GOMES

Ocupao	Classificados	Não Classificados	Total
Médico Clínico	4.230	8	4.238
Médico Pediatra	1.241	1	1.242
Total	5.471	9	5.480

Figura 10 - Número de atendimentos de emergência. Fonte: B.I - Data da Extração: 05/08/2026



3. Contrato de Gestão 033/2021 - Saquarema Hospitalar

Contrato de Gestão 033/2021 - Saquarema Hospitalar	
Hospital Municipal Nossa Senhora do Nazareth	4.794
Hospital Municipal Porphirio Nunes de Azeredo	13.570
PU Saquarema	5.104
PU Jaconé	4.540
PU Sampaio Corrêa	2.370
Socorro Saúde	695
Centro Municipal de Imagem	3.680

Hospital Municipal Nossa Senhora do Nazareth

Consultas Especializadas	JULHO
Cirurgia Geral	260
Proctologia	33
Cirurgia Ortopédica	241
Cirurgia Ginecológica	83
Cirurgia Urológica	112
Cirurgia Neurológica	50
Cirurgia Vascular	21
Cirurgia Pediátrica	74
Cirurgia Oncológica	28
Cirurgia Plástica	3
Cirurgia Torácica	2
Dermatologia	4
Risco Anestésico	58
Bucomaxilo	41
Cirurgia Cabeça e Pescoço	40
Oncologia Clínica	78
Otorrino	65
Atendimento de Urgência	54
Dentista	976
Enfermagem	232
Farmacêutico	118
Nutrólogia	4
Psicologia	1026
Assistente Social	1091
Fonoaudiologia	39
Terapia Ocupacional	61
Total	4.794

Figura 11- Número de atendimentos, consultas e cirurgias. Fonte: Gerenciador Saquarema Hospitalar - Data da extração: 06/08/2026

Hospital Municipal Porfirio Nunes de Azeredo**Atendimentos por Ocupação Julho 2026****Unidade de Saúde:** HOSPITAL MUNICIPAL PORPHIRIO NUNES DE AZEREDO

Ocupao	Classificados	Não Classificados	Total
Médico Cirurgião Geral	107	30	137
Médico Clínico	8.297	777	9.074
Médico Gastroenterologista	1	3	4
Médico Generalista	364	24	388
Médico Neurocirurgião	2	0	2
Médico Neurologista	1	0	1
Médico Ortopedista E Traumatologista	882	145	1.027
Médico Pediatra	2.929	5	2.934
Médico Psiquiatra	1	2	3
Total	12.584	986	13.570

*Figura 12- Número de atendimento de emergência por ocupação. Fonte B.I - Data da Extração: 14/08/2026***PU Saquarema****Atendimentos por Ocupação Julho 2026****Unidade de Saúde:** POSTO DE URGENCIA DE SAQUAREMA

Ocupao	Classificados	Não Classificados	Total
Médico Clínico	4.401	117	4.518
Médico Generalista	518	14	532
Médico Neurologista	48	2	50
Médico Pediatra	4	0	4
Total	4.971	133	5.104

Figura 13- Número de atendimento de emergência por ocupação. Fonte B.I - Data da Extração: 14/08/2026

PU Jaconé

Atendimentos por Ocupação Julho 2026

Unidade de Saúde: POSTO DE URGENCIA DE JACONE

Ocupao	Classificados	Não Classificados	Total
Médico Clínico	3.345	60	3.405
Médico Generalista	100	0	100
Médico Pediatra	1.026	9	1.035
Total	4.471	69	4.540

Figura 14- Número de atendimento de emergência por ocupação. Fonte B.I - Data da Extração: 14/08/2026

PU Sampaio Corrêa

Atendimentos por Ocupação Julho 2026

Unidade de Saúde: POSTO DE URGENCIA DE SAMPAIO CORREA

Ocupao	Classificados	Não Classificados	Total
Médico Clínico	2.315	17	2.332
Médico Gastroenterologista	1	0	1
Médico Neurologista	37	0	37
Total	2.353	17	2.370

Figura 15- Número de atendimento de emergência por ocupação. Fonte B.I - Data da Extração: 14/08/2026



**PRIMA
QUALITÀ
SAÚDE**

Socorro Saúde



**PRIMA
QUALITÀ
SAÚDE**

RELATÓRIO DO MÊS DE JULHO/2026 SOCORRO SAÚDE.

Introdução:

O socorro saúde proporciona ao município de saquarema um serviço de APH (atendimento pré-hospitalar) que se dá desde o momento da solicitação através da chamada telefônica pelos 0800 e se encerra ao fim do atendimento médico ou após a entrega do paciente ao serviço hospitalar.

Na central dos 0800, realizamos uma triagem e coleta de dados do solicitante para após avaliação empenhar no atendimento o melhor recurso necessário para o caso, assim como auxiliar a equipe das viaturas no acionamento de outros recursos necessários como PMERJ e CBMERJ, assim como na identificação de situações vulneráveis /recorrentes aonde após sinalização da equipe a coordenação realiza relatório técnico sobre a questão e encaminha aos setores pertinentes (CRAS/CREAS/CAPS/ESF...).

As equipes de solo objetivam o atendimento de excelência sempre visando um bom tempo resposta (tempo entre a chamada até a chegada ao local e prestação do cuidado) e objetivando a máxima resolutividade em domicílio e quando não possível a resolução no lugar que o paciente seja direcionado para o recurso adequado (Hospital/PU) já avaliado pela equipe médica, medicado e prestado informações aos familiares quanto ao motivo da remoção.

Neste relatório constam os dados mensais de atendimentos.

Dados de atendimentos.

- Julho de 2026 totalizou 695 atendimentos (incluindo saída da base) pelas equipes, sendo divididos em 437 atendimentos da equipe avançada, 258 atendimentos da equipe básica.

Com a totalização de 244 pacientes removidos a unidade hospitalar e 168 pacientes atendidos e sem a indicação de remoção, 25 óbitos e 258 TIH (TRANSFERÊNCIA INTRA HOSPITALAR).

Tempo de prontidão (Mês de Julho): 34:17 = 2057/695 ocorrências.

Dando uma média de 2,96

Atenciosamente;

Equipe do Socorro Saúde

Saquarema, 11 de agosto de 2026

Documento assinado digitalmente:
gov.br CATHERINE BRAGANÇA DE MORAES
Data: 12/08/2026 08:18:25-0100
Verifique em <https://validar.jt.gov.br>

Figura 16- Relatório de Produção da unidade - fonte: e-mail - Data da extração 12/08/2026

Centro Municipal de Imagem

Centro Municipal De Imagem		
Setor	Qtd de Exames Agendados	Qtd de Exames Efetivados
ECOCARDIOGRAMA	272	201
ECODOPPLER DE CAROTIDAS	150	122
DESINDOMETRIA OSSEA	202	70
ULTRASSONOGRRAFIA	2.016	1.322
COLONOSCOPIA	38	31
HOLTER 24H	90	74
M.A.P.A	90	75
TOMOGRAFIA	1.852	1.651
ENDOSCOPIA	170	134
TOTAL	4.880	3.680

Figura 17 - Relatório de exames da unidade - fonte: documento enviado por e-mail - Data da extração 15/08/2026

4. Contrato de Gestão 001/2021 - UMPA Pacheco

Contrato de Gestão 001/2021 - UMPA Pacheco	
Atendimento de emergência	11.797

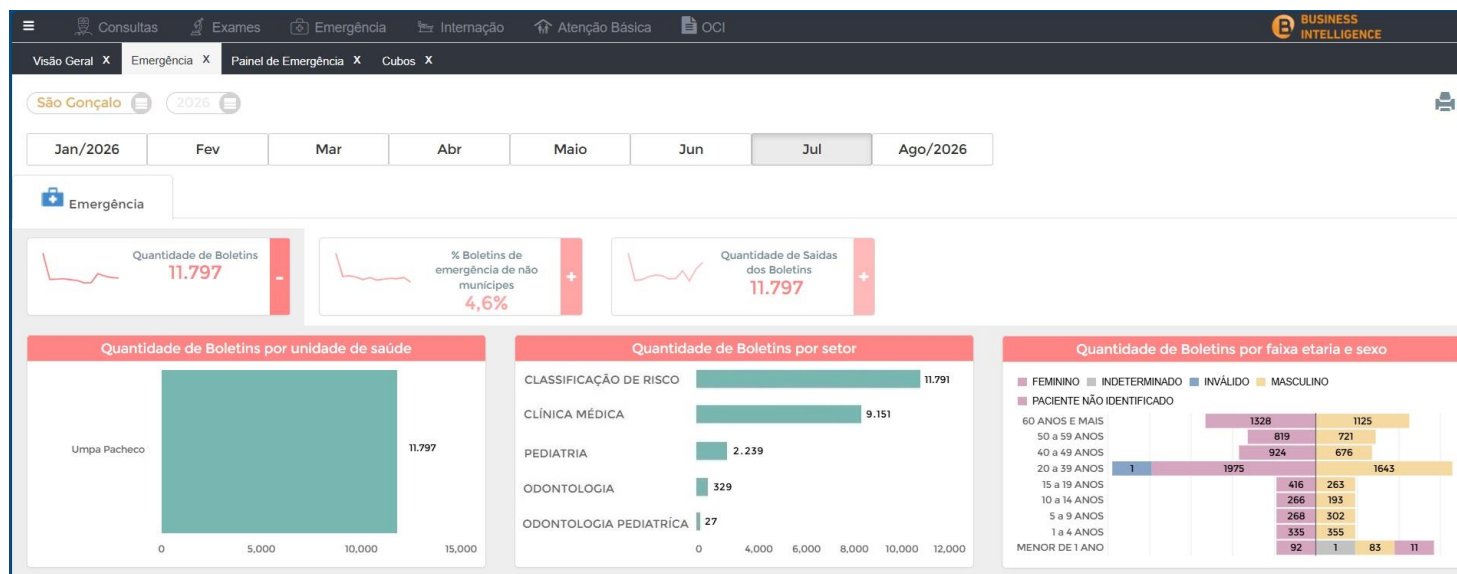


Figura 18 - Número de atendimento de emergência por ocupação. Fonte B.I - Data da Extração:04/08/2026

5. Contrato de Gestão 002/2021 - UMPA Nova Cidade

Contrato de Gestão 002/2021 - UMPA Nova Cidade	
Atendimento de emergência	13.049

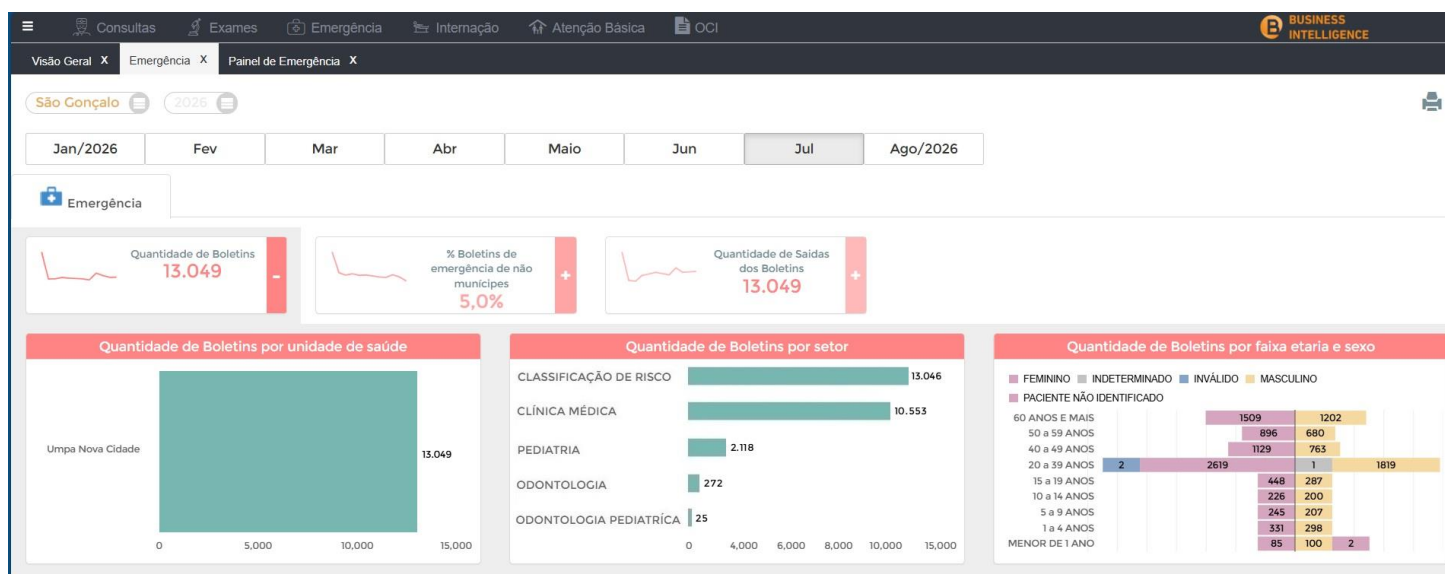


Figura 19- Número de atendimento de emergência por ocupação. Fonte B.I - Data da Extração:04/08/2026

6. Contrato de Gestão 081/2023 - Arraial do Cabo

Contrato de Gestão 081/2023 - Arraial do Cabo	
Hospital Municipal Geral de Arraial do Cabo	8.969
Pronto Socorro de Figueira	4.824
Centro Especializado em Reabilitação	3.783
Central de Exames	3.970
Central de Marcação	6.535
Centro de Atenção Psicossocial	1.869
Policlínica	4.227
Central de Transporte	1.307
Centro Oftalmológico	1.978
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	1.790
Atenção Básica e ESF	9.076
E-Multi (Nasf)	2.507
Melhor em Casa (SAD)	267
Centro de Doenças Infecciosas	644
Casa do Autista	718

Hospital Municipal Geral de Arraial do Cabo**Atendimentos por Ocupação Julho 2026****Unidade de Saúde:** HOSPITAL GERAL DE ARRAIAL DO CABO

Ocupação	Classificados	Não Classificados	Total
Médico Cirurgião Geral	8	0	8
Médico Clínico	7.616	159	7.775
Médico Ginecologista E Obstetra	135	4	139
Médico Ortopedista E Traumatologista	199	39	238
Médico Pediatra	801	8	809
Total	8.759	210	8.969

*Figura 20 - Número de atendimento de emergência por ocupação. Fonte B.I - Data da Extração:06/08/2026***Pronto Socorro de Figueira****Atendimentos por Ocupação Julho 2026****Unidade de Saúde:** PRONTO SOCORRO BARBARA AMARAL DE MACEDO

Ocupação	Classificados	Não Classificados	Total
Cirurgião Dentista - Clínico Geral	288	2	290
Cirurgião Dentista - Traumatologista Bucomaxilofacial	39	0	39
Médico Clínico	3.876	177	4.053
Médico Pediatra	433	9	442
Total	4.636	188	4.824

Figura 21- Número de atendimento de emergência por ocupação. Fonte B.I - Data da Extração:06/08/2026

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO MENSAL – CER

Mês Julho de 2026

Nossa equipe é composta de 03 (três) Fisioterapeutas e 04 (Quatro) psicólogo, além da equipe administrativa e de apoio. Sendo realizados atendimentos específicos em Neurologia Adulto, Traumato/Ortopedia, Oncologia, Acupuntura, Fisioterapia Respiratória, Reumatologia, Pediatria e Psicologia.

Atendimentos:

Atendimento CER			
Fisioterapia	Psicologia	Consultas	Total
1754	546	1483	3783

Figura 22- Relatório de atendimentos da unidade - fonte: documento enviado por e-mail - Data da extração 06/08/2026

Central de Exames**DE:** COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CENTRAL DE EXAMES**PARA:** GESTÃO DE CONTRATOS - PRIMA QUALITÁ SAÚDE**ASSUNTO:** Produção da Central de Exames Julho/2026

Segue a produção de Julho/2026 da Central de Exames.

EXAME	AGENDADOS	EFETIVADOS	ABSENTEÍSMO	
RAIO X	418	418	0	0%
DENSITOMETRIA ÓSSEA	50	50	0	0%
DOPPLER	412	346	66	16%
ULTRASSONOGRRAFIA	1.935	1.442	493	25%
MAMOGRAFIA	170	120	50	29%
TESTE ERGOMÉTRICO	45	32	13	28%
MAPA	138	87	51	36%
HOLTER	58	40	18	31%
TOMOGRAFIA	1.246	1.246	0	0%
COLONOSCOPIA/ENDOSCOPIA	114	72	42	36%
ECOCARDIOGRAMA	93	75	18	19%
ELETROENCEFALOGRAMA	59	42	17	28%
TOTAL	4.738	3.970	768	16%

Figura 23- Relatório de exames da unidade - fonte: documento enviado por e-mail - Data da extração 11/08/2026



Central de Marcação

Visão Geral X Cubos X	
Cubos	
Esus - Fila de Consultas	
Medidas Add	
Dimensões	
Medidas	
Qtde de Pacientes que Saíram da Fila	
Colunas	
Linhas	
Filtros	
Arraial do Cabo	
2026/JUL	
Qtde de Pacientes que Saíram da Fila	
Unidade de Saúde	Ocupacao
Unidade Externa	Médico Dermatologista
	Médico Mastologista
Centro Oftalmológico Jairo Pinto De Oliveira	Médico Oftalmologista
Policlinica Municipal De Arraial Do Cabo	Medico Nefrologista
	Médico Alergista E Imunologista
	Médico Anestesiologista
	Médico Angiologista
	Médico Cardiologista
	Médico Cirurgião Geral
	Médico Cirurgião Pediatrico
	Médico Coloproctologista
	Médico Dermatologista
	Médico Endocrinologista E Metabologista
	Médico Gastroenterologista
	Médico Geriatria
	Médico Ginecologista E Obstetra
	Médico Hematologista
	Médico Neurologista
	Médico Ortopedista E Traumatologista
	Médico Otorrinolaringologista
	Médico Pediatra
	Médico Pneumologista
	Médico Psiquiatra
	Médico Reumatologista
	Médico Urologista
Ceo David Segundo Ayres De Oliveira	Cirurgião Dentista - Endodontista
	Cirurgião Dentista - Protesista
Hospital Geral De Arraial Do Cabo	Médico Angiologista
	Grand Total

Figura 24- quantidade de pacientes que saíram da fila no período separados por unidade de saúde. Fonte B.1 - Data da Extração:11/08/2026

Centro de Atenção Psicossocial

ATENDIMENTOS	Julho/26
ATENDIMENTO INDIVIDUAL	1331
ATENDIMENTO EM GRUPO	538
TOTAL DE ATENDIMENTOS	1869

Figura 25- Número de atendimento realizados no período. Fonte: relatório enviado por e-mail - Data da Extração:11/08/2026





Central de Transporte



RELATÓRIO DE PRODUÇÃO MENSAL – CENTRAL DE TRANSPORTES

No mês de julho, tivemos 408 atendimentos de Resgate, 163,20% da meta proposta conforme demonstrado no quadro abaixo, mesmo com a demanda de eventos, férias, apoio à equipe de remoção do HGAC e da Secretaria de Saúde, nossa equipe conseguiu obter um tempo de resposta abaixo da meta proposta, e conseguimos atingir o maior número de atendimentos desde a criação do setor de Resgate. Isso demonstra total comprometimento com o serviço oferecido à população.

RESGATE	
Meta	250
Total de Atendimentos	408
%	163,20%

RESGATE	
Meta	<= 5min
Tempo médio de atendimento (1.996 minutos / 408 chamados) = 4.53 minutos	

Sobre os atendimentos do TFD, tivemos 899 pacientes atendidos, um número acima da meta proposta e também o maior número de atendimentos desde a implementação do serviço com carros de passeio. Conforme demonstrado no quadro abaixo e tivemos um total de apenas 2,92% de absenteísmo.

TFD	
Meta	600
Total de Atendimentos	899
%	149,83%

TFD	
Número de pacientes agendados	926
Número de pacientes cancelados	27
Taxa de Absenteísmo	2,92%


Rodrigo dos Santos Coelho
Coordenador Administrativo
Central de Transportes

Rodrigo dos Santos Coelho
Coordenador Administrativo
Central de Transportes

Figura 27- Número de atendimento realizados na unidade no período. Fonte: relatório enviado por e-mail - Data da Extração: 05/08/2026

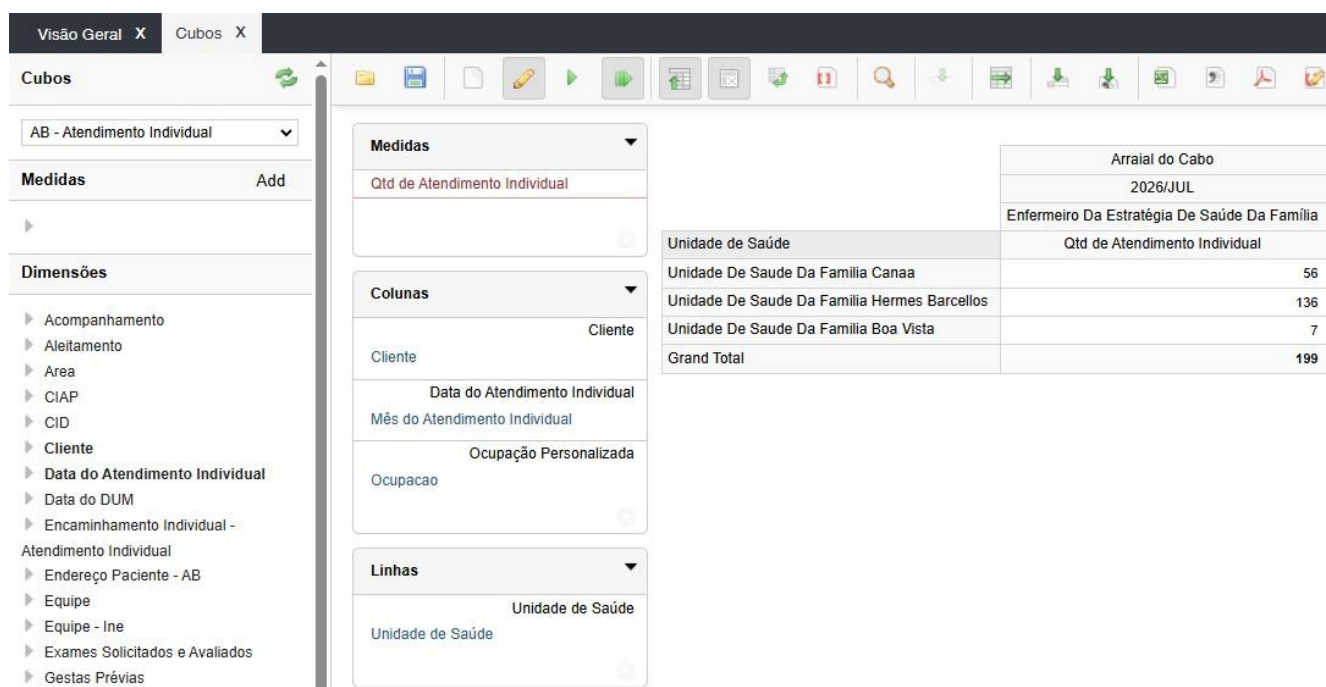


Figura 31- Número de atendimento de médico e enfermeiro. Fonte B.I - Data da Extração:06/08/2026

Procedimentos Odontológicos. Sistemas PEP e AB

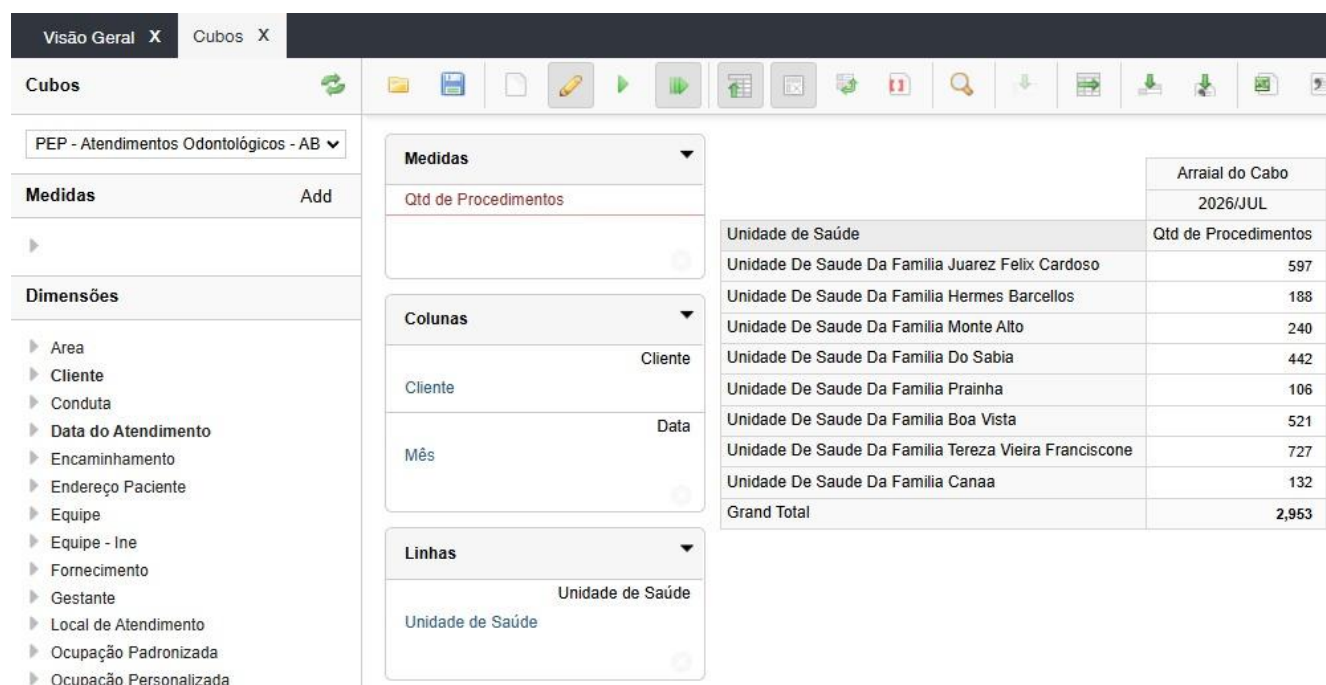


Figura 32- Quantidade de procedimentos realizados por cirurgião dentista. Fonte B.I - Data da Extração:06/08/2026



E-Multi

Unidade de Saúde	JULHO, 2026		Total de respostas aos encaminhamentos EMULTI
	Total de atendimentos realizados	Total de encaminhamentos EMULTI	
ESF BOA VISTA	416	410	410
ESF FIGUEIRA	428	425	425
ESF JUAREZ FELIX	267	265	265
ESF MONTE ALTO	242	238	238
ESF PRAINHA	206	200	200
ESF SABIÁ	277	275	275
ESF HERMES	350	348	348
ESF CANAÃ	321	315	315
TOTAL	2507	2476	2476

Figura 33- quantidade de atendimentos realizados pela equipe e-multi, quantidade de pacientes encaminhados para e-multi e quantidade de respostas realizadas pela e-multi. Fonte: relatório enviado por e-mail – Data da extração: 11/08/2026

SAD

ATENDIMENTO POR OCUPAÇÃO SAD	
JULHO, 2026	
OCUPAÇÃO	ATENDIMENTO
ENFERMEIRO	66
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	93
ASSISTENTE SOCIAL	9
FISIOTERAPEUTA	22
MEDICO	77
TOTAL	267

Figura 34- Quantidade de atendimentos por ocupação. Fonte B.I - Data da Extração: 11/08/2026



Centro de Doenças Infecciosas

<u>RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS</u>	
CBO	ATENDIMENTO INDIVIDUAL
ATENDIMENTO DA INFECTOLOGISTA	107
ATENDIMENTO DA DERMATOLOGISTA SANITÁRIA	26
ATENDIMENTO DA PSICOLOGA	44
ATENDIMENTO DA ASSIS. SOCIAL	16
ATENDIMENTO DA ENFERMAGEM	188
COLETAS DE SANGUE	48
PPD	43
TRD (TESTAGEM RÁPIDO DE DIAGNÓSTICO)	36
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	136
TOTAL:	644

Figura 35- Número de atendimento e medicamentos disponibilizados. Fonte: relatório enviado por e-mail - Data da Extração: 06/08/2026



Casa do Autista

Relatório Quantitativo de Atendimentos:

Psicóloga Ana Clara	79
Psicóloga Alice	77
Psicóloga Rozilda	0 (Férias)
Psicopedagoga Raquel	41
Psicopedagoga Andrea	10 (férias)
Psicopedagoga Taina	75
Assistente Social Leticia	18
Nutricionista Juliana	46
Nutricionista Mariá	12 (férias)
Psiquiatra Lilian	74
Psiquiatra Rodrigo	75
Fonoaudiologa Andrea Lucia	136
Fonoaudiologa Renata	38
Fonoaudióloga Sandra	37
TOTAL	718

Figura 36- Número de atendimento realizados. Fonte: relatório enviado por e-mail - Data da Extração:05/08/2026

7. Contrato de Gestão 068/2024 - Quissamã

Contrato de Gestão 068/2024 - Quissamã	
Atenção Básica e ESF	5.067
E-Multi (Nasf)	566
Exame de TC	498



Nº	Equipe de Atenção Básica	Produção Mês
1	Consulta Médica na ESF	2.327
2	Consulta de Enfermagem na ESF	712
3	Procedimentos odontológicos	2.028
4	Atendimento NASF	566
5	Exame de TC	498

Atenção Básica e ESF

Atendimento Médico e de Enfermeiro

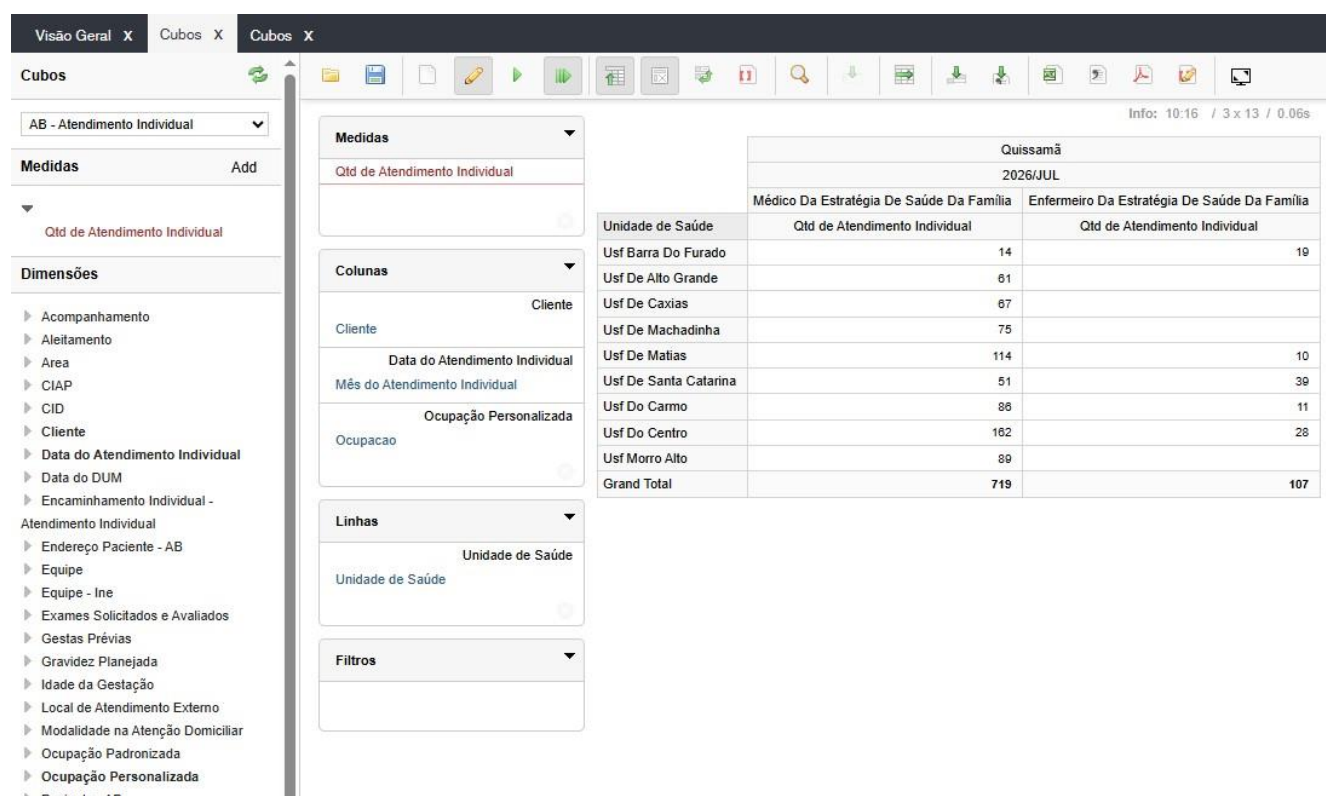


Figura 37- quantidade de atendimento de médicos e enfermeiros. Fonte: B.I - Data da Extração:10/08/2026

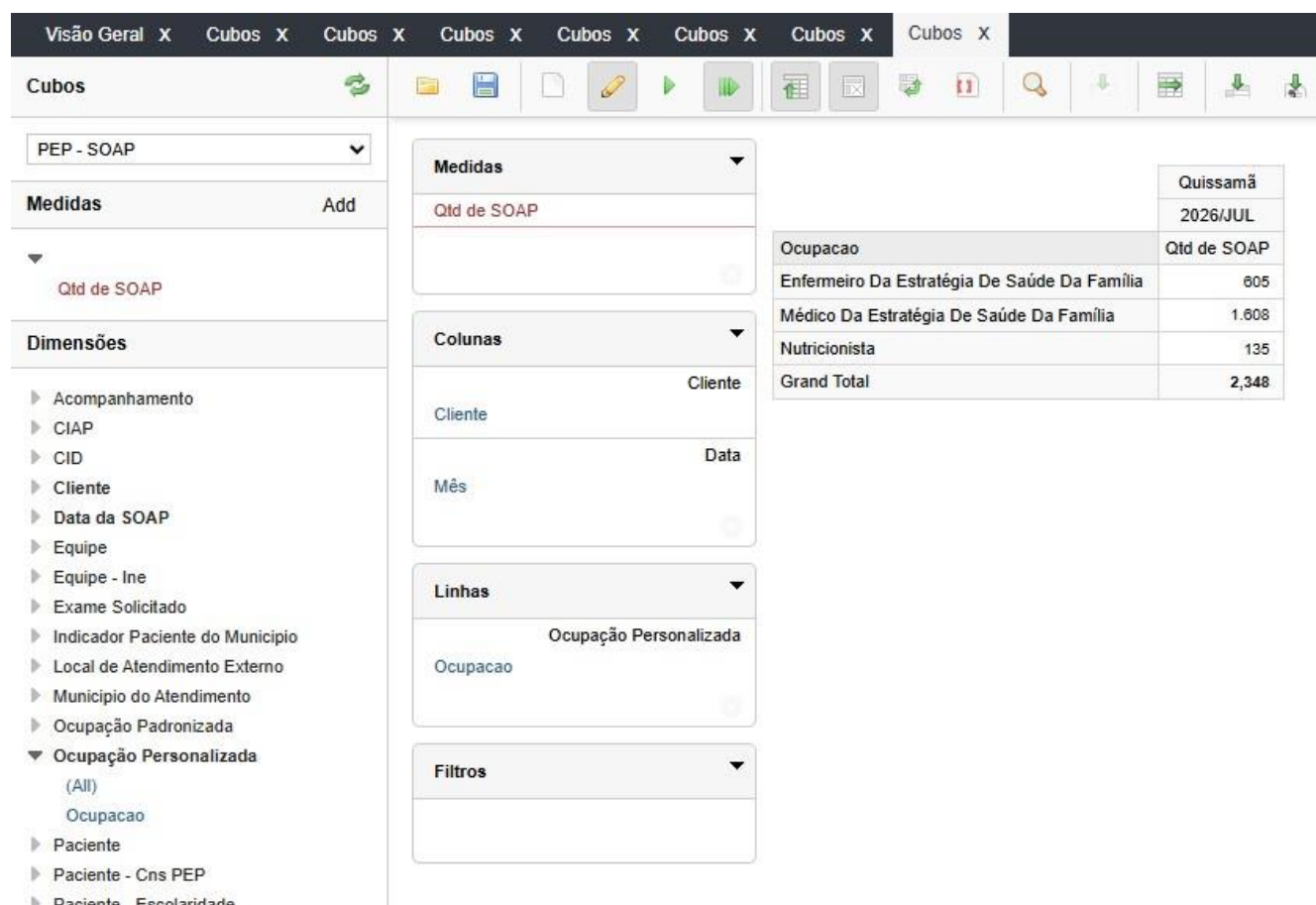


Figura 38- quantidade de atendimento por ocupação. Fonte: B.I - Data da Extração:10/08/2026

Procedimentos Odontológicos

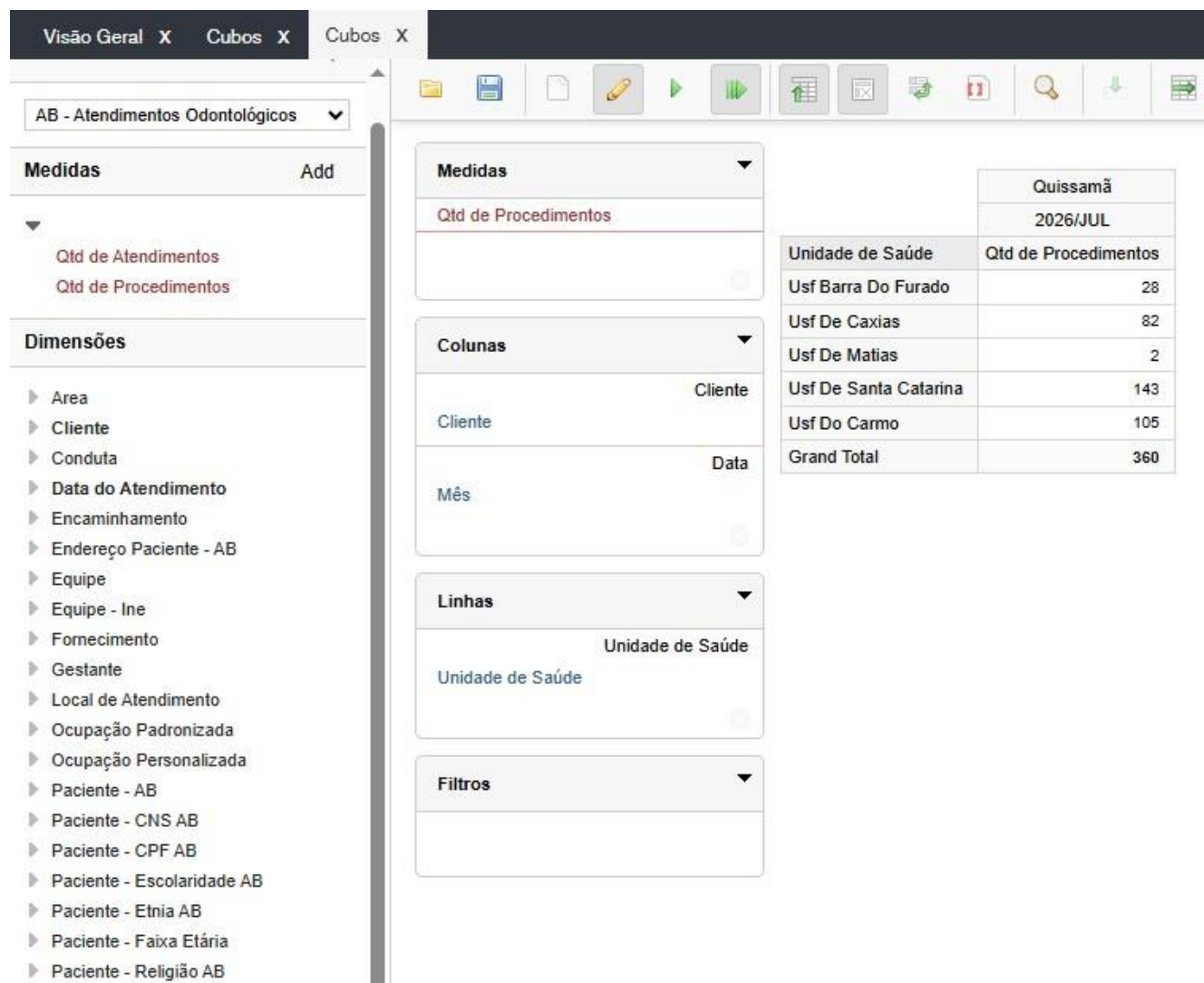


Figura 39- Número de Procedimentos odontológicos no sistema de Atenção Básica. Fonte: B.I - Data de extração: 10/08/2026

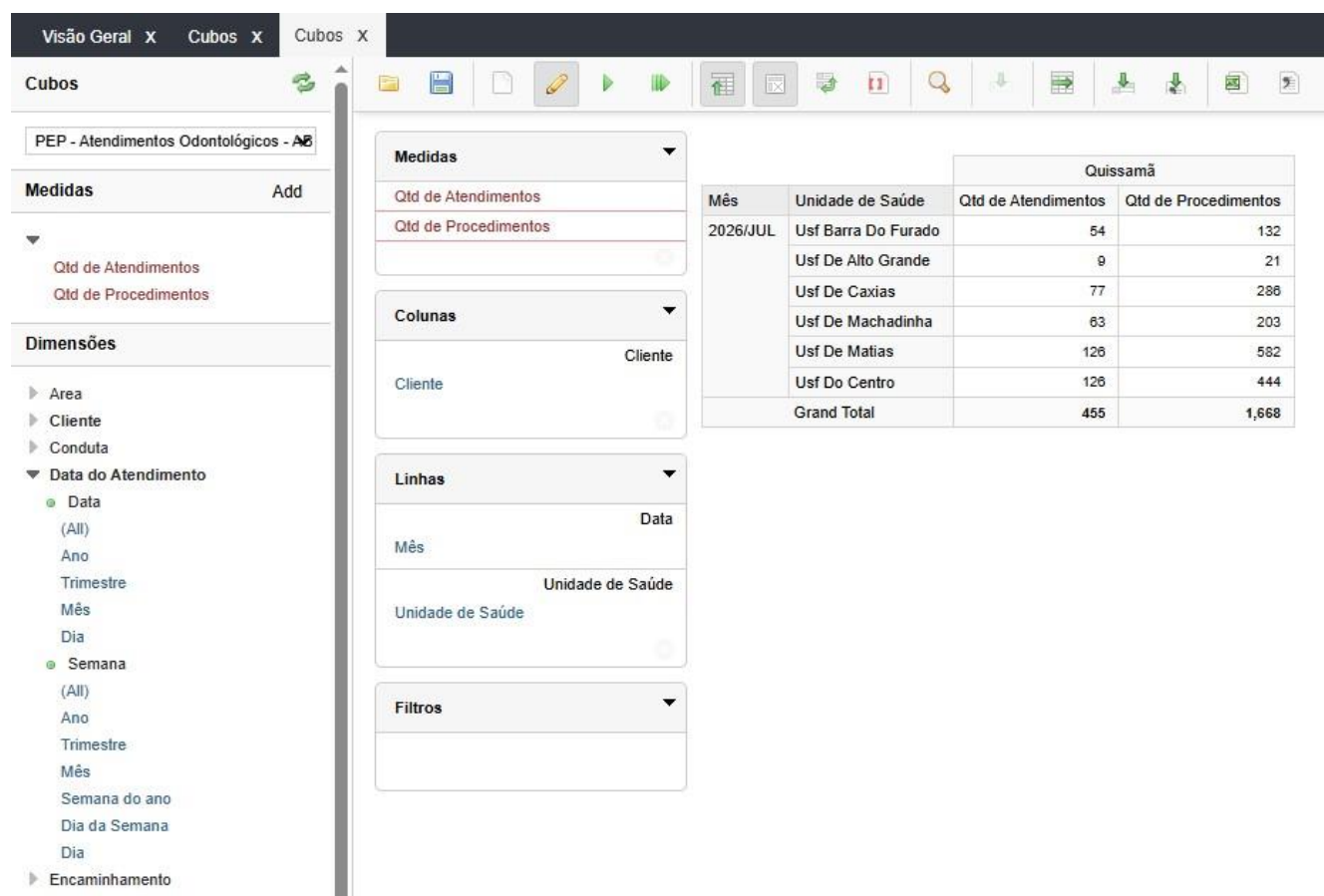


Figura 40- Número de Procedimentos odontológicos no sistema de prontuário eletrônico. Fonte: B.I - Data da Extração: 10/08/2026

8. Contrato de Gestão 196/2024 - Cordeiro

Contrato de Gestão 196/2024 - Cordeiro	
Atendimento de emergência	4.482
Atendimento Ambulatorial	153

Hospital de Cordeiro**Atendimentos por Ocupação Julho 2026****Unidade de Saúde:** HOSPITAL DE CORDEIRO

Ocupação	Classificados	Não Classificados	Total
Médico Clínico	3.844	638	4.482
Total	3.844	638	4.482

*Figura 41- quantidade de atendimentos realizados na emergência. Fonte: B.I - Data da Extração:10/08/2026***Atendimento Ambulatorial**

ATENDIMENTO AMBULATORIAL	
PEDIATRA	23
ORTOPEDISTA	58
VASCULAR	15
OBSTETRA	15
CIRURGIÃO GERAL	42
TOTAL	153

*Figura 42- quantidade consultas realizados por ocupação. Fonte: documento enviado por e-mail - Data da Extração:21/08/2026***9. Contrato de Gestão 005/2025 - Saquarema Ambulatorial**

Contrato de Gestão 005/2025 - Saquarema Ambulatorial	
Policlínica	6.430
Central de Marcação	19.533
Casa do Diabético	858
Centro Especializado em Reabilitação	3.624
Clínica Municipal de Fisioterapia Luiz Claudio Silva de Carvalho	12.069
Clínica da Mulher	3.144
Clínica da Criança	3.067
Clínica do Homem	935
Clínica do Idoso	2.238

Policlínica

CONSULTAS AMBULATORIAIS - POLICLÍNICA - JULHO	
ESPECIALIDADES	Nº CONSULTAS
Assistente Social	45
Médico Nefrologista	180
Médico Hematologista	54
Médico Alergista E Imunologista	128
Médico Cardiologista	452
Médico Cirurgião Geral	119
Médico Clínico	939
Médico Dermatologista	377
Médico Endocrinologista E Metabologista	512
Médico Gastroenterologista	417
Médico Neurologista	431
Médico Ortopedista E Traumatologista	792
Médico Otorrinolaringologista	288
Médico Perito	39
Médico Pneumologista	93
Médico Proctologista	166
Médico Psiquiatra	0
Médico Reumatologista	211
Médico Urologista	47
Tec. Gesso	59
Fonoaudiologia	0
Nutricionista	130
Neuropsicólogo	0
Psicólogo Clínico	0
Risco Cirúrgico	314
Consulta de Enfermagem	637
Psicólogo Clínico Tele	0

Figura 43 - Quantidade de consultas efetivadas por CBO. Fonte: Planilha de estatística mensal - Data da Extração: 07/08/2026



Central de Marcação

CENTRAL DE MARCAÇÃO	
STATUS	QUANTIDADE
Não Atendeu a Ligação	126
Exames Agendados	11
Consultas	19.342
Caixa Postal	23
Desistiu do Exame	12
Paciente foi a Óbito	0
Já Realizou o Exame	19
TOTAL	19.533

Figura 44- Relatório de Produção da unidade - fonte: Envio por e-mail - Data da extração 06/08/2026

Casa do Diabético

CASA DO DIABÉTICO	
Designação	Quantidade realizada
Assistente Social	80
Enfermeiro	116
Médico Cardiologista	70
Médico Em Cirurgia Vascular	47
Médico Endocrinologista E Metabologista	274
Médico Neurologista	53
Médico Ortopedista E Traumatologista	77
Nutricionista	40
Podólogo	88
Psicólogo Clínico	13
TOTAL	858

Figura 45- Quantidade de consultas efetivadas por CBO. Fonte B.I - data da Extração: 13/08/2026



Centro Especializado em Reabilitação

CENTRAL DE REABILITAÇÃO

No mês de julho de 2026 tivemos 654 pacientes ativos, uma produção de 3.624, como segue a planilha a baixo:

CODIGO	FISIOTERAPIA DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	403
301070067	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO EM REABILITAÇÃO NAS MULTIPLAS DEFICIÊNCIAS	170
302060014	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	92
301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	87
302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	73
302060030	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DESORDENS DO DESENVOLVIMENTO NEURO MOTOR	85
301070121	TRATAMENTO INTENSIVO DE PACIENTE EM REABILITAÇÃO FÍSICA (1 TURNO PACIENTE- DIA - 20 ATENDIMENTOS-MÊS)	51
301070296	ESTIMULAÇÃO PRECOCE RELACIONADA AO NEURODESENVOLVIMENTO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	42
211030040	AVALIAÇÃO DE FUNÇÃO E MECÂNICA RESPIRATÓRIA	9
	NUTRIÇÃO	
301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO)	25
101040024	AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA	25
301040087	ATENDIMENTO EM GRUPO NA ATENÇÃO BÁSICA	23
101050062	SESSÃO DE ARTETERAPIA	2
301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	73
	FONOAUDIOLOGIA	
301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	341
301070113	TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	150
301070075	ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	31
301050155	ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TERAPIA NUTRICIONAL	12
301070296	ESTIMULAÇÃO PRECOCE RELACIONADO A NEURODESENVOLVIMENTO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	16
030170024	ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA	1
	PEDIATRIA	
301070072	CONSULTA MEDICA NA ATENCÇÃO ESPECIALIZADA	151
	NEUROLOGIA	
301070072	CONSULTA MEDICA NA ATENCÇÃO ESPECIALIZADA	110
	PSIQUIATRIA INFANTIL	
301010072	CONSULTA MÉDICA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	151
	EDUCAÇÃO FÍSICA	
301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	219
101010036	PRÁTICA CORPORAL / ATIVIDADE FÍSICA EM GRUPO	175



PSICOLOGO CLINICO		
301040044	TERAPIA INDIVIDUAL	249
301040036	TERAPIA EM GRUPO	14
101010028	ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	5
301080178	ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM PSICOTERAPIA	75
301070091	ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPÊUTICA II PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (POR OFICINA)	5
301070296	ESTIMULAÇÃO PRECOCE RELACIONADA AO NEURODESENVOLVIMENTO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	11
301040079	ESCUA INICIAL / ORIENTAÇÃO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONT NEA)	5
301080160	ATENDIMENTO EM PSICOTERAPIA DE GRUPO	2
301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	619
ASSISTENTE SOCIAL		
301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	45
301050147	VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	1
MASSOTERAPEUTA		
309050057	SESSÃO DE MASSOTERAPIA	63
ENFERMAGEM		
301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	13
TOTAL		3624

Nº de Pacientes em PTS	Nº de usuários ativos
654	654


Anne Muniz Pinho
Coord. Administrativa
Mat.: 971

Figura 46- Relatório de Produção da unidade - fonte: e-mail - Data da extração 14/08/2026

Clínica Municipal de Fisioterapia Luiz Claudio Silva de Carvalho

Siglap	2026/JUL
	Saquarema
	Clinica Munic De Fisioterapia Luiz Claudio Silva De Carvalho
	Qtd de Procedimentos
AVALIACAO CINEMATICA E DE PARAMETROS LINEARES	9
AVALIACAO CINÉTICA, CINEMÁTICA E DE PARÂMETROS LINEARES	85
AVALIAÇÃO FUNCIONAL MUSCULAR	21
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NAATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO)	6
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NAATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	756
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	1.150
ATENDIMENTO FISIOTERAPÉUTICO EM PACIENTE ONCOLÓGICO CLÍNICO	9
ATENDIMENTO FISIOTERAPÉUTICO EM PACIENTE NO PRÉ E PÓS CIRURGIA ONCOLÓGICA	1
ATENDIMENTO FISIOTERAPÉUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	2
ATENDIMENTO FISIOTERAPÉUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	4
ATENDIMENTO FISIOTERAPÉUTICO NAS DISFUNÇÕES VASCULARES PERIFÉRICAS	1
ATENDIMENTO FISIOTERAPÉUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	2.314
ATENDIMENTO FISIOTERAPÉUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	5.013
ATENDIMENTO FISIOTERAPÉUTICO EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	154
SESSAO DE ACUPUNTURA APLICACAO DE VENTOSAS / MOXA	25
SESSAO DE ACUPUNTURA COM INSERCAO DE AGULHAS	33
SESSÃO DE ELETROESTIMULAÇÃO	2.077
SESSÃO DE MASSOTERAPIA	383
SESSÃO DE TRATAMENTO QUIROPRÁTICO	26
Grand Total	12.069

Figura 47 - Procedimentos realizados da Unidade. Fonte B.I - Data da Extração: 13/08/2026

Clínica da Mulher

Cliente	Ocupacao	2026/JUL		
		Clinica Da Mulher		
		Qtd de Consultas Disponibilizadas	Qtd de Consultas Agendadas	Qtd de Consultas Efetivadas
Saquarema	Assistente Social	94	74	73
	Cirurgião Dentista - Clínico Geral	277	164	110
	Enfermeiro	374	351	140
	Fisioterapeuta Geral	253	255	164
	Médico Cardiologista	163	163	121
	Médico Dermatologista	165	164	118
	Médico Endocrinologista E Metabologista	188	162	130
	Médico Ginecologista E Obstetra	1.143	1.104	847
	Médico Mastologista	270	219	187
	Nutricionista	271	204	131
	Psicólogo Clínico	271	236	147
	Técnico De Enfermagem	371	263	249
	Grand Total	3,840	3,359	2,417

Figura 48- Quantidade de consultas efetivadas no periodo. Fonte: B.I - Data da extração: 13/08/2026



		Saquarema
		Clinica Da Mulher
		2026/JUL
Setor	Procedimento Alternativo	Qtd de Exames Efetivados
MAMOGRAFIA	MAMOGRAFIA	22
ULTRASSONOGRAFIA	ULTRASSONOGRAFIA	1
	ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	1
	ULTRASSONOGRAFIA DE TRANSLUCENCIA NUCAL	52
	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO	5
	ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL	2
	ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA	77
	ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	200
	ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER	80
	ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)	3
	ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	175
	VIAS URINARIAS	4
LABORATORIO TELE DIAGNOSTICO MEDICINA DIAGNOSTICA	EXAMES LABORATORIAIS	87
CARDIOTOCOGRAFIA ANTEPARTO	TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO	12
ELETROCARDIOGRAMA	ELETROCARDIOGRAMA	6
Grand Total		727

Figura 49 - Quantidade de exames efetivados no período. Fonte: B.I - Data da extração: 13/08/2026

Clínica da Criança

CLÍNICA DA CRIANÇA	
Consulta de especialidades médicas	PRODUÇÃO
Pediatra	993
Pneumologista	77
Gastroenterologista	45
Neuropediatra	157
Ortopedia	15
Psiquiatra	210
Otorrinolaringologista	60
Nefrologista	47
Endocrinologista e Metabologista	51
Consulta de nível superior	PRODUÇÃO
Terapeuta Ocupacional	88
Fisioterapia	180
Fonoaudiologia	358
Nutricionista	80
Psicólogo Clínico	517
Cirurgião Dentista - Clínico Geral	108
Assistente Social	0
Consulta de nível superior	PRODUÇÃO
Coleta de exames laboratoriais	81

Figura 50 - Quantidade de consultas realizadas por ocupação: Fonte B.I - Data da Extração: 13/08/2026

Clínica do Homem

Ocupação	Disponibilizadas	Agendadas	Efetivadas
ASSISTENTE SOCIAL	133	96	96
ENFERMEIRO	275	143	89
MÉDICO UROLOGISTA	693	632	473
NUTRICIONISTA	144	62	40
PSICÓLOGO CLÍNICO	289	184	86

Figura 51 - Produtividade de Consultas (disponibilizados, Agendados e Efetivados) - Fonte: ESUS - Data da extração: 07/08/2026

Setor	Disponibilizados	Agendados	Efetivados
BIOPSIA	20	12	9
ELETROCARDIOGRAMA	180	2	0
LABORATÓRIO TELE DIAGNÓSTICO MEDICINA DIAGNÓSTICA	72	30	30
ULTRASSONOGRAFIA	240	152	109

Figura 52 - Quantidade de exames efetivados no período. Fonte: B.I - Data da extração: 07/08/2026

Ocupação	Disponibilizadas	Agendadas	Efetivadas	Não Efetivadas	Aguardando
MÉDICO UROLOGISTA	16	6	3	3	0

Figura 53 - Quantidade de Exames de Cistoscopia Efetivados – Clínica Do Homem – Fonte: ESUS. – Data da Extração: 14/08/2026

Clínica do Idoso

Saquarema			
2026/JUL			
Clínica Do Idoso			
Ocupacao	Qtd de Consultas Disponibilizadas	Qtd de Consultas Agendadas	Qtd de Consultas Efetivadas
Nutricionista	252	207	120
Médico Geriatria	542	441	382
Fisioterapeuta Geral	248	147	122
Médico Cardiologista	379	318	147
Assistente Social	444	286	280
Médico Ortopedista E Traumatologista	285	243	201
Médico Neurologista	251	241	179
Médico Reumatologista	153	123	102
Enfermeiro	263	125	95
Profissional De Educação Física Na Saúde	745	485	472
Psicólogo Clínico	329	234	178
Grand Total	3,891	2,850	2,238

Figura 54- Quantidade de consultas agendadas e efetivadas por ocupação. Fonte: B.I - Data da extração: 07/08/2026

10. Contrato de Gestão 006/2025 - Saquarema Atenção Primária

Contrato de Gestão 006/2025 - Saquarema Atenção Primária	
Atenção Básica (ESF) e Saúde Bucal (ESB)	23.295
Melhor em Casa (SAD)	993
E-Multi (Nasf)	984
Remédio em Casa	7.302
Odontoclínica Dr. Drude	810
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	3.580
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) - Verde Vale	7.180
Centro de Atenção Psicossocial	13.880

Atenção Básica e ESF

Atendimento médico

		Saquarema	
		2026/JUL	
Unidade de Saúde	Equipe	Médico Da Estratégia De Saúde Da Família	Médico Generalista
		Qtd de SOAP	Qtd de SOAP
Esf Bacaxá	NÃO INFORMADO	189	
	330550 008 BACAXA	277	
Esf Barra Nova	ESB DA ESF BARRA NOVA	1	
	330550 001 BARRA NOVA	447	
Esf Barreira	NÃO INFORMADO	136	
	330550 008 BARREIRA	350	
Esf Bicuiba	ESB DA ESF BICUIBA	2	
	330550 201 BICUIBA	503	
Esf Bonsucesso	330550 006 BONSUCESSO	401	
Esf Boqueirao Anercina Theodora Das Dores	NÃO INFORMADO	72	
	VIRGÍLIO SERRANO	251	
	GETÚLIO VARGAS	328	
	PRAIA DE BOQUEIRÃO	339	
	CASTELO BRANCO	268	
Esf Guarani	GUARANI	327	
	ESB GUARANI	1	
Esf Jaconé	NÃO INFORMADO	5	
	330550 008 TATUÍS	540	
	EQUIPE SAMBAQUIS	591	
Esf Jardim Ipitangas	330550 017 JARDIM IPITANGAS	573	
Esf Madressilva	EQ. SAUDE DA FAM. MADRESSILVA	308	
Esf Mombaca	NÃO INFORMADO	233	
	330550 101 MOMBACA	188	
Esf Palmital	330550 202 PALMITAL	308	
Esf Rio De Areia	NÃO INFORMADO	280	
	330550 005 RIO DE AREIA	52	
Esf Rio Mole	330550 004 RIO MOLE	195	143
	ESB DA ESF RIO MOLE	1	
Esf Rio Seco	330550 002 RIO SECO	384	
Esf Sampaio Correa	NÃO INFORMADO	129	
	330550 003 SAMPAIO CORREA	411	
Esf Saquarema	330550 008 SAQUAREMA	420	
Esf Serra Do Mato Grosso	SAUDE DA FAMILIA SERRA DO M.G.	378	
Esf Vilatur	330550 102 VILATUR	507	
Esf Água Branca	NÃO INFORMADO	36	
	330550 007 ÁGUA BRANCA	388	
	ESB DA ESF AGUA BRANCA	1	
Posto De Saude De Engenho Grande	NÃO INFORMADO	210	
	330550 005 ENGENHO GRANDE	101	
Grand Total		10,105	143

Figura 55 - Quantidade de SOAP por Unidade de Saúde e Equipe – Atendimento Médico (ESF) – Fonte: B.I. – Data da Extração: 13/08/2026

Atendimento de enfermagem



		Saquarema
		2026/JUL
		Enfermeiro Da Estratégia De Saúde Da Família
Unidade de Saúde	Equipe	Qtd de SOAP
Esf Bacaxá	NÃO INFORMADO	1
	330550 008 BACAXA	479
Esf Barra Nova	330550 001 BARRA NOVA	282
Esf Barreira	ESB DA ESF BARREIRA	1
	330550 008 BARREIRA	316
Esf Bicuiba	330550 201 BICUIBA	100
Esf Bonsucesso	330550 006 BONSUCESSO	113
Esf Boqueirao Anercina Theodora Das Dores	NÃO INFORMADO	25
	VIRGÍLIO SERRANO	79
	GETÚLIO VARGAS	62
	PRAIA DE BOQUEIRÃO	83
	CASTELO BRANCO	121
Esf Guarani	GUARANI	118
	ESB GUARANI	1
Esf Jaconé	NÃO INFORMADO	103
	330550 008 TATUÍS	1
	EQUIPE SAMBAQUIS	168
Esf Jardim Ipitangas	330550 017 JARDIM IPITANGAS	314
Esf Madressilva	EQ. SAUDE DA FAM. MADRESSILVA	335
	EQ. DE SAUDE BUCAL MADRESSILVA	1
Esf Mombaca	330550 101 MOMBACA	184
Esf Palmital	330550 202 PALMITAL	264
Esf Rio De Areia	NÃO INFORMADO	428
	330550 005 RIO DE AREIA	10
Esf Rio Mole	330550 004 RIO MOLE	375
	ESB DA ESF RIO MOLE	37
Esf Rio Seco	330550 002 RIO SECO	324
Esf Sampaio Correa	NÃO INFORMADO	85
	330550 003 SAMPAIO CORREA	306
Esf Saquarema	330550 008 SAQUAREMA	244
Esf Serra Do Mato Grosso	SAUDE DA FAMILIA SERRA DO M.G.	242
Esf Vilatur	NÃO INFORMADO	120
	330550 102 VILATUR	62
Esf Água Branca	NÃO INFORMADO	206
	330550 007 ÁGUA BRANCA	332
Posto De Saude De Engenho Grande	330550 005 ENGENHO GRANDE	266
	Grand Total	6,188

Figura 56- Quantidade de consultas realizadas pelo enfermeiro da estratégia de saúde no prontuário eletrônico - Fonte: B.I - Data da extração: 14/08/2026

Atendimento odontológico

		Saquarema
		2026/JUL
Unidade de Saúde	Equipe	Qtd de Atendimentos
Esf Bacaxá	NÃO INFORMADO	301
Esf Barra Nova	ESB DA ESF BARRA NOVA	319
	330550 001 BARRA NOVA	2
Esf Barreira	NÃO INFORMADO	1
	ESB DA ESF BARREIRA	242
	330550 008 BARREIRA	8
Esf Bicuiba	ESB DA ESF BICUIBA	333
	330550 201 BICUIBA	55
Esf Bonsucesso	NÃO INFORMADO	169
	ESB DA ESF BONSUCESSO	205
	330550 006 BONSUCESSO	14
Esf Boqueirao Anercina Theodora Das Dores	NÃO INFORMADO	51
	GETÚLIO VARGAS	3
	CASTELO BRANCO	2
	ESB VIRGILIO SERRANO	11
	ESB PRAIA DO BOQUEIRÃO	237
	ESB GETULIO VARGAS	284
Esf Guarani	GUARANI	1
	ESB GUARANI	219
Esf Jaconé	NÃO INFORMADO	417
	330550 008 TATUÍS	2
	ESB DE TATUÍS	50
	EQUIPE SAMBAQUIS	15
Esf Jardim Ipitangas	ESB DA ESF JARDIM IPITANGAS	40
	330550 017 JARDIM IPITANGAS	7
Esf Madressilva	NÃO INFORMADO	2
	EQ. SAUDE DA FAM. MADRESSILVA	53
	EQ. DE SAUDE BUCAL MADRESSILVA	264
Esf Mombaca	ESB DA ESF MOMBACA	309
Esf Palmital	ESB DA ESF PALMITAL	307
Esf Rio De Areia	ESB DA ESF RIO D AREIA	418
Esf Rio Mole	ESB DA ESF RIO MOLE	330
Esf Rio Seco	330550 002 RIO SECO	1
	ESB DA ESF RIO SECO	366
Esf Sampaio Correa	NÃO INFORMADO	142
	330550 003 SAMPAIO CORREA	4
	ESB DA ESF SAMPAIO CORREA	155
Esf Saquarema	EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	335
Esf Serra Do Mato Grosso	SAUDE DA FAMILIA SERRA DO M.G.	10
	BUCAL SERRA DO MATO GROSSO	247
Esf Vilatur	ESB DA ESF VILATUR	328
Esf Água Branca	NÃO INFORMADO	7
	ESB DA ESF AGUA BRANCA	304
Grand Total		6,859

Figura 57- Quantidade de Atendimentos por Unidade de Saúde e Equipe – Atendimento Odontológico - Fonte: B.I - Data da extração: 13/08/2026

Melhor em Casa

Saquarema	
2026/JUL	
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE AT. DOMICILIAR TIPO II	
Ocupação	Qtd de Atendimentos
MÉDICO CARDIOLOGISTA/MÉDICO CLÍNICO	33
NUTRICIONISTA	18
MÉDICO CLÍNICO /MÉDICO DO TRABALHO	33
ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	70
NUTRICIONISTA /TÉCNICO EM AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	42
ENFERMEIRO /ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	24
TÉCNICO DE ENFERMAGEM /TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1
FISIOTERAPEUTA GERAL	303
MÉDICO CLÍNICO	48
MÉDICO CLÍNICO /MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	40
PSICÓLOGO CLÍNICO	71
ASSISTENTE SOCIAL	54
ENFERMEIRO	255
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1
Grand Total	993

Figura 58 - Quantidade de atendimentos no prontuário eletrônico por ocupação. Fonte B.I - Data da Extração: 17/08/2026

E-Multi (NASF) Atendimento Individual - Sistema AB

Saquarema		
Mês do Atendimento Individual	Equipe	Ocupacao
2026/JUL	EMULTI-AMPLIADA SAQUAREMA	Assistente Social
		Fisioterapeuta Geral
		Fonoaudiólogo Geral
		Nutricionista
	EMULTI- ESTRATEGICA SAQUAREMA	Fisioterapeuta Geral
		Nutricionista
		Profissional De Educação Física Na Saúde
		Grand Total
		448

Figura 59 - Quantidade de atendimentos no sistema de atenção básica por ocupação. Fonte: B.I - Data da Extração: 17/08/2026

Atendimento Individual - Sistema PEP

Medidas			Saquarema	
Qtd de SOAP			Mês	Qtd de SOAP
			2026/JUL	
			EMULTI- ESTRATEGICA SAQUAREMA	
			Fisioterapeuta Geral	12
			Nutricionista	52
			Psicólogo Clínico	76
			EMULTI-AMPLIADA SAQUAREMA	
			Assistente Social	18
			Fisioterapeuta Geral	57
			Fonoaudiólogo Geral	30
			Médico Psiquiatra	29
			Nutricionista	168
			Psicólogo Clínico	94
			Grand Total	536

Figura 60 - Quantidade de atendimentos no prontuário eletrônico por ocupação. Fonte: B.I - Data da Extração: 17/08/2026



Remédio em Casa

2.2 Quantitativos De Pacientes Cadastrados No Programa

UNIDADES	PACIENTES
ESF ENGENHO	144
ESF BICUÍBA	239
ESF ÁGUA BRANCA	472
ESF MOMBAÇA	481
ESF SAMPAIO	598
ESF SAQUAREMA	226
ESF JACONÉ	720
ESF JARDIM IPITANGAS	515
ESF BONSUCESSO	403
ESF BARRA NOVA	40
ESF RIO MOLE	206
ESF RIO SECO	226
ESF RIO D' AREIA	512
ESF BARREIRA	452
ESF PALMITAL	514
ESF BACAXÁ	350
ESF VILATUR	539
ESF SERRA DO MATO GROSSO	149
ESF MADRESSILVA	290
ESF GUARANI	9
ESF BOQUEIRÃO	217
TOTAL:	7.302

Figura 61- Relatório de produção de cadastros por unidade. Fonte: relatório enviado por e-mail - Data da Extração: 06/08/2026

Odontoclínica Dr. Drude

Medidas		Saquarema
Qtd de Consultas Efetivadas		Cirurgião Dentista - Clínico Geral
	Mês	Unidade de Saúde
	2026/JUL	Odontoclínica Dr. Drude
		Qtd de Consultas Efetivadas
		810

Figura 62 - Quantidade de consultas disponibilizadas, agendadas e efetivadas. Fonte: B.I - Data da Extração: 11/08/2026

Centro de Especialidades Odontológicas – CEO

PRODUTIVIDADE - JULHO		
ESPECIALIDADE	PROCEDIMENTOS	CONSULTAS
CIRURGIA	0	131
ENDODONTIA	441	124
ESTOMATOLOGIA	25	46
PERIODONTIA	1.779	84
PNE	550	400
TOTAL	2.795	785

Figura 63- Quantidade de atendimentos e procedimentos realizados. Fonte: relatório enviado por e-mail - Data da extração: 11/08/2026

Centro de Especialidades Odontológicas – CEO Verde Vale

PRODUTIVIDADE - JULHO		
ESPECIALIDADE	PROCEDIMENTOS	CONSULTAS
CIRURGIA	558	253
ENDODONTIA	997	200
DTM	157	89
PERIODONTIA	2.329	125
PNE	2.132	340
TOTAL	6.173	1.007

Figura 64- Quantidade de atendimentos e procedimentos realizados. Fonte: relatório enviado por e-mail - Data da extração: 11/08/2026

**Centro de Atenção Psicossocial
CAPS AD**

Consolidado Geral:

DESCRIÇÃO	QUANT.
Atendimento Individual (Superior, Médio e Técnico)	1.580
Atendimento em grupo	5.446
Número de pacientes em PTS	233
Número de famílias	121
Número de pacientes ativos	233

Figura 65- Quantidade de atendimentos individuais, participantes em grupos, número de pacientes com projeto terapêutico, número de famílias atendidas e número de pacientes ativos. Fonte: relatório enviado por e-mail - data da extração: 10/08/2026

Total de atendimentos individuais e grupos:

Nome	Função	Quantitativo individual	Quantitativo em grupo	Total
Maria Letícia M. R. Cardoso	Médica Psiquiatra	233	67	300
Omar Sayar de Castro	Médico Clínico	43	104	147
Liamara Martins Gonçalves	Psicóloga	60	245	305
Marcos Aurélio M. Oliveira	Psicólogo	106	526	632
Natália Fagundes Goularte	Psicóloga	208	575	783
Nathany da Silva Machado	Psicóloga	61	361	422
Aline Silveira Lemos	Assistente Social	-	-	-
Natália da Silva Costa Jesus	Assistente Social	Licença	maternidade	
Tatiane Bezerra da Silva	Assistente Social	30	380	410
Camila Ribeiro Xavier	Farmacêutica	95	6	101
Ana Lúcia Oliveira de Castro	Enfermeira	52	120	172
Thayla Macedo dos Santos	Enfermeira	47	547	594
Luana Joana C. Furtado	Téc. de enfermagem	198	814	1.012
Priscila de Souza Antunes	Téc. de enfermagem	100	788	888
Viviane Cabral	Téc. de Enfermagem	85	363	448
Priscila da Costa Santos	Oficineira	250	450	700
Ramona da Costa	Oficineira	12	100	112
TOTAL		1.580	5.446	7.026

Figura 66- Quantidade de atendimentos individuais, participantes em grupos, número de pacientes com projeto terapêutico, número de famílias atendidas e número de pacientes ativos separados por ocupação. Fonte: relatório enviado por e-mail - data da extração: 10/08/2026



CAPS II

Consolidado Geral:

DESCRIÇÃO	QUANT.
Atendimento Individual (superior mais médio)	2.507
Atendimento em grupo	4.347
Número de pacientes em PTS	887
Número de família	627
Número de pacientes ativos	1.042

Figura 67- Quantidade de atendimentos individuais, participantes em grupos, número de pacientes com projeto terapêutico, número de famílias atendidas e número de pacientes ativos. Fonte: relatório enviado por e-mail - data da extração: 11/08/2026



Total de atendimentos individuais:

Nome	Função	Quant. individual
Cecília Verônica de Matos Feitosa	Médica Psiquiatra	333
Priscila Brasil	Médica Psiquiatra	301
Hayanny Veiga Bastos	Psicóloga	181
Suelen Santana dos Santos	Psicóloga	31
Diego Nunes Marinho	Psicólogo	0
Camila dos Santos Coutinho Soares	Assistente Social	-
Mariana Marques da Costa	Assistente Social	20
Miryan Paulucci Luna	Assistente Social	84
Daliana de Melo Penetra	Farmacêutica	471
Raíssa Castro da Silva	Farmacêutica	464
Nadja Carneiro do Nascimento	Enfermeira	43
Roberta Ferreira Baeta	Enfermeira	56
Alan Tourino Soares	Técnico de Enfermagem	25
Cleide Maria da Conceição de Freitas	Téc. de Enfermagem	90
Érica Cristina Souza Azevedo	Téc. de Enfermagem	178
Acompanhante T. Daniela	Acompanhante Terapêutica	61
Geovana de Souza Nunes	Acompanhante Terapêutica	71
Marla Cricia dos Santos	Oficineira	32
Sidilene Oliveira Teixeira Lessa	Oficineira	36
Alanderson Macedo da Silva	Oficineiro	6
Peterson Ferreira de Oliveira	Oficineiro	0
Andressa do Nascimento Mota	Educador Físico	24
TOTAL		2.507

Figura 68 - Quantidade de atendimentos individuais, participantes em grupos, número de pacientes com projeto terapêutico, número de famílias atendidas e número de pacientes ativos separados por ocupação. Fonte: relatório enviado por e-mail - data da extração: 11/08/2026



Total de atendimentos em grupo:

Nome	Função	Quant. individual
Cecília Verônica de Matos Feitosa	Médica Psiquiatra	-
Priscila Brasil	Médica Psiquiatra	-
Hayanny Veiga Bastos	Psicóloga	150
Suelen Santana dos Santos	Psicóloga	50
Diego Nunes Marinho	Psicólogo	-
Camila dos Santos Coutinho Soares	Assistente Social	-
Mariana Marques da Costa	Assistente Social	91
Miryan Paulucci Luna	Assistente Social	37
Daliana de Melo Penetra	Farmacêutica	-
Raíssa Castro da Silva	Farmacêutica	-
Nadja Carneiro do Nascimento	Enfermeira	139
Roberta Ferreira Baeta	Enfermeira	47
Alan Taurino Soares	Téc. de Enfermagem	96
Cleide Maria da Conceição de Freitas	Téc. de Enfermagem	236
Érica Cristina Souza Azevedo	Téc. de Enfermagem	215
Daniela Paulino	Acompanhante Terapêutica	865
Geovana de Souza Nunes	Acompanhante Terapêutica	866
Marla Cricia dos Santos	Oficineira	345
Sidilene Oliveira Teixeira Lessa	Oficineira	257
Alanderson Macedo da Silva	Oficineiro	432
Peterson Ferreira de Oliveira	Oficineiro	96
Andressa do Nascimento Mota	Educadora Física	425
TOTAL:		4.347

Figura 69 - Quantidade de atendimentos individuais, participantes em grupos, número de pacientes com projeto terapêutico, número de famílias atendidas e número de pacientes ativos separados por ocupação. Fonte: relatório enviado por e-mail - data da extração: 11/08/2026

Documento assinado digitalmente
gov.br FABIO PINTO DA MATTA
Data: 02/09/2026 11:24:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fabio Pinto da Matta
Supervisor



Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência

Data:	07/07/2026
Contrato/Dispositivo:	Saquarema
Participantes:	Ricardo Mangabeira, Rogerio da Costa Azevedo, Carlos Magno, Fernanda Santos, Simone Vidal Evelyn Amorim
Atividades Gerenciais:	Grupo de trabalho com gestores das comissões hospitalares
Tipo de atividade:	Reunião presencial - instrução, planejamento e gestão

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Alinhamento metodológico e padronizado dos modelos de relatórios emitidos pelas Comissões Hospitalares, especificamente pela Comissão de Revisão de Prontuários, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Comissão de Revisão de Óbitos; garantindo maior consistência na apresentação das informações, fortalecimento da rastreabilidade das análises e conformidade com os requisitos legais, normativos

Inconformidades:

Análise Crítica dos Indicadores, Recomendações Técnicas, Não conformidades encontradas, Planos de ação corretiva e preventiva.

Apontamentos:

Fernanda Oliveira Santos : Identificação da comissão; Objetivo do relatório; Período de referência; Base de dados analisada; Indicadores monitorados; Resultados alcançados; Análise crítica dos indicadores; Não conformidades identificadas; Plano de ação corretivo e preventivo; Recomendações técnicas; Deliberações da comissão; Responsáveis pelas ações; Cronograma de acompanhamento; Assinaturas dos membros.

Prazo pactuado para alinhamento:

45 dias

Resultados desejados (melhorias):

Elaboração de um modelo institucional único para os relatórios das Comissões Hospitalares, mantendo as particularidades técnicas de cada comissão, porém utilizando estrutura documental padronizada que contemple, no mínimo os apontamentos realizados.



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**



www.primaqualitasaude.org

Travessa do Ouvidor, 21 - Sala 503
Centro - Rio de Janeiro/RJ - Cep: 20.040-040
Telefone: 21 20424250
CNPJ: 40.289.134/0001-99



Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência

Data:	09/07/2026
Contrato/Dispositivo:	Cachoeiras de Macacu - Hospital Municipal Dr Celso Martins
Participantes:	Marcia Abraão - Gerente de Contrato, Liliane Lessa - Direção de Enfermagem, Ricardo Mangabeira - Coord. Rede Cuidados - HUE, Rogerio da Costa Azevedo - Supervisor Rede de Cuidados -HUE.
Atividades Gerenciais:	Acompanhamento de Plano de Ação.
Tipo de atividade:	Reunião presencial - instrução, planejamento e gestão

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Reunião realizada com objetivo de acompanhamento do plano de ação elaborado com objetivo de melhoria da unidade, a visita foi conduzida por meio de inspeção visual in loco nos ambientes sinalizados na visita anterior, com checagem das ações corretivas propostas, e registro fotográfico observada no momento da visita.

Inconformidades:

Piso da DML dentro da lavanderia, o piso é cimentado, poroso, manchado, sem revestimento impermeável e resistente a produtos químicos e desinfetantes, manchas de umidade, bolor e infiltração visíveis na parede próxima ao tanque, sacos com roupa limpa/processada, dentro do mesmo ambiente onde ficam vassouras, rodos, baldes e produtos químicos de limpeza; caixas de perfurocortante dispostas diretamente no chão, as mesmas devem permanecer sobre superfície plana, nunca diretamente em contato com piso úmido ou em local sujeito a alagamento e não empilhada.

Apontamentos:

Marcia Abraão, Liliane Lessa - foi esclarecido os pontos críticos e os apontamentos do plano de ação.

Prazo pactuado para alinhamento:

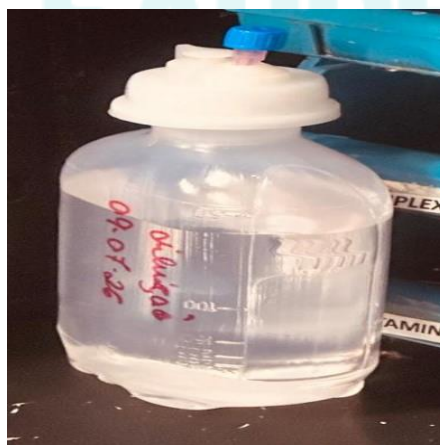
30 dias

Resultados desejados (melhorias):

Recomenda-se o cumprimento do plano de ação no prazo estabelecido, garantindo a implementação das correções sugeridas e a mitigação das causas das não conformidades identificadas.



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

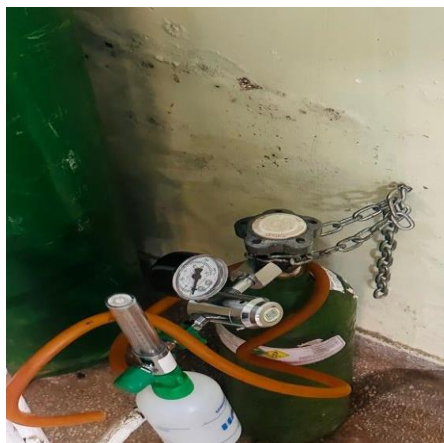


www.primaqualitasaude.org

Travessa do Ouvidor, 21 - Sala 503
Centro - Rio de Janeiro/RJ - Cep: 20.040-040
Telefone: 21 20424250
CNPJ: 40.289.134/0001-99



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**



www.primaqualitasaude.org

Travessa do Ouvidor, 21 - Sala 503
Centro - Rio de Janeiro/RJ - Cep: 20.040-040
Telefone: 21 20424250
CNPJ: 40.289.134/0001-99



Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência

Data: 27/07/2026

Contrato/Dispositivo: Hospital Municipal de Cordeiro

Participantes: Ricardo Mangabeira, Rogerio da Costa Azevedo, Dayanne de Souza, Camila Valadares

Atividades Gerenciais: Definição de nível e qualificação e classificação de gravidade de eventos adversos para notificação junto à NOTIVISA e incentivo da equipe para adesão à notificação; bem como discutidas as diretrizes para padronização das atas das comissões hospitalares, com o objetivo de garantir uniformidade de registro, rastreabilidade das decisões e facilidade das ações das comissões.

Tipo de atividade: Reunião presencial - instrução, planejamento e gestão, Visita técnica

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Durante a reunião, foram discutidas as diretrizes para padronização das atas das comissões hospitalares, com o objetivo de garantir uniformidade de registro, rastreabilidade das decisões e facilidade de ações. Quanto às notificações de eventos adversos, foi reforçada a importância do preenchimento tempestivo e da correta classificação de gravidade, assegurando o encaminhamento à área responsável dentro do prazo institucional a ser definido.

Inconformidades:

Processo avaliativo registrado nas atas. Observa-se, com frequência, a ausência de critérios objetivos e padronizados para a avaliação dos casos discutidos, o que resulta em registros subjetivos, incompletos ou pouco conclusivos. A falta de indicadores quantitativos, de metodologia explícita de análise e de referência a protocolos institucionais compromete a comparabilidade entre reuniões e dificulta a mensuração da efetividade das ações implementadas ao longo do tempo

Apontamentos:

Dayanne de Souza, Camila Valadares

Prazo pactuado para alinhamento:

30 dias

Resultados desejados (melhorias):



PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE

Padronização do modelo de ata: Rastreabilidade completa entre avaliação, deliberação, encaminhamento, execução das ações; comparabilidade histórica entre reuniões, permitindo análise de tendências ao longo do tempo; classificação padronizada de evitabilidade, permitindo identificar óbitos evitáveis de forma sistemática; maior conexão entre óbitos e eventos adversos previamente notificados, revelando causas-raiz recorrentes.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO

PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE

REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO (CROHMC)

As seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis na sala de reuniões do Hospital Municipal de Cordeiro a Reunião da CROHMC.

Esta reunião foi presidida pelo Dr. Alexander da Silva Pinto (Presidente – CROHMC).

O Presidente iniciou a reunião com a exposição dos dados do mês de abril como segue planilha abaixo:

MÊS	ÓBITOS TOTAIS	REVISADOS	%
ABRIL	06	06	100

MÊS	TOTAL DE SAÍDA	ÓBITOS IML	*ÓBITOS < 24H UNIDADE	*ÓBITO > 24H UNIDADE
ABRIL	121	2	04	02

As seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis às onze horas da manhã, reuniu-se, em sua sede, a Comissão de Revisão de Óbitos do Hospital Municipal de Cordeiro (CROHMC), para realização da reunião ordinária mensal. Participaram os seguintes membros: Dr. Alexander da Silva Pinto (Presidente), Katia Milene da Conceição Bon (Vice-Presidente) e Alexandra Silva Cavaleiro Freitas (Secretária). A pauta consistiu na análise epidemiológica e estatística dos óbitos ocorridos no mês de abril de dois mil e vinte e seis nesta unidade hospitalar. Foram registrados seis óbitos no período, sendo quatro indivíduos do sexo masculino e dois do sexo feminino. Dentre esses, duas Declarações de Óbito foram emitidas em domicílio (nº 37761240-5 e nº 37726544-6). Identificaram-se dois casos com causa morte indeterminada, devidamente encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para elucidação diagnóstica. Constatou-se, ainda, de Óbito, incluíram insuficiência respiratória aguda, sepse de foco pulmonar e infarto agudo do miocárdio. Nos casos encaminhados ao IML, a causa básica permaneceu indeterminada ou sob investigação. Como condições consequenciais e/ou comorbidades associadas foram identificadas hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, doença renal crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença cardíaca isquêmica, doença hepática crônica, doença neurológica, doença oncológica, doença infecciosa, doença autoimune, doença endócrina, doença hematológica, doença imunológica, doença metabólica, doença nutricional, doença psicológica, doença social, doença ambiental, doença ocupacional, doença relacionada à saúde, doença relacionada à atividade física, doença relacionada à alimentação, doença relacionada à atividade sexual, doença relacionada à atividade profissional, doença relacionada à atividade acadêmica, doença relacionada à atividade artística, doença relacionada à atividade esportiva, doença relacionada à atividade recreativa, doença relacionada à atividade cultural, doença relacionada à atividade religiosa, doença relacionada à atividade política, doença relacionada à atividade econômica, doença relacionada à atividade social, doença relacionada à atividade comunitária, doença relacionada à atividade voluntária, doença relacionada à atividade cidadã, doença relacionada à atividade cívica, doença relacionada à atividade política, doença relacionada à atividade econômica, doença relacionada à atividade social, doença relacionada à atividade comunitária, doença relacionada à atividade voluntária, doença relacionada à atividade cidadã, doença relacionada à atividade cívica.

Dr. Alexander da Silva Pinto
CRM-RJ 52.829-0
R.OF. 17075-0

Katia Milene da Conceição Bon
CRM-RJ 225.176-0
R.OF. 17075-0

Alexandra Silva Cavaleiro Freitas
CRM-RJ 152.829-0
R.OF. 17075-0

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO

PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (CCHI)

As cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis, às 10h (dez horas), no sede do Hospital Municipal de Cordeiro, realizou-se a 19ª Reunião Ordinária da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCHI), sob a presidência do Dr. Alexander da Silva Pinto.

Estiveram presentes os seguintes membros: Dr. Alexander da Silva Pinto – Presidente; a Enfermeira Katia Milene da Conceição Bon – Secretária; a Enfermeira Fabiola A. da Silva Zanon – 1ª Suplente; e a Técnica de Enfermagem Débora de Oliveira Ferreira – 2ª Suplente.

A Enf.ª Katia, informa que está detendo o cargo de Diretora da enfermagem e passando a sua responsabilidade técnica para Enf.ª Dayanne Abreu Muniz de Souza.

No ocasião, foram apresentados e discutidos os dados referentes ao mês de abril de 2026. Constatou-se, no período, um total de 121 (cento e vinte e um) altas hospitalares, cujos prontuários foram analisados em sua totalidade (100%). Dentre estes, 19 (dezenove) pacientes apresentaram patologias infecciosas, correspondendo a 16% do total.

Em comparação ao mês anterior, observou-se aumento no número de interações e de infecções registradas na unidade. Foram identificadas duas Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), a patologia de maior prevalência no período foi pneumonia representando 43%.

Dos 19 pacientes com patologias infecciosas, 06 (seis) eram do sexo feminino e 13 (treze) do sexo masculino.

Foram registrados 1 (um) óbito relacionado a patologias infecciosas, tendo como causa principal insuficiência renal aguda (IRA) e houveram 2 (duas) transfusões para causa infecciosa (CTI).

Os prontuários foram avaliados segundo os seguintes critérios: número do prontuário, inicial do paciente, data de internação, sexo, patologia apresentada, data de alta, data de óbito e antibióticos administrados, segue planilha em anexo.

Os principais antibióticos utilizados nos tratamentos foram: ceftriaxona, cefepime, clindamicina, amoxicilina, ampicilina, e Tazocin.

A vigilância da CCHI (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) tem como foco o controle do risco de infecção. Relações de Infecções Relacionadas à Saúde (IRAS), tais como pneumonia, infecção do trato urinário, infecção de corrente sanguínea e infecção pós-cirúrgica. Destaca-se também a importância da vigilância de eventos de notificação compulsória que requerem ações imediatas, como meningite, sarampo, rubéola e COVID-19.

Nada mais havendo a tratar, o Dr. Alexander da Silva Pinto encerra o reunião, solicitando aos presentes a assinatura da folha de presença para fins de registro. Para constar, eu, Enf.ª Katia Milene da Conceição Bon, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos demais membros presentes.

Dr. Alexander da Silva Pinto
CRM-RJ 52.829-0
R.OF. 17075-0

Katia Milene da Conceição Bon
CRM-RJ 225.176-0
R.OF. 17075-0

Fabiola A. da Silva Zanon
CRM-RJ 152.829-0
R.OF. 17075-0

Debora de Oliveira Ferreira
CRM-RJ 152.829-0
R.OF. 17075-0

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO

PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE

ATA DA 20ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - CCHI HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO (CCHI-HMC)

Cordeiro, 05 de maio de 2026, às 10:00hrs

Lista de Presença da CCHI-HMC

PRESENTES	FUNÇÃO	ASSINATURA
Dr. Alexander da Silva Pinto	Médico – Presidente	Dr. Alexander da Silva Pinto CRM-RJ 52.829-0 R.OF. 17075-0
Enf.ª Katia Milene da Conceição Bon	Secretária	Katia Milene da Conceição Bon CRM-RJ 225.176-0 R.OF. 17075-0
Julia Aparecida Vitorino de Souza	Farmacêutica - 1ª Suplente	Julia A. Vitorino de Souza CRM-RJ 152.829-0 R.OF. 17075-0
Enf.ª Fabiola A. da Silva Zanon	Enfermeira - 2ª Suplente	Fabiola A. da Silva Zanon CRM-RJ 152.829-0 R.OF. 17075-0
Débora de Oliveira Ferreira	Téc. de enfermagem - 3ª Suplente	Débora de Oliveira Ferreira CRM-RJ 152.829-0 R.OF. 17075-0

Dr. Alexander da Silva Pinto
CRM-RJ 52.829-0
R.OF. 17075-0

Julia A. Vitorino de Souza
CRM-RJ 152.829-0
R.OF. 17075-0

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO

PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE

REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORDEIRO (CROHMC)

As seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis na sala de reuniões do Hospital Municipal de Cordeiro a Reunião da CROHMC.

Esta reunião foi presidida pelo Dr. Alexander da Silva Pinto (Presidente – CROHMC).

O Presidente iniciou a reunião com a exposição dos dados do mês de abril como segue planilha abaixo:

MÊS	ÓBITOS TOTAIS	REVISADOS	%
ABRIL	06	06	100

MÊS	TOTAL DE SAÍDA	ÓBITOS IML	*ÓBITOS < 24H UNIDADE	*ÓBITO > 24H UNIDADE
ABRIL	121	2	04	02

As seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis às onze horas da manhã, reuniu-se, em sua sede, a Comissão de Revisão de Óbitos do Hospital Municipal de Cordeiro (CROHMC), para realização da reunião ordinária mensal. Participaram os seguintes membros: Dr. Alexander da Silva Pinto (Presidente), Katia Milene da Conceição Bon (Vice-Presidente) e Alexandra Silva Cavaleiro Freitas (Secretária). A pauta consistiu na análise epidemiológica e estatística dos óbitos ocorridos no mês de abril de dois mil e vinte e seis nesta unidade hospitalar. Foram registrados seis óbitos no período, sendo quatro indivíduos do sexo masculino e dois do sexo feminino. Dentre esses, duas Declarações de Óbito foram emitidas em domicílio (nº 37761240-5 e nº 37726544-6). Identificaram-se dois casos com causa morte indeterminada, devidamente encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para elucidação diagnóstica. Constatou-se, ainda, de Óbito, incluíram insuficiência respiratória aguda, sepse de foco pulmonar e infarto agudo do miocárdio. Nos casos encaminhados ao IML, a causa básica permaneceu indeterminada ou sob investigação. Como condições consequenciais e/ou comorbidades associadas foram identificadas hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, doença renal crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença cardíaca isquêmica, doença hepática crônica, doença neurológica, doença oncológica, doença imunológica, doença metabólica, doença nutricional, doença psicológica, doença social, doença ambiental, doença ocupacional, doença relacionada à saúde, doença relacionada à atividade física, doença relacionada à alimentação, doença relacionada à atividade sexual, doença relacionada à atividade profissional, doença relacionada à atividade acadêmica, doença relacionada à atividade artística, doença relacionada à atividade esportiva, doença relacionada à atividade recreativa, doença relacionada à atividade cultural, doença relacionada à atividade religiosa, doença relacionada à atividade política, doença relacionada à atividade econômica, doença relacionada à atividade social, doença relacionada à atividade comunitária, doença relacionada à atividade voluntária, doença relacionada à atividade cidadã, doença relacionada à atividade cívica.

Dr. Alexander da Silva Pinto
CRM-RJ 52.829-0
R.OF. 17075-0

Katia Milene da Conceição Bon
CRM-RJ 225.176-0
R.OF. 17075-0

Alexandra Silva Cavaleiro Freitas
CRM-RJ 152.829-0
R.OF. 17075-0

Debora de Oliveira Ferreira
CRM-RJ 152.829-0
R.OF. 17075-0



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

www.primaqualitasaude.org

Travessa do Ouvidor, 21 - Sala 503
Centro - Rio de Janeiro/RJ - Cep: 20.040-040
Telefone: 21 20424250
CNPJ: 40.289.134/0001-99



Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência

Data: 28/07/2026
Contrato/Dispositivo: Hospital Municipal Porphírio Nunes - Saquarema
Participantes: Dominyk Cantisane - RT Diamond
Thamires Vieira Martins Horácio - Nutricionista Clínica
Atividades Gerenciais: Não se aplica
Tipo de atividade: Visita técnica

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Foi realizada visita técnica ao hospital, com acompanhamento da equipe de Nutrição Clínica, para verificação das rotinas do serviço e acompanhamento das atividades em andamento.

Durante visita à Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), sob gestão da terceirizada Diamond, foi realizada reunião com a nova Responsável Técnica da empresa, Sra. Thamires, que informou ter implementado algumas adequações no fluxo de trabalho, visando à otimização dos processos operacionais.

Na sequência, foi realizada vistoria nas obras de reforma da unidade, sendo observado avanço na execução dos serviços em relação à última visita. Até o momento, não há previsão definida para a conclusão da reforma.

Inconformidades:

Apontamentos:

Michele - Coordenadora Nutrição

Prazo pactuado para alinhamento:

Não definido.

Resultados desejados (melhorias):

Fortalecimento da integração entre a equipe de Nutrição Clínica e a empresa terceirizada.

Padronização e otimização dos fluxos de trabalho do serviço de alimentação.

Continuidade da execução das obras, visando à melhoria da estrutura física e das condições operacionais do hospital.



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

Aprimoramento da qualidade e segurança dos processos relacionados à assistência nutricional e à produção de refeições.



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

www.primaqualitasaude.org

Travessa do Ouvidor, 21 - Sala 503
Centro - Rio de Janeiro/RJ - Cep: 20.040-040
Telefone: 21 20424250
CNPJ: 40.289.134/0001-99



Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência

Data: 28/07/2026
Contrato/Dispositivo: Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth - Saquarema
Participantes: Marcela Rocha - Supervisora Rede de Cuidados
Paulo Vitor - Coordenador de Nutrição
Atividades Gerenciais: Não se aplica
Tipo de atividade: Visita técnica

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Foi realizada visita técnica ao hospital, com o objetivo de acompanhar as atividades desenvolvidas pelo Serviço de Nutrição e verificar a execução das rotinas assistenciais e operacionais.

Durante a visita, foram acompanhadas as atividades da equipe de Nutrição, sendo realizadas observações quanto aos processos de trabalho e ao funcionamento dos setores envolvidos. Também foram prestadas orientações técnicas, quando pertinentes, visando ao aprimoramento das rotinas e à padronização dos procedimentos.

Na oportunidade, foi discutida, de forma sugestiva pelo coordenador, a possibilidade de implantação da produção própria de refeições nas Policlínicas de Urgência (PUs), considerando que, atualmente, o abastecimento é realizado pela cozinha terceirizada do hospital, para avaliação da viabilidade operacional.

A visita transcorreu de forma satisfatória, sendo registradas as observações para acompanhamento nas próximas visitas técnicas.

Inconformidades:

Apontamentos:

Paulo Vitor - Coordenador de Nutrição

Prazo pactuado para alinhamento:

Não se aplica

Resultados desejados (melhorias):

Manutenção da organização e do bom funcionamento das rotinas do Serviço de Nutrição.

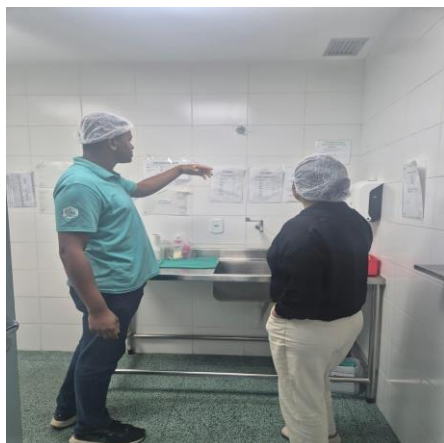
Avaliação da viabilidade operacional para otimização da produção e distribuição de refeições



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

às Policlínicas de Urgência (PUs).

Fortalecimento do planejamento dos processos, visando à melhoria contínua do serviço



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

www.primaqualitasaude.org

Travessa do Ouvidor, 21 - Sala 503
Centro - Rio de Janeiro/RJ - Cep: 20.040-040
Telefone: 21 20424250
CNPJ: 40.289.134/0001-99



Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Primária à Saúde

Data:	07/07/2026
Contrato/Dispositivo:	Santa Maria Madalena/RJ
Participantes:	Equipe CRC: Gláucia Capibaribe e Mariana Lattanzi PSF Triunfo: Enfª. Ellen da Cruz PSF Arrachadouro: Enfª. Joana; Dr Rafael
Atividades Gerenciais:	Encontro com as equipes da ESF das unidades de saúde junto com a Coordenação de APS local
Tipo de atividade:	Reunião presencial - instrução, planejamento e gestão, Visita técnica

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Visita as unidades de saúde da APS: PSF Triunfo e PSF Arrachadouro
Conversa com profissionais médicos e enfermeiros sobre o panorama dos indicadores, com ênfase no uso qualificado do sistema e as fragilidades enfrentadas;

Inconformidades:

Foram observadas algumas fragilidades na qualificação dos dados inseridos que impactam nos resultados alcançados sendo sanadas as dúvidas com os profissionais presentes.

Apontamentos:

As unidades tanto de Triunfo, quanto de Arrachadouro foram orientados aos campos e códigos que validam para avaliação dos indicadores; também foram salientados quanto ao acesso do paciente a unidade, sinalizando devidamente o tipo de consulta e não esquecerem de finalizar o atendimento.

Prazo pactuado para alinhamento:

Ao longo dos meses, através dos resultados alcançados pelos indicadores da APS

Resultados desejados (melhorias):

Melhoria na oferta e cuidado prestado ao paciente, com consequente melhoria nos resultados das boas práticas referentes aos indicadores da APS que são voltadas para o acolhimento e acompanhamento do usuário ao longo do seu ciclo de vida.



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

www.primaqualitasaude.org

Travessa do Ouvidor, 21 - Sala 503
Centro - Rio de Janeiro/RJ - Cep: 20.040-040
Telefone: 21 20424250
CNPJ: 40.289.134/0001-99



Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Primária à Saúde

Data:	10/07/2026
Contrato/Dispositivo:	Santa Maria Madalena; Arraial; Saquarema e Quissamã
Participantes:	Equipe CRC/APS: Glaucia de Oliveira - Coordenação CRC/APS; Mariana Lattanzi - Supervisora; Raphael Arêas - Supervisor; João Lucas Brito - Supervisor e Greiciane Souza-adm. Supervisores do sistema A4PM: Rodolpho (Saquarema/RJ); Marcos(Arraial/RJ) Marcelo (Quissamã/RJ) e Ronald(Santa Maria Madalena/RJ)
Atividades Gerenciais:	Encontro com Supervisores do sistema A4PM lotados nos municípios
Tipo de atividade:	Reunião online - instrução, planejamento e gestão

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Vacina – Como esta o processo de migração dos dados de vacina para a RNDS? Todos os municípios estão com o certificado digital atualizado? Conseguiram identificar o que esta ocorrendo para a não atualização de dados vacinais no site do MS?
Gestante - O lançamento da DUM e DPP, uma vez lançado não fica registrado? Foi pontuado pelos municípios que em todas as consultas com a usuária gestante, é necessário o preenchimento.

Saúde Bucal - Registro correto das ações de escovação supervisionada (indicador de SB/B4), somente é validado no sistema AB? Os dados referentes a esse indicador para o Ministério da Saúde estão zerados.

Citopatológico: Como esta a atualização no sistema para o código de coleta/exame de rastreio para DNA/HPV? Tanto no sistema sistema AB quanto no PEP constam? Código SIGTAP 02.02.10.025-1 exame molecular de detecção de HPV -conta para o indicador ministerial referente ao rastreio/ citopatológico.

Inconformidades:

- Vacinas: abordamos com os supervisores sobre a inconsistência de dados vacinais, onde as doses não estão sendo atualizadas ou quando migram, estão com as informações divergentes.

Estamos no aguardo do reprocessamento de dados que estavam retidos no sistema para acompanhar o processo de atualização dos dados vacinais no sistema do ministério da saúde.

- Gestante: Segundo os supervisores para inserir os dados de gestante em acompanhamento de pré natal tem-se duas opções (SOAP – inserir a condição – colocar a



DUM/DPP) e a cada atendimento, se abre um novo SOAP e inseri o dados todos novamente pois não fica armazenado. No caso do campo “acompanhamento de pré natal”, uma vez que insere os dados de DUM/DPP, ficam salvos, não necessitando de a cada atendimento se colocar os dados novamente;

- Saúde Bucal: avaliação da atividade coletiva, com a pratica de escovação supervisionada realizada pelo profissional da eSB, pois não estão sendo visualizado na proposta do indicador referente a eSB, que tem como avaliação de boa pratica a escovação supervisionada, entre crianças de 6 a 12 anos de idade.
- Coleta de citopatológico: referente a codificação SIGTAP para o rastreio do HPV Discutimos a verificação dos códigos corretos, visto que o Ministério da Saúde entrou com a nova proposta de rastreio para o HPV. Desta forma, verificamos que possivelmente os códigos sugeridos são para:
SIGTAP: 02.01.02.007-6 Coleta feita pelo profissional para o exame molecular de HPV.
SIGTAP: 02.02.10.025-1 O exame em si (processamento no laboratório).

Apontamentos:

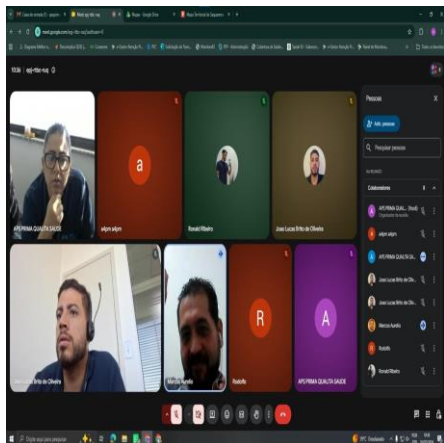
Todas as colocações feitas em reunião foram propostas aos supervisores avaliarem e nos darem a devolutiva, assim que possível, visto que, implicam em produção e financiamentos para a APS, pois estão diretamente relacionados aos indicadores da APS.

Prazo pactuado para alinhamento:

45 dias

Resultados desejados (melhorias):

Melhoria e aprimoramento do sistema para melhor qualificação das informações, visto que, são dados fornecidos ao sistema do Ministério da Saúde que causam impactos financeiros ao município.





Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Primária à Saúde

Data:	08/07/2026
Contrato/Dispositivo:	Santa Maria Madalena/RJ
Participantes:	Equipe CRC: Gláucia Capibaribe e Mariana Lattanzi PSF Manoel de Moraes: Enfª. Ana Carolina Barroso; Dra. Ana Carolina Garcia
Atividades Gerenciais:	Encontro com as equipes da ESF das unidades de saúde junto com a Coordenação de APS local
Tipo de atividade:	Reunião presencial - instrução, planejamento e gestão, Visita técnica

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Visita a unidade de saúde da APS: PSF Manoel de Moraes
Conversa com profissionais médicos e enfermeiros sobre o panorama dos indicadores, com ênfase no uso qualificado do sistema e as fragilidades enfrentada

Inconformidades:

Foram observadas algumas fragilidades na qualificação dos dados inseridos que impactam nos resultados alcançados sendo sanadas as dúvidas com os profissionais presentes.

Apontamentos:

Ao Enfermeiro e médico da unidade de Manoel de Moraes foram orientados aos campos e códigos que validam para avaliação dos indicadores; também foram salientados quanto ao acesso do paciente a unidade, sinalizando devidamente o tipo de consulta e não esquecerem de finalizar o atendimento.

Prazo pactuado para alinhamento:

Ao longo dos meses

Resultados desejados (melhorias):

Melhoria na oferta e cuidado prestado ao paciente, com consequente melhoria nos resultados das boas práticas referentes aos indicadores da APS que são voltadas para o acolhimento e acompanhamento do usuário ao longo do seu ciclo de vida.



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

www.primaqualitasaude.org

Travessa do Ouvidor, 21 - Sala 503
Centro - Rio de Janeiro/RJ - Cep: 20.040-040
Telefone: 21 20424250
CNPJ: 40.289.134/0001-99



Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Primária à Saúde

Data: 27/07/2026
Contrato/Dispositivo: SAQUAREMA
Participantes: Mariana Lattanzi - Supervisor CRC, Greiciane Souza - Assist. Adm, Joane Oliveira - Supervisor CRC, Mariana Oliveira - Supervisor APS, equipe eMulti
Atividades Gerenciais: .
Tipo de atividade: Capacitação e Educação Permanente

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

CAPACITAÇÃO COM EQUIPE EMULTI SOBRE ATRIBUIÇÕES, MATRICIAMENTO E PROJETO TEREPEÚTICO SINGULAR

Inconformidades:

- Integração entre eMulti e eSF: observa-se dificuldade de articulação da equipe eMULTI com eSF e gerência das unidades, comprometendo a lógica de apoio matricial prevista na Portaria GM/MS nº 635, de 22 de maio de 2023 ;
- Ausência de Projeto Terapêutico Singular (PTS): não foi identificada a elaboração de PTS pelas equipes, ferramenta preconizada pela Política Nacional de Humanização (PNH) como instrumento central de cuidado compartilhado e integral aos usuários;
- Baixa realização de consultas compartilhadas: verifica-se reduzida frequência dessa modalidade de atendimento, prevista como uma das principais estratégias de atuação da eMulti junto às eSF, conforme diretrizes da Portaria GM/MS nº 635, de 22 de maio de 2023.;
- Falhas na comunicação interna: identificam-se lacunas no fluxo de informações entre a gerência e as equipes quanto às atividades programadas na unidade, impactando o planejamento e a execução das ações assistenciais;
- Baixa adesão ao matriciamento: os casos discutidos em matriciamento apresentam adesão insatisfatória por parte das equipes, prejudicando a efetividade do apoio técnico-pedagógico previsto na PNAB;
- Compreensão insuficiente sobre a atuação da eMulti: constata-se desconhecimento, por parte das equipes da unidade, quanto ao escopo, atribuições e forma de atuação da equipe eMulti, o que dificulta sua correta inserção no processo de trabalho;
- Atuação em unidades não vinculadas no CNES: identifica-se atuação das equipes em



estabelecimentos sem o devido vínculo no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), em desacordo com as normas de cadastramento vigentes.

Apontamentos:

Todos os apontamentos foram repassados à Supervisora Mariana Oliveira, com as seguintes orientações e encaminhamentos acordados:

- Alinhamento entre eMulti e eSF: solicitada a realização de reunião com gerentes e equipe eSF, com o objetivo de alinhar as atividades e atribuições da equipe eMulti na unidade, buscando sanar as dificuldades de integração e de compreensão sobre sua atuação;
- Elaboração de PTS e matriciamento: determinada a supervisão, pela gestão local, da efetiva realização de Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) e das atividades de matriciamento pelas equipes, visando reverter a baixa adesão e a ausência de registros identificadas;
- Melhoria dos indicadores da eMulti: acordado o acompanhamento sistemático dos indicadores de desempenho da equipe, com vistas à correção das fragilidades apontadas, incluindo a ampliação das consultas compartilhadas;
- Regularização da atuação nas unidades vinculadas ao CNES: pactuado o alinhamento da realização das atividades das equipes exclusivamente nas unidades devidamente vinculadas no CNES, em conformidade com a legislação vigente.
- Melhoria da comunicação interna: orientada a implementação de fluxo formal de comunicação entre a gerência e as equipes quanto às atividades agendadas na unidade, de modo a garantir que todos os profissionais tenham ciência prévia da programação e evitar prejuízos ao planejamento assistencial.

Prazo pactuado para alinhamento:

45 dias

Resultados desejados (melhorias):

Com a implementação das orientações repassadas, espera-se:

- Maior integração entre a equipe eMulti e as equipes eSF, com definição clara de atribuições e fluxos de atuação conjunta;
- Elaboração regular de Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) pelas equipes, conforme preconizado pela PNH;
- Aumento na realização de consultas compartilhadas entre eMulti e eSF;
- Estabelecimento de fluxo de comunicação eficiente entre gerência e equipe quanto às atividades programadas na unidade;
- Elevação da adesão das equipes ao matriciamento dos casos discutidos;
- Ampliação da compreensão das equipes da unidade quanto ao escopo e à forma de atuação da eMulti;
- Regularização da atuação das equipes exclusivamente em unidades devidamente



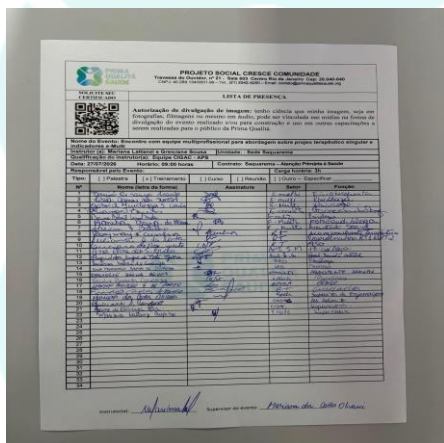
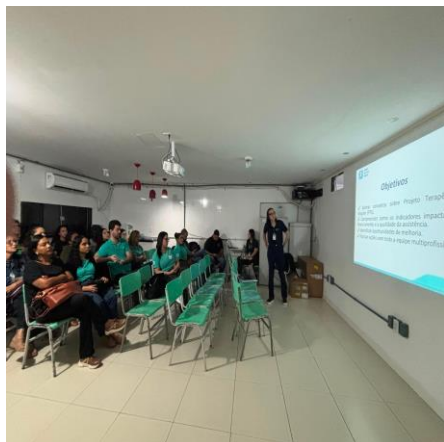
**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

vinculadas

no

CNES;

- Melhoria consolidada dos indicadores de desempenho da eMulti na unidade.



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

www.primaqualitasaude.org

Travessa do Ouvidor, 21 - Sala 503
Centro - Rio de Janeiro/RJ - Cep: 20.040-040
Telefone: 21 20424250
CNPJ: 40.289.134/0001-99



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Primária à Saúde

Data: 23/07/2026

Contrato/Dispositivo: Sede Saquarema

Participantes: Coordenadora de saúde bucal - Denize
Supervisor de Rede de Cuidados - Raphael Arêas
Representantes de empresa de prótese digital

Atividades Gerenciais: Reunião presencial junto a Coordenação de Saúde Bucal para alinhamento do serviço de prótese dentária digital.

Tipo de atividade: Reunião presencial - instrução, planejamento e gestão

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Reunião presencial junto a Coordenação de Saúde Bucal para alinhamento do serviço de prótese dentária digital.

Inconformidades:

Apontamentos:

Denize - Coordenação de saúde bucal

Prazo pactuado para alinhamento:

45 dias

Resultados desejados (melhorias):

n/a





**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Primária à Saúde

Data: 07/07/2026
Contrato/Dispositivo: Santa Maria Madalena
Participantes: Supervisor de Rede de Cuidados - Raphael Arêas
Atividades Gerenciais: Supervisor de Rede de Cuidados - Raphael Arêas
Tipo de atividade: Visita técnica

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Visita técnica das unidades: Osório, Sossego, Triunfo, Santo Antonio do Imbé, Agulha, Manoel de Moraes, Alto Imbé, Vila Sampaio.

Inconformidades:

Apontamentos:

Raphael Arêas

Prazo pactuado para alinhamento:

45 dias

Resultados desejados (melhorias):



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Primária à Saúde

Data: 08/07/2026
Contrato/Dispositivo: Santa Maria Madalena
Participantes: Supervisor de Rede de Cuidados
Atividades Gerenciais: Supervisor de Rede de Cuidados
Tipo de atividade: Visita técnica

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Visita técnica das unidades: Terras Frias, Dr Loretto, Colombiano, Ribeirão, Barra Linda.

Inconformidades:

Apontamentos:
Elivelton Machado

Prazo pactuado para alinhamento:
45 dias

Resultados desejados (melhorias):
Melhoria dos equipamentos odontológicos analisados.



Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Primária à Saúde

Data: 29/07/2026
Contrato/Dispositivo: Quissamã
Participantes: Raphael Arêas - Supervisor de Rede de Cuidados
Matheus Lima - Coordenador de Saúde Bucal Municipal
Atividades Gerenciais: Coordenação de Saúde Bucal municipal - Matheus Lima
Supervisor de Rede de Cuidados - Raphael Arêas
Tipo de atividade: Visita técnica

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Visita técnica das unidades: Centro, Caxias, Matias, Santa Catarina, Morro Alto, Carmo, Barra do Furado e Machadinha.

Inconformidades:

Apontamentos:

Matheus Lima

Prazo pactuado para alinhamento:

45 dias

Resultados desejados (melhorias):

Melhoria dos equipamentos odontológicos analisados.



Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Primária à Saúde

Data: 30/07/2026

Contrato/Dispositivo: Quissamã

Participantes: Fabianne Borges - Gerente de Contrato
Daina Chagas - Coordenadora da APS
Raphael Arêas - Supervisor de Rede de Cuidados

Atividades Gerenciais: Fabianne Borges - Gerente de Contrato
Daina Chagas - Coordenadora da APS
Raphael Arêas - Supervisor de Rede de Cuidados

Tipo de atividade: Reunião presencial - instrução, planejamento e gestão,
Reunião online - instrução, planejamento e gestão

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Avaliação das metas contratuais.

Inconformidades:

Apontamentos:

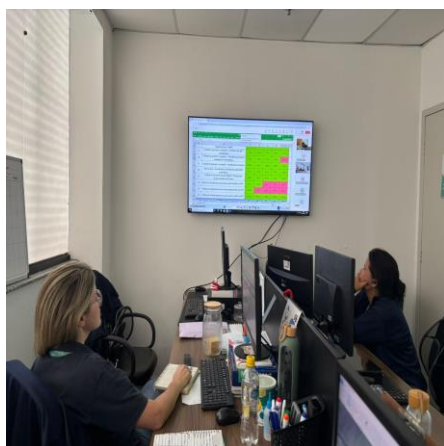
Fabianne Borges

Prazo pactuado para alinhamento:

30 dias

Resultados desejados (melhorias):

Melhorar as metas contratuais não atingidas.





Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Primária à Saúde

Data: 09/07/2026
Contrato/Dispositivo: Saquarema
Participantes: João Lucas Brito - Supervisor CRC
Greiciane Souza - Ass. Adm
Enfermeiros das unidades (manhã)
Gerentes das unidades (tarde)
Atividades Gerenciais: Panorama dos Indicadores da APS - 1º Quadrimestre/26
Tipo de atividade: Reunião presencial - instrução, planejamento e gestão

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

- Apresentação e análise dos resultados dos indicadores do Ministério da Saúde referentes ao 1º quadrimestre de 2026;
- Discussão e análise de estudos de caso.

Inconformidades:

- Registros realizados de forma incorreta ou incompleta em decorrência da ausência de orientação padronizada e clara;
- Inconsistências sistêmicas.

Apontamentos:

Orientado aos profissionais da unidade a realizarem a abertura de chamado junto à A4PM, com o objetivo de solicitar capacitação e formalizar a sinalização das inconsistências identificadas no sistema;

Definido que a equipe do CRC realizará a abertura de chamado complementar, reforçando as inconsistências apontadas e solicitando atendimento em caráter de urgência para a devida regularização das questões identificadas.

Prazo pactuado para alinhamento:

O quanto antes.

Resultados desejados (melhorias):

- Padronização dos registros realizados pelos profissionais da unidade;
- Redução de erros no preenchimento das informações no sistema;
- Fortalecimento do conhecimento da equipe quanto aos fluxos e orientações de registro;



**PRIMA
QUALITÀ
SAÚDE**

- Realização de capacitação para os profissionais, conforme solicitação encaminhada à A4PM;
- Correção das inconsistências sistêmicas identificadas, com melhoria da qualidade e confiabilidade dos dados.



PRIMA QUALITÀ SAÚDE
Travessa do Ouvidor, 21 - Sala 503 Centro/RJ de Janeiro CEP: 20.040-040
CNPJ: 40.289.134/0001-99

PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE
Atividade: Capacitação Básica e Avançada em Saúde
Data: 09/07/2024 Horário: 08:00 horas Contrato: Sequenciado - Atividade Primária à Saúde
Responsável pelo Evento: [Assinatura]

LISTA DE PRESENÇA

Autorização de divulgação de imagens: tenho ciência que minha imagem, seja em fotografias, filmagens ou mesmo em áudio, pode ser vinculada aos meios de divulgação do evento realizado a/ou para construção e uso em outras capacitações a serem realizadas para o público da Prima Qualidade.

NP	Nome (Letra de Forma)	Assinatura	Sector	Função
1	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
2	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
3	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
4	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
5	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
6	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
7	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
8	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
9	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
10	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
11	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
12	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
13	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
14	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
15	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
16	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
17	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
18	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
19	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
20	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
21	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
22	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
23	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
24	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
25	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
26	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
27	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
28	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
29	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
30	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
31	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
32	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
33	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
34	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]

CONFERE COM ORIGINAL

PRIMA QUALITÀ SAÚDE
Travessa do Ouvidor, 21 - Sala 503 Centro/RJ de Janeiro CEP: 20.040-040
CNPJ: 40.289.134/0001-99

PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE
Atividade: Capacitação Básica e Avançada em Saúde
Data: 09/07/2024 Horário: 08:00 horas Contrato: Sequenciado - Atividade Primária à Saúde
Responsável pelo Evento: [Assinatura]

LISTA DE PRESENÇA

Autorização de divulgação de imagens: tenho ciência que minha imagem, seja em fotografias, filmagens ou mesmo em áudio, pode ser vinculada aos meios de divulgação do evento realizado a/ou para construção e uso em outras capacitações a serem realizadas para o público da Prima Qualidade.

NP	Nome (Letra de Forma)	Assinatura	Sector	Função
1	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
2	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
3	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
4	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
5	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
6	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
7	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
8	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
9	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
10	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
11	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
12	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
13	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
14	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
15	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
16	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
17	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
18	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
19	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
20	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
21	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
22	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
23	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
24	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
25	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
26	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
27	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
28	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
29	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
30	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
31	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
32	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
33	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]
34	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]	[Assinatura]

CONFERE COM ORIGINAL



Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Primária à Saúde

Data: 21/07/2026

Contrato/Dispositivo: Arraial do Cabo

Participantes: João Lucas Brito - Supervisor CRC
Greiciane Souza - Ass. Adm
Mariana Velasco - Diretora APS
Henrique Valvieste - Subgerente unidades
Administradores das unidades
Enfermeiras das unidades
Médica - UBS Hermes Barcellos

Atividades Gerenciais: Panorama dos Indicadores da APS - 1º Quadrimestre/26

Tipo de atividade: Reunião presencial - instrução, planejamento e gestão

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

- Apresentação e análise dos resultados dos indicadores do Ministério da Saúde referentes ao 1º quadrimestre de 2026;
- Discussão e análise de estudos de caso.

Inconformidades:

- Registros realizados de forma incorreta ou incompleta em decorrência da ausência de orientação padronizada e clara;
- Inconsistências sistêmicas.

Apontamentos:

- Orientado aos profissionais da unidade a realizarem a abertura de chamado junto à A4PM, com o objetivo de solicitar capacitação e formalizar a sinalização das inconsistências identificadas no sistema;
- Definido que a equipe do CRC realizará a abertura de chamado complementar, reforçando as inconsistências apontadas e solicitando atendimento em caráter de urgência para a devida regularização das questões identificadas.

Prazo pactuado para alinhamento:

Com a maior brevidade possível.

Resultados desejados (melhorias):

- Padronização dos registros realizados pelos profissionais da unidade;
- Redução de erros no preenchimento das informações no sistema;
- Fortalecimento do conhecimento da equipe quanto aos fluxos e orientações de registro;



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

- Realização de capacitação para os profissionais, conforme solicitação encaminhada à A4PM;
- Correção das inconsistências sistêmicas identificadas, com melhoria da qualidade e confiabilidade dos dados.



PRIMA QUALITÁ SAÚDE
Travessa do Ouvidor, 21 - Sala 503
Centro - Rio de Janeiro/RJ - Cep: 20.040-040
Telefone: 21 20424250 - Fax: 21 20424250 - E-mail: contato@primaqualitasaude.org

PROJETO SOCIAL CRESCER COMUNIDADE
TODOS OS DIAS DO 1º, 3º, 5º, 7º, 9º, 11º, 13º, 15º, 17º, 19º, 21º, 23º, 25º, 27º, 29º, 31º DE AGOSTO - 2025

LISTA DE PRESEÇA

Autorização de divulgação de imagens: todos sabem que minha imagem, seja em fotografias, filmagens ou mesmo em áudio, pode ser vinculada aos dados na forma de divulgação. Se você concordar com esta autorização e com o uso de suas informações e dados pessoais para o projeto da Prima Qualitá.

Nome do Evento: Formação Saúde Brasil 1400 - Boas práticas indicadores de APS 1º Quadrimestre - 2025
Organizador: Secretaria Municipal de Saúde e Saúde Bucal - Prefeitura Municipal de São João del-Rei
Local: Centro de Referência de Saúde - APS - Unidade: Unidade Básica de Saúde - Vila Rica
Data: 21/08/2025 - Horário: 13:00 horas - Contrato: Anual de Contr. - Atividade: Formação e Saúde - Curso: Saúde Bucal

Nº	Nome do Participante	Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura
01	Adriana de Souza				
02	Adriana de Souza				
03	Adriana de Souza				
04	Adriana de Souza				
05	Adriana de Souza				
06	Adriana de Souza				
07	Adriana de Souza				
08	Adriana de Souza				
09	Adriana de Souza				
10	Adriana de Souza				
11	Adriana de Souza				
12	Adriana de Souza				
13	Adriana de Souza				
14	Adriana de Souza				
15	Adriana de Souza				
16	Adriana de Souza				
17	Adriana de Souza				
18	Adriana de Souza				
19	Adriana de Souza				
20	Adriana de Souza				
21	Adriana de Souza				
22	Adriana de Souza				
23	Adriana de Souza				
24	Adriana de Souza				
25	Adriana de Souza				
26	Adriana de Souza				
27	Adriana de Souza				
28	Adriana de Souza				
29	Adriana de Souza				
30	Adriana de Souza				
31	Adriana de Souza				
32	Adriana de Souza				
33	Adriana de Souza				
34	Adriana de Souza				

Instituidor: [Assinatura] - Supervisor do Evento: [Assinatura]

**QUALITÁ
SAÚDE**



Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Saúde Mental e Psicosocial

Data: 02/07/2026
Contrato/Dispositivo: Saquarema/ Ambulatório de Saúde Mental
Participantes: Vnessa Mendonça- Supervisora da Rede de Cuidados, Camila Leal- Psicóloga, Ingrid- Coordenadora do Ambulatório de Saúde Mental e Rafael Carmo- psicólogo
Atividades Gerenciais: Supervisão
Tipo de atividade: Reunião presencial - instrução, planejamento e gestão

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Visita técnica de orientação: Realização de agenda institucional com foco no alinhamento e orientação do processo de trabalho da equipe local.
Supervisão de manejo clínico: Monitoramento prático e suporte técnico voltado à condução de grupos terapêuticos na unidade.
Acompanhamento do Grupo de Recepção: Participação direta como observador no grupo de acolhimento/recepção para avaliação da dinâmica assistencial.
Feedback técnico aos condutores: Realização de devolutiva técnica e repasse de orientações metodológicas aos dois psicólogos responsáveis pela facilitação da atividade.
Alinhamento com a gestão: Reunião de fechamento com a coordenação do serviço para discussão e repasse das melhorias estruturais necessárias.

Inconformidades:

Necessidade de ajustes no manejo grupal: Identificou-se a necessidade de refinamento nas técnicas de manejo e condução da atividade coletiva, visando garantir maior fluidez e alcance dos objetivos terapêuticos propostos.

Apontamentos:

Coordenadora do Ambulatório: Ingrid

Orientações Repassadas: Foram transmitidas orientações específicas aos dois psicólogos facilitadores sobre técnicas de intervenção grupal, manejo de participantes e gestão do tempo em sessões coletivas.

Decisões Acordadas: Em alinhamento imediato com a coordenadora Ingrid, foram definidos os ajustes técnicos prioritários para o fluxo de recepção dos pacientes. A gestão local



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

comprometeu-se a monitorar a aplicação das diretrizes repassadas, com prazo de adequação imediata incorporado ao plano de ação da unidade.

Prazo pactuado para alinhamento:

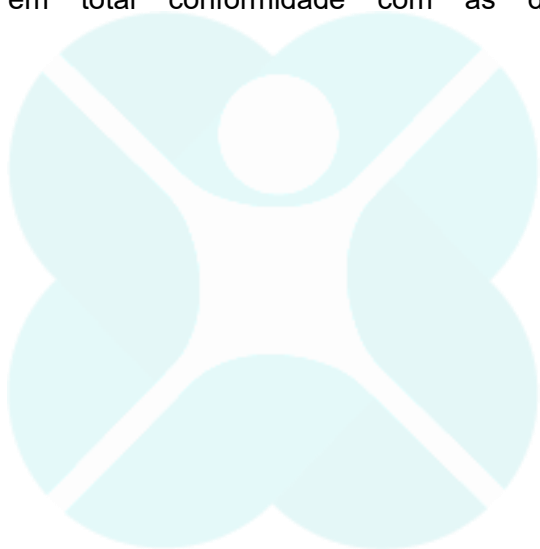
30 dias,

Resultados desejados (melhorias):

Excelência no manejo clínico: Garantir que os profissionais conduzam os grupos terapêuticos com maior segurança técnica, domínio metodológico e resolutividade.

Otimização do fluxo assistencial: Promover uma melhor integração entre o Grupo de Recepção e os tratamentos subsequentes do ambulatório.

Padronização do processo de trabalho: Estabelecer um modelo de acolhimento fluido, ágil e em total conformidade com as diretrizes regulatórias e éticas da profissão.



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**



Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Saúde Mental e Psicosocial

Data:	02/07/2026
Contrato/Dispositivo:	Saquarema / CAPS II
Participantes:	Joane Oliveira - Supervisora de Rede de Cuidados. Arnaldo Souza - Coordenador do CAPS II. Equipe multiprofissional do CAPS II presente no dia da visita técnica.
Atividades Gerenciais:	Supervisão.
Tipo de atividade:	Visita técnica, Monitoramento e avaliação

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Foi realizada visita técnica ao CAPS II de Saquarema com a finalidade de acompanhar, in loco, os processos de trabalho desenvolvidos pela equipe que consiste na observação direta do local onde as atividades assistenciais efetivamente acontecem. Durante a visita, foram acompanhados o fluxo assistencial, as rotinas de trabalho da equipe multiprofissional, a organização dos atendimentos, bem como a execução das oficinas terapêuticas e dos grupos terapêuticos ofertados aos usuários. A observação direta permitiu identificar aspectos relacionados à organização do serviço, à condução das atividades terapêuticas e às práticas assistenciais desenvolvidas, favorecendo a avaliação da conformidade dos processos de trabalho e a identificação de oportunidades de qualificação. Verificou-se que as oficinas terapêuticas estão sendo executadas de forma regular, organizada e em conformidade com o cronograma estabelecido pela unidade, sendo conduzidas pela equipe multiprofissional de maneira adequada, com participação ativa dos usuários e alinhamento aos objetivos da reabilitação psicossocial.

Inconformidades:

Durante a observação das oficinas terapêuticas e das atividades acompanhadas, não foram identificadas inconformidades relacionadas à execução das ações observadas. As atividades encontravam-se em conformidade com a proposta assistencial do serviço e alinhadas aos princípios da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), conforme as diretrizes da Lei nº 10.216/2001 e da Portaria de Consolidação GM/MS nº 3/2017, Anexo V, que dispõe sobre a organização da RAPS.

Apontamentos:

Foram apresentados os objetivos da visita técnica, ressaltando a importância do acompanhamento contínuo dos processos de trabalho como estratégia para fortalecimento das boas práticas assistenciais e melhoria contínua da qualidade do cuidado ofertado. Orientou-se a manutenção da regularidade das oficinas terapêuticas, do registro adequado



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

das atividades desenvolvidas e do monitoramento sistemático dos indicadores assistenciais, conforme estabelecido nos instrumentos de gestão da unidade.

Prazo pactuado para alinhamento:

30 dias

Resultados desejados (melhorias):

- Fortalecer a qualificação dos processos de trabalho por meio do monitoramento contínuo.
- Manter a regularidade e a qualidade das oficinas e grupos terapêuticos, garantindo sua aderência ao Projeto Terapêutico Singular (PTS) dos usuários.
- Incentivar a melhoria contínua dos registros assistenciais e do acompanhamento dos indicadores de produção e qualidade.
- Consolidar as boas práticas observadas durante a visita, promovendo a organização do serviço e o fortalecimento da atenção psicossocial centrada no usuário.



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**



Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Saúde Mental e Psicosocial

Data: 02/07/2026

Contrato/Dispositivo: Saquarema/ CAPSII

Participantes: Vanessa Mendonça, Joane Oliveira e Franciele Lima- Supervisoras de Rede de Cuidados, Arnaldo Souza Coordenador do CAPSII, Luan Cabral - Supervisor local, Luciana Costa- Coordenadora SRT, Ingrid Garcia- Coordenadora do Ambulatório de Saúde Mental, Lilian Fortunato- Coordenadora de Saúde Mental e Dr. Vitoria Cabral- RT Médica

Atividades Gerenciais: Reunião de Coordenação

Tipo de atividade: Reunião presencial - instrução, planejamento e gestão

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Infraestrutura e recursos humanos do Ambulatório: Discussão sobre o atraso na chegada do auxiliar de farmácia, impactando o tempo de atendimento em dias de maior fluxo, e instabilidade na linha telefônica do serviço.

Manejo em grupos terapêuticos: Alinhamento técnico sobre as dinâmicas e condução dos grupos assistenciais realizados no ambulatório.

Fluxos da Psicologia Hospitalar: Solicitação de agenda específica para apresentação, alinhamento dos Protocolos Operacionais Padrão (Pops) já estruturados e definição das diretrizes de acolhimento em situações de óbito.

Funcionalidades do Prontuário Eletrônico (e-SUS): Relato sobre a ausência do campo de registro de atividades coletivas/grupos no sistema, gerando a necessidade de anotações manuais temporárias pela equipe de psicologia.

Suporte à equipe e insumos do CAPS AD: Discussão sobre o impacto emocional e a fragilidade da equipe após intercorrência grave com usuário, além do desabastecimento de materiais para oficinas terapêuticas.

Programa de Estágio: Alinhamento sobre a centralização administrativa dos processos de estágio no Centro Administrativo da UNIO.

Calendário Institucional e Fóruns: Ajuste na data fixa das reuniões de coordenação para a segunda quinta-feira de cada mês, visando garantir a participação nos Fóruns de Saúde Mental, e definição da data da festividade do CAPS II.



Inconformidades:

Falha em canal de comunicação essencial: Instabilidade na linha telefônica do ambulatório, prejudicando o direito de acesso, agendamento e informação dos pacientes.

Apontamentos:

Luan Cabral (Supervisor Local): Informou que já formalizou a cobrança junto à empresa prestadora para a regularização imediata do sistema telefônico. Ficou responsável por auditar o fluxo de entrega de materiais para as oficinas do CAPS AD e avaliar a viabilidade legal/orçamentária para a concessão de horas extras para suprir os afastamentos da equipe de Psicologia no CAPSII.

Lilian Fortunato (Coordenadora de Saúde Mental): Alinhou as diretrizes do programa de estágio, que passará a ser centralizado na UNIO. Solicitou e agendou uma reunião com a equipe de Psicologia Hospitalar para o próximo dia 07 para desenhar o fluxo de acolhimento em casos de óbito.

Marcos (Coordenação CAPS AD): Trouxe as demandas de suporte à equipe pós-intercorrência. Ficou acordado que a coordenação/supervisão comparecerá à próxima reunião de equipe do CAPS AD para realizar o acolhimento institucional e conduzir o manejo da situação com os colaboradores.

Ingred Garcia (Coordenação Ambulatório): Reportou as demandas do e-SUS e da farmácia. Foi orientada a manter temporariamente os registros manuais da psicologia até a atualização do sistema e a alinhar com a equipe o manejo do fluxo nos dias de maior movimento.

Decisão Coletiva da Gestão: Definiu-se que as reuniões de coordenação ocorrerão na segunda quinta-feira de cada mês (sendo a próxima em 13/07/2026). A festividade do CAPS II ficou agendada para o dia 11/08/2026.

Prazo pactuado para alinhamento:

30 dias

Resultados desejados (melhorias):

Restabelecimento dos canais de acesso: Normalização imediata do telefone do ambulatório para garantir o fluxo regular de marcações dos usuários.

Suporte à Saúde Mental do Trabalhador: Mitigar o impacto emocional na equipe do CAPS AD através de suporte e escuta qualificada na próxima reunião.

Eficiência e Padronização: Implementação de Pops claros para a psicologia hospitalar em situações de óbito e regularização dos insumos de oficina e RH.



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

PRIMA QUALITÁ SAÚDE
FORMULÁRIO DE REGISTRO DE CENÁRIO

Nome: _____ Data: 22/11/2016

Endereço: _____

ASSISTENTES TRATADOR

1. Nome: _____ Função: _____

2. Nome: _____ Função: _____

3. Nome: _____ Função: _____

4. Nome: _____ Função: _____

5. Nome: _____ Função: _____

6. Nome: _____ Função: _____

7. Nome: _____ Função: _____

8. Nome: _____ Função: _____

9. Nome: _____ Função: _____

10. Nome: _____ Função: _____

RESPONSÁVEL POR REALIZAR E AUTOPESQUISAR

1. Nome: _____ Função: _____

2. Nome: _____ Função: _____

3. Nome: _____ Função: _____

4. Nome: _____ Função: _____

5. Nome: _____ Função: _____

6. Nome: _____ Função: _____

7. Nome: _____ Função: _____

8. Nome: _____ Função: _____

9. Nome: _____ Função: _____

10. Nome: _____ Função: _____

PARTICIPANTES

Nome	Função	Contato
Guilherme Sampaio	Coord. CAPS	9 9999-9999
Luana C. P. de Jesus	Sup. S.M.	9 9999-9999
Luciana A. de Jesus	Coord. S.M.	9 9999-9999
Luiz Carlos de Jesus	Coord. S.M.	9 9999-9999
Luiz Carlos de Jesus	Coord. S.M.	9 9999-9999
Luiz Carlos de Jesus	Coord. S.M.	9 9999-9999
Luiz Carlos de Jesus	Coord. S.M.	9 9999-9999
Luiz Carlos de Jesus	Coord. S.M.	9 9999-9999
Luiz Carlos de Jesus	Coord. S.M.	9 9999-9999
Luiz Carlos de Jesus	Coord. S.M.	9 9999-9999



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

www.primaqualitasaude.org

Travessa do Ouvidor, 21 - Sala 503

Centro - Rio de Janeiro/RJ - Cep: 20.040-040

Telefone: 21 20424250

CNPJ: 40.289.134/0001-99



Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Saúde Mental e Psicosocial

Data:	06/07/2026
Contrato/Dispositivo:	Santa Maria Madalena/ CAPSI
Participantes:	Vanessa Mendonça, Joane de Oliveira- Supervisora de Rede de Cuidados, Milena Souza- Coordenadora Técnica e Anete- Gerente administrativa
Atividades Gerenciais:	Supervisão
Tipo de atividade:	Reunião presencial - instrução, planejamento e gestão

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Canais de comunicação com o usuário: Monitoramento da indisponibilidade de contato gerada pelo aparelho telefônico danificado (quebrado) na unidade.

Infraestrutura e ambiência: Diagnóstico sobre a necessidade de reposição de eletrodomésticos essenciais (geladeira) e manutenção de equipamentos de integração/lazer (televisão inoperante e necessidade de aparelho TV Box).

Estrutura de Tecnologia da Informação (TI): Avaliação do deficit de computadores para o corpo técnico, gerando restrição nos registros de relatórios e lançamentos de produtividade.

Educação permanente da equipe: Planejamento e alinhamento para a realização de capacitação em oficinas e grupos terapêuticos.

Calendário institucional: Definição da data da festividade comemorativa (Festa Julina) da unidade.

Fluxos de Rede Intersetorial (Saúde e Assistência Social): Alinhamento sobre as demandas externas de informação a respeito das novas Residências Inclusivas (RI) do município.

Inconformidades:

Prejuízo nos canais de atendimento por dano em equipamento: O aparelho telefônico da unidade encontra-se quebrado, interrompendo a comunicação ativa e os informativos aos pacientes.

Restrição de recursos tecnológicos para o corpo técnico: Os computadores da unidade estão operacionais apenas nos setores administrativo e consultório médico. A falta de máquinas para a equipe técnica dificulta a confecção de relatórios e o lançamento oportuno da produtividade no sistema.



Necessidade de adequação em itens de ambiência: Unidade operando sem geladeira e com aparelho de televisão sem funcionamento, demandando também um receptor TV Box.

Dúvidas institucionais sobre fluxos intersetoriais: Demandas da comunidade direcionadas ao CAPS buscando informações sobre equipamentos que não pertencem à rede de saúde, necessitando de alinhamento técnico de fluxos.

Apontamentos:

Milena Souza (Coordenadora Técnica) e Anete (Gerente Administrativa): Recepcionaram a equipe de supervisão e apresentaram as demandas de infraestrutura, RH e insumos.

Encaminhamentos e Decisões Acordadas:

Telefonia: Realizado contato com a gerência de contratos, que esclareceu que o processo de compra para a substituição do aparelho telefônico quebrado já foi iniciado.

Eventos: Ficou definido que a Festa Julina do CAPS acontecerá no dia 14 de julho.

Capacitação: Ficou agendada e confirmada a capacitação focada em oficinas terapêuticas e grupos terapêuticos para o dia 18 de agosto.

Orientação sobre Residências Inclusivas (RI): A coordenadora Milena relatou que o município contará com duas novas Residências Inclusivas e que o CAPS tem recebido questionamentos do público sobre o tema. A equipe de supervisão realizou a orientação técnica de que esse serviço é de competência exclusiva da Assistência Social (SUAS). Portanto, foi acordado que a equipe local deve sempre orientar os usuários de que a gestão deste equipamento não cabe à Saúde Mental, direcionando as dúvidas para a secretaria ou órgãos da Assistência Social.

Prazo pactuado para alinhamento:

30 dias

Resultados desejados (melhorias):

Restabelecimento da comunicação: Entrega e instalação do novo aparelho telefônico para normalizar as chamadas e informativos aos usuários.

Autonomia tecnológica para os técnicos: Fornecimento de computadores adicionais para que os profissionais registrem seus relatórios e produtividades sem barreiras operacionais.

Estruturação da ambiência: Aquisição da geladeira e restabelecimento do sistema de TV (com TV Box) para qualificar o espaço de convivência.



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

Aprimoramento metodológico: Realização da capacitação em agosto para aperfeiçoar a condução das atividades coletivas da unidade.

Alinhamento de fluxos e resolutividade: Garantir que a equipe realize o direcionamento intersetorial correto e assertivo aos usuários, evitando ruídos de comunicação entre as redes de Saúde Mental e Assistência Social.



**QUALITÁ
SAÚDE**



Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Saúde Mental e Psicosocial

Data: 02/07/2026
Contrato/Dispositivo: Saquarema
Participantes: Franciele de Lima - Supervisora de Rede de Cuidados
Caroline Helena da Silva Penaforte Parreiras - Assistente Administrativo.
Aline de Sousa Aprung - Assistente Administrativo.
Atividades Gerenciais: Reunião presencial - instrução, planejamento e gestão
Tipo de atividade: Reunião presencial - instrução, planejamento e gestão, Visita técnica

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Atividades Terapêuticas

Durante a observação, verificou-se que a oficina terapêutica iniciou às 09h40.

Conforme o cronograma da unidade, a atividade prevista era uma oficina de artesanato. Entretanto, foi realizada uma oficina de beleza, com oferta de corte de cabelo masculino.

Observou-se que diversos usuários permaneceram deitados em diferentes ambientes do serviço, sem participação na atividade terapêutica desenvolvida.

Segundo relato da equipe, a alteração ocorreu em razão da insuficiência de insumos necessários para execução das oficinas planejadas, comprometendo o cumprimento do cronograma terapêutico. Estrutura Física

Durante a inspeção da unidade foram observadas as seguintes condições:

Bebedouro obstruído, impossibilitando o fornecimento adequado de água aos usuários e colaboradores;

Caixa d'água confeccionada em amianto sem vedação apropriada, permanecendo protegida apenas por cobertura plástica em alguns momentos, favorecendo risco de contaminação; Torneiras do tanque localizado próximo à piscina permaneciam abertas sem utilização, ocasionando desperdício contínuo de água.

Inconformidades:

Divergência entre a programação terapêutica registrada e a atividade realizada no momento da visita técnica.

Insuficiência de materiais e insumos para execução regular das oficinas terapêuticas previstas.



Baixa adesão/participação dos usuários na atividade terapêutica observada, com usuários permanecendo sem inserção na proposta desenvolvida. Bebedouro da unidade apresentando obstrução, comprometendo sua funcionalidade. Caixa d'água sem vedação adequada, apresentando potencial risco sanitário devido à possibilidade de entrada de contaminantes. Uso inadequado das instalações hidráulicas, com torneiras abertas sem necessidade, ocasionando desperdício de água. Necessidade de validação e atualização contínua das informações cadastrais dos profissionais vinculados ao CNES.

Apontamentos:

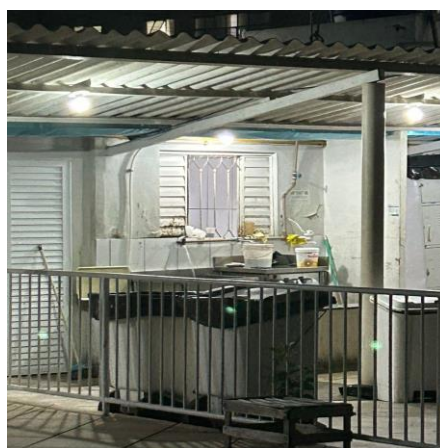
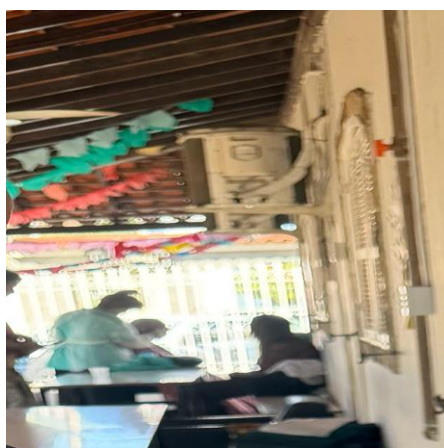
Caroline Helena da Silva Penaforte Parreiras - Assistente Administrativo.
Aline de Sousa Aprung - Assistente Administrativo.
Não foram descritos.

Prazo pactuado para alinhamento:

30 dias

Resultados desejados (melhorias):

Regularidade na execução das oficinas terapêuticas conforme cronograma estabelecido;
Disponibilidade contínua de insumos necessários às atividades terapêuticas;
Maior adesão e participação dos usuários nas atividades coletivas;
Melhoria da qualidade da assistência ofertada aos usuários do CAPS AD;
Restabelecimento do funcionamento adequado do bebedouro;
Eliminação dos riscos sanitários relacionados à vedação da caixa d'água;
Redução do desperdício de água e fortalecimento das práticas de sustentabilidade;
Melhoria das condições estruturais da unidade;
Fortalecimento da organização dos processos de trabalho e da qualidade assistencial.





**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

www.primaqualitasaude.org

Travessa do Ouvidor, 21 - Sala 503
Centro - Rio de Janeiro/RJ - Cep: 20.040-040
Telefone: 21 20424250
CNPJ: 40.289.134/0001-99



Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Saúde Mental e Psicosocial

Data: 07/07/2026

Contrato/Dispositivo: Saquarema / CAPS AD.

Participantes: Equipe técnica do CAPS AD.
Pedro - Supervisor clínico Institucional.
Lilian - Coordenadora de saúde mental.
Luan - Supervisor de saúde mental local.
Joane Oliveira - Supervisora de Rede de Cuidados.
Vanessa Mendonça - Supervisora de Rede de Cuidados.

Atividades Gerenciais: Supervisão.

Tipo de atividade: Reunião presencial - instrução, planejamento e gestão

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Foi realizada reunião de equipe no CAPS AD, com a participação da equipe técnica do serviço, do Supervisor de Saúde Mental, Pedro, do Supervisor Local, Luan, e da Coordenadora Municipal de Saúde Mental, Lilian.

Durante a reunião, foram discutidos os seguintes pontos:

Materiais para Oficinas Terapêuticas: Foi solicitado que a equipe elabore uma relação detalhada e individualizada dos materiais necessários para o desenvolvimento das oficinas terapêuticas, encaminhando-a ao Supervisor Local, Luan, para as providências referentes à aquisição.

Manejo de Situações de Crise: Reforçou-se a importância da qualificação do manejo das situações de crise, priorizando intervenções pautadas na escuta qualificada, na comunicação terapêutica e no fortalecimento do vínculo com os usuários, conforme os princípios da atenção psicossocial.

Projeto Terapêutico Singular (PTS): Foi solicitado à equipe o levantamento atualizado do quantitativo de usuários que possuem Projeto Terapêutico Singular (PTS) ativo.

Dimensionamento das Quarentinhas: Destacou-se a necessidade de conhecer o número de usuários acompanhados por meio de PTS, considerando que essas informações subsidiarão a análise da demanda e o planejamento quanto à necessidade de ampliação da oferta de refeições (quarentinhas) aos usuários do serviço.

Inconformidades:

Ausência de levantamento atualizado dos usuários com Projeto Terapêutico Singular (PTS) ativo, dificultando o monitoramento assistencial, o planejamento das ações terapêuticas e o dimensionamento adequado dos recursos do serviço.
Necessidade de sistematização da relação de materiais utilizados nas oficinas terapêuticas,



visando subsidiar o processo de aquisição e garantir a continuidade das atividades ofertadas aos usuários.

Identificada a necessidade de fortalecimento das práticas de manejo de situações de crise, com ênfase em intervenções pautadas na comunicação terapêutica, na escuta qualificada e no fortalecimento do vínculo, em consonância com os princípios da atenção psicossocial previstos na Lei nº 10.216/2001 e nas diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

Apontamentos:

A equipe deverá elaborar uma lista detalhada dos materiais necessários para a execução das oficinas terapêuticas e encaminhá-la ao Supervisor Local, Luan, para prosseguimento do processo de aquisição.

Solicitou-se o levantamento atualizado para a equipe do quantitativo de usuários com Projeto Terapêutico Singular (PTS) ativo.

Orientou-se que essas informações sejam utilizadas para subsidiar a avaliação da necessidade de ampliação da oferta de refeições (quentinhas), garantindo que o quantitativo disponibilizado esteja compatível com a demanda assistencial da unidade.

Prazo pactuado para alinhamento:

30 dias

Resultados desejados (melhorias):

Disponibilização de relação completa e atualizada dos materiais necessários para as oficinas terapêuticas, possibilitando planejamento adequado das aquisições. Atualização do quantitativo de usuários com PTS ativo, qualificando o acompanhamento assistencial, o monitoramento dos indicadores e o planejamento das ações terapêuticas. Aprimoramento das práticas de manejo de crise pela equipe, fortalecendo a assistência humanizada e reduzindo intervenções desnecessárias. Adequação da oferta de refeições às necessidades reais dos usuários acompanhados pelo serviço, contribuindo para maior organização do processo de trabalho e melhor utilização dos recursos disponíveis.



Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Saúde Mental e Psicosocial

Data:	07/07/2026
Contrato/Dispositivo:	Saquarema / Hospital Municipal Porphírio Nunes de Azeredo.
Participantes:	Lilian – Coordenadora Municipal de Saúde Mental. Denise – Responsável Técnica da Psicologia Hospitalar do Hospital Municipal Porphírio Nunes de Azeredo. Joane Oliveira - Supervisora de Rede de Cuidados. Vanessa Mendonça - Supervisora de Rede de Cuidados.
Atividades Gerenciais:	Supervisão.
Tipo de atividade:	Reunião presencial - instrução, planejamento e gestão

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Realizada reunião de alinhamento dos fluxos assistenciais da Psicologia Hospitalar do Hospital Municipal Porphírio Nunes de Azeredo, com foco na organização do processo de trabalho, padronização das práticas assistenciais e qualificação do atendimento. Foram discutidos o fluxo de atendimento da Psicologia Hospitalar, as principais demandas assistenciais do serviço, a rotina de atuação dos psicólogos e os desafios identificados no cotidiano da unidade. Também foi abordada a possibilidade de implantação de cobertura em regime de plantão psicológico na escala de 24 horas por 120 horas, sendo pactuado que a viabilidade da proposta deverá ser analisada com base no levantamento da demanda assistencial, perfil dos atendimentos e necessidade institucional. Durante a reunião, foi solicitada a implantação da Anamnese Psicológica Hospitalar como instrumento de avaliação inicial dos pacientes acompanhados pela Psicologia, com o objetivo de padronizar a coleta de informações clínicas e psicossociais, qualificar os registros em prontuário, subsidiar a elaboração do plano terapêutico e fortalecer a continuidade da assistência. Por fim, foi reforçada a utilização do Procedimento Operacional Padrão (POP) da Psicologia Hospitalar como documento norteador das atividades desenvolvidas pela equipe, garantindo maior padronização dos fluxos, segurança assistencial e conformidade com as diretrizes institucionais.

Inconformidades:

Necessidade de padronização dos fluxos assistenciais da Psicologia Hospitalar por meio da implementação efetiva do Procedimento Operacional Padrão (POP). Ausência de instrumento padronizado para realização da anamnese psicológica inicial dos pacientes, comprometendo a uniformidade dos registros e do processo assistencial.



Apontamentos:

Responsável Local: Denise – Responsável Técnica da Psicologia Hospitalar. Foram alinhados os fluxos assistenciais da Psicologia Hospitalar e reforçada a obrigatoriedade da utilização do POP como instrumento de padronização das atividades desenvolvidas pela equipe. Foi orientada a implantação da Anamnese Psicológica Hospitalar como documento padrão para avaliação inicial dos pacientes atendidos pela Psicologia, visando qualificar o processo assistencial, padronizar os registros em prontuário e subsidiar a construção do plano terapêutico.

Prazo pactuado para alinhamento:

30 dias

Resultados desejados (melhorias):

Padronização dos fluxos de trabalho da Psicologia Hospitalar por meio da implantação efetiva do POP. Implantação da Anamnese Psicológica Hospitalar como instrumento padrão de avaliação inicial, promovendo maior qualidade dos registros e da assistência. Maior organização e uniformidade das práticas assistenciais desenvolvidas pela equipe. Dimensionamento adequado da equipe de Psicologia Hospitalar com base na demanda real do serviço. Melhoria da qualidade, da segurança e da continuidade da assistência psicológica aos pacientes hospitalizados. Fortalecimento da gestão dos processos e do monitoramento dos indicadores assistenciais para subsidiar futuras tomadas de decisão.





Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Saúde Mental e Psicosocial

Data:	15/07/2026
Contrato/Dispositivo:	Saquarema/ Ambulatório de Saúde Mental
Participantes:	Vanessa Mendonça- Supervisora de Rede de Cuidados, Ingrid- Coordenadora do Ambulatório e Lilian Coordenadora de Saúde Mental
Atividades Gerenciais:	Reunião com coordenação e Supervisão .
Tipo de atividade:	Reunião presencial - instrução, planejamento e gestão

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Fluxo e remanejamento de profissionais: Encaminhamento de 1 (uma) psicóloga para a Clínica do Idoso e 2 (duas) para a Clínica do Homem para atuação em carga horária de 20 horas semanais, motivado pela baixa disponibilidade de consultórios físicos no Ambulatório de Saúde Mental.

Prospecção de novos espaços de atendimento: Planejamento de articulação, por meio da coordenadora Ingrid, com a Clínica da Mulher e com o Posto Único (PU) de Sampaio Correia para mapeamento de salas disponíveis.

Mapeamento do Teleatendimento: Articulação de reunião com a coordenadora Nathália no Ambulatório de Saúde Mental para levantamento de vagas e capacidade técnica de atendimento remoto.

Educação Permanente e Regulação: Realização de reunião com os psicólogos da regulação para alinhamentos técnicos. A partir disso, foi programada uma capacitação voltada aos auxiliares administrativos sobre manejo de pacientes e atribuições da recepção física, a ser conduzida por Lilian no dia 31.

Alinhamento ético-técnico com a equipe: Realização de orientações técnicas com os psicólogos do ambulatório sobre a condução dos grupos de recepção, preenchimento de dados de produtividade (levantamento de pacientes), sigilo profissional e preceitos éticos.

Inconformidades:

Necessidade de otimização de espaços físicos: Importância de mapear novas salas e descentralizar alguns atendimentos, tendo em vista o alto fluxo de atividades no Ambulatório de Saúde Mental e a necessidade de acomodar adequadamente os novos horários da equipe de psicologia.

Aprimoramento metodológico nos grupos terapêuticos de recepção: Oportunidade de alinhar e qualificar ainda mais as estratégias de manejo dos psicólogos especificamente dentro dos grupos de recepção (acolhimento inicial de pacientes), garantindo um fluxo mais dinâmico de entrada na rede. (Nota: O treinamento dos auxiliares administrativos que atuam na recepção física já está planejado para o dia 31).



Alinhamento sobre prerrogativas profissionais: Necessidade de reforçar as diretrizes do Código de Ética Profissional do Psicólogo (Resolução CFP nº 010/05, Art. 9º), especificamente no que tange ao dever de resguardar o sigilo profissional, garantindo que o fluxo administrativo de dados não comprometa a confidencialidade clínica dos pacientes.

Apontamentos:

Responsável	local:	Coordenadora	Ingrid.
Encaminhamentos		e	deliberações:

Ficou sob responsabilidade da coordenadora Ingrid realizar o contato oficial com a Clínica da Mulher e com o PU de Sampaio Correia para verificar a viabilidade de salas físicas. Definida a realização da capacitação para os auxiliares administrativos da recepção no dia 31 deste mês, a ser ministrada por Lilian, com foco em manejo com pacientes e funções administrativas (alinhado previamente em reunião com os psicólogos da regulação). Acordada a realização de reunião com Nathália para diagnóstico da capacidade de vagas no teleatendimento.

Realizada orientação técnica direta aos psicólogos locais quanto ao manejo de grupos de recepção e ao levantamento preciso de dados epidemiológicos/número de pacientes atendidos.

Prazo pactuado para alinhamento:

30 dias

Resultados desejados (melhorias):

Otimização do espaço físico e ampliação de vagas: Descentralização eficiente da agenda de psicologia, aproveitando as salas da Clínica da Mulher, PU de Sampaio Correia e a modalidade de teleatendimento para reduzir a fila de espera.

Humanização e eficiência no atendimento inicial: Melhoria no acolhimento e na recepção física por meio da capacitação dos auxiliares administrativos ministrada por Lilian, organizando melhor as funções da entrada e diminuindo o estresse do paciente.

Segurança jurídica e ética no serviço: Consolidação de uma prática profissional rigorosamente alinhada ao Código de Ética da Psicologia, mitigando riscos de quebra de sigilo e organizando um sistema seguro de monitoramento de dados epidemiológicos dos pacientes atendidos.



Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Saúde Mental e Psicosocial

Data:	14/07/2026
Contrato/Dispositivo:	Saquarema / CAPS II.
Participantes:	Arnaldo – Coordenador do CAPS II de Saquarema. Joane Oliveira - Supervisora de Rede de Cuidados.
Atividades Gerenciais:	Supervisão.
Tipo de atividade:	Reunião presencial - instrução, planejamento e gestão

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

- Realizada visita técnica ao CAPS II de Saquarema com o objetivo de prestar apoio técnico à coordenação da unidade quanto ao registro e monitoramento da produção ambulatorial em saúde mental.
- Durante a visita, foram apresentadas orientações sobre o funcionamento da RAAS (Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde), abordando os critérios para registro dos atendimentos, os códigos de procedimentos passíveis de faturamento e sua correta utilização, conforme as normativas vigentes do Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS).
- Foram esclarecidas as formas de conferência do quantitativo de atendimentos registrados na RAAS e sua compatibilidade com os relatórios de produção da unidade, reforçando a importância da consistência entre os registros assistenciais e os dados encaminhados ao Ministério da Saúde.
- Foi demonstrado o procedimento para consulta e verificação da produção do CAPS II processada pelo Sistema de Informação Ambulatorial do SUS, permitindo o acompanhamento da produção efetivamente enviada ao Ministério da Saúde e a identificação de possíveis inconsistências.
- Foi enfatizada a importância do correto preenchimento da RAAS para garantir a qualidade da informação em saúde, subsidiar o planejamento e a avaliação dos serviços, fortalecer os indicadores da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e contribuir para o adequado financiamento da assistência em saúde mental.

Inconformidades:

Verificou-se a necessidade de aprimoramento do processo de monitoramento da produção registrada na RAAS e da conferência sistemática dos dados encaminhados ao Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS), visando assegurar a consistência das informações registradas e evitar divergências entre a produção realizada e a produção processada.

Apontamentos:

Responsável local: Arnaldo – Coordenador do CAPS II de Saquarema.



Apontamentos realizados: Orientado quanto ao correto registro das ações na RAAS e à utilização adequada dos códigos de procedimentos. Reforçada a necessidade de monitoramento periódico da produção registrada e da conferência dos relatórios encaminhados ao Ministério da Saúde. Demonstrado o procedimento para consulta da produção processada no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS, visando maior controle gerencial dos dados. Pactuado que a coordenação da unidade realizará acompanhamento contínuo da produção assistencial, promovendo a conferência periódica entre os registros da RAAS e os relatórios de produção, com o objetivo de reduzir inconsistências e qualificar a informação enviada ao Ministério da Saúde.

Prazo pactuado para alinhamento:

30 dias

Resultados desejados (melhorias):

Padronização dos registros da RAAS e correta utilização dos códigos de procedimentos. Maior confiabilidade e consistência das informações assistenciais encaminhadas ao Ministério da Saúde. Redução de inconsistências entre a produção realizada, registrada e processada. Fortalecimento do monitoramento dos indicadores assistenciais do CAPS II. Qualificação da gestão da informação e do faturamento ambulatorial, contribuindo para o adequado financiamento da unidade e para o planejamento das ações da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).



Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Saúde Mental e Psicosocial

Data:	14/07/2026
Contrato/Dispositivo:	Saquarema/CAPS AD
Participantes:	Vanessa Mendonça- Supervisora de Rede de Cuidados, Joane Oliveira- Supervisora de Rede de Cuidados e Fraciele Lima - Supervisora de Rede de Cuidados
Atividades Gerenciais:	Supervisão
Tipo de atividade:	Reunião presencial - instrução, planejamento e gestão

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Alinhamento com a gestão interina: Realização de reunião de orientação com o psicólogo Marcos, que está respondendo temporariamente pela coordenação da unidade devido ao afastamento médico da coordenadora Larissa.

Aprimoramento dos Projetos Terapêuticos: Entrega de um novo modelo de projeto terapêutico para subsidiar e padronizar a revisão dos Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) dos usuários atendidos na unidade.

Planejamento de Atividades Terapêuticas: Apresentação e entrega do cronograma de atividades semanais para avaliação da coordenação, contendo propostas de novos grupos e oficinas terapêuticas visando uma maior adesão e participação dos técnicos do setor.

Suporte técnico à equipe: Oferta de suporte e assessoria técnica para auxiliar os profissionais da unidade no manejo metodológico e na condução prática dos grupos e oficinas.

Fluxo de segurança e controle de acesso: Alinhamento técnico sobre o correto posicionamento do controlador de acesso na área externa do dispositivo de saúde.

Manutenção predial e manejo de resíduos: Recebimento e encaminhamento de demandas estruturais urgentes trazidas pela coordenação interina referentes à troca da caixa d'água e ao descarte adequado de resíduos alimentares da cozinha.

Inconformidades:

Necessidade de atualização instrumental (PTS): Importância de padronizar e atualizar as ferramentas de registro clínico, garantindo que os Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) dos usuários reflitam as diretrizes atuais de cuidado em saúde mental.

Necessidade de otimização das atividades terapêuticas: Oportunidade de ampliação e fortalecimento da grade de grupos e oficinas semanais para garantir a oferta de cuidados integrais e diversificados, em consonância com as diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS - Portaria de Consolidação nº 3/2017).

Inadequação no descarte de resíduos alimentares: Identificado que sobras de alimentos descartadas na área interna de fácil acesso estavam sendo manuseadas por usuários. Essa prática gera riscos de vulnerabilidade à saúde e infringe as normas de vigilância sanitária



(Resolução RDC ANVISA nº 222/2018, que dispõe sobre as Boas Práticas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde).
Demanda de infraestrutura física: Necessidade de substituição urgente da caixa d'água da unidade para garantir o abastecimento seguro e a potabilidade da água consumida por usuários e servidores.
Desvio de posicionamento na segurança: Necessidade de ajuste no posto de trabalho do controlador de acesso, que deve atuar estritamente na área externa do dispositivo para melhor triagem e preservação do ambiente terapêutico interno.

Apontamentos:

Responsável local: Marcos (Coordenador Interino).
Encaminhamentos e deliberações:
O coordenador Marcos recebeu o novo modelo de projeto terapêutico e ficou responsável por articular junto à equipe técnica a revisão e atualização dos PTS dos usuários. O coordenador Marcos assumiu o compromisso de apresentar e discutir o novo cronograma de atividades semanais (grupos e oficinas) com toda a equipe técnica da unidade. Colocamo-nos à disposição imediata para dar suporte prático aos técnicos quanto ao manejo dos grupos apresentados. Foi orientado que o controlador de acesso seja reposicionado para realizar suas atribuições na área externa do dispositivo de forma permanente. As demandas emergenciais (troca da caixa d'água e alteração no fluxo de descarte de alimentos da cozinha para a área externa, evitando o acesso dos usuários ao lixo) foram registradas e formalmente repassadas ao Subgerente de Contratos para providências imediatas.

Prazo pactuado para alinhamento:

30 dias

Resultados desejados (melhorias):

Projetos Terapêuticos Singulares atualizados: Qualificação e padronização dos registros de evolução e planejamento clínico (PTS) de cada usuário com base no novo modelo entregue. Dinâmica terapêutica fortalecida: Implantação de um cronograma semanal de oficinas e grupos mais atrativo, com maior envolvimento do corpo técnico e ampliação da oferta de cuidado aos usuários. Segurança e vigilância sanitária adequadas: Eliminação do risco de contaminação e exposição de usuários ao lixo por meio do descarte seguro e isolado dos resíduos alimentares pela cozinha, além do restabelecimento pleno do abastecimento de água com a nova caixa d'água. Organização e segurança do fluxo de entrada: Melhoria na triagem e na segurança do dispositivo com a atuação do controlador de acesso posicionado corretamente na área externa.



**PRIMA
QUALITÀ
SAÚDE**

PRIMA QUALITÀ SAÚDE
PROJETO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL - PTI

Data de abertura do PTI: _____

1. IDENTIFICAÇÃO
Nome: _____
Endereço: _____
Data de nascimento: _____ Idade: _____ Cel: _____
Profissional de referência: _____
Equipe de referência: _____
Estr. de referência: _____
Razão de apoio: _____

2. HIPÓTESE DIAGNÓSTICA: _____

3. JUSTIFICATIVA DO TRATAMENTO NO SERVIÇO / HISTÓRICO PSICOSSOCIAL: _____

4. OBJETIVOS:
CURTO PRAZO: _____
MÉDIO PRAZO: _____
LONGO PRAZO: _____

5. CONDIÇÕES TERAPÊUTICAS: _____

www.primaqualitasaude.org
Travessa do Ouvidor, 21 - Sala 503
Centro - Rio de Janeiro/RJ - Cep: 20.040-040
Telefone: 21 20424250
CNPJ: 40.289.134/0001-99

**CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
CAPS AD**

Horário	Segunda	Terceira	Quarta	Quinta	Sexta
08:00 às 08:30	Café da manhã	Café da manhã	Café da manhã	Café da manhã	Café da manhã
08:30 às 09:30	Grupo Bom dia	Reunido de equipe	Grupo Bom dia	Grupo Bom dia	Grupo Bom dia
09:30 às 11:00	Grupo AD Mediador Dr. Omar	Reunido de equipe	Oficina de base Mediador Priscila e Nathany	Oficina de resiliência Mediador Nathany e Marcelo	Oficina de resiliência Mediador Nathany e Marcelo
11:30	Almoço	Almoço	Almoço	Almoço	Almoço
13:00	Convivência (Livre)	Convivência (Livre)	Convivência (Livre)	Convivência (Livre)	Convivência (Livre)
14:30 às 15:30	Oficina de culinária Mediador Priscila	Grupo terapêutico Lapas e vivências Mediador Psicólogo	Oficina de base Mediador Priscila	Grupo entre elas (feminino) Mediador Psicólogo	Oficina de atividades Mediador Ramona
			Grupo terapêutico Papo reto (masculino) Mediador Psicólogo de Assistência social		Cine CAPS AD Mediador Thayla e Aline Leites

13:30
às
14:00
Lanche

14:00
às
15:00
Lanche

15:00
às
16:00
Lanche

16:00
às
17:00
Lanche

17:00
às
18:00
Lanche

18:00
às
19:00
Lanche

19:00
às
20:00
Lanche

20:00
às
21:00
Lanche

Observação:
Assessoria (mediador: Tatiane e Viviane) - Primeira quarta-feira do mês.
Grupo de família - Última terça-feira do mês.
Grupo terapêutico Lapas e vivências - Grupo terapêutico misto.
Grupo terapêutico Papo reto (masculino) - Grupo será relacionado a vivências masculinas.
Grupo entre elas (feminino) - Grupo será relacionado a vivências femininas.
Grupo resiliência - O mediador terá temas relacionados a saúde por sugestões dos usuários (Integra, vídeos, convulsões de APTs).
Oficina de artesanato do mês - Última sexta-feira do mês.

PRIMA QUALITÀ SAÚDE

() Atendimento Psicológico
() Atendimento de Terapias Sociais
() Atendimento Psiquiátrico
() Atendimento em grupo
() Grupo de família
() Atendimento AD
() Visita domiciliar
() Matriculamento

6. FREQUÊNCIA: () SEM () TER () QU () QUA () SEX

7. OFICINAS TERAPÊUTICAS: _____

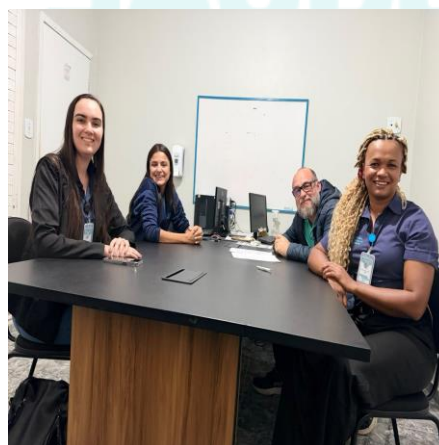
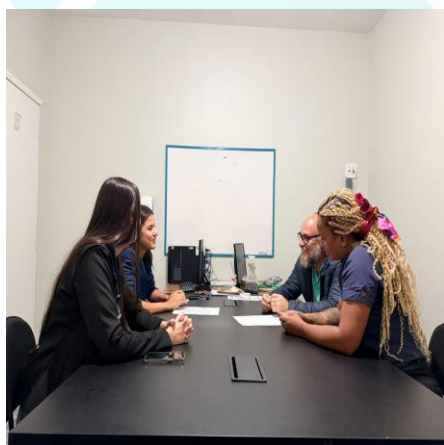
8. DATA DE REAVALIAÇÃO DO PTI: _____

ASSINATURA DO USUÁRIO: _____

ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE REFERÊNCIA: _____

ASSINATURA DO FAMILIAR: _____

www.primaqualitasaude.org
Travessa do Ouvidor, 21 - Sala 503
Centro - Rio de Janeiro/RJ - Cep: 20.040-040
Telefone: 21 20424250
CNPJ: 40.289.134/0001-99



www.primaqualitasaude.org

Travessa do Ouvidor, 21 - Sala 503
Centro - Rio de Janeiro/RJ - Cep: 20.040-040
Telefone: 21 20424250
CNPJ: 40.289.134/0001-99



Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Saúde Mental e Psicosocial

Data: 14/07/2026
Contrato/Dispositivo: Caps AD / Saquarema
Participantes: Franciele de Lima - Supervisora de Rede de Cuidados.
Marcos Aurélio - Coordenador Interino
Joane Oliveira - Supervisora de Rede de Cuidados
Atividades Gerenciais: Reunião de equipe
Tipo de atividade: Reunião presencial - instrução, planejamento e gestão

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Participação em reunião de equipe do CAPS AD

Durante o período da manhã, foi realizada participação na reunião de equipe do CAPS AD, conduzida pelo coordenador interino, psicólogo Marcos Aurélio Moraes, que está respondendo temporariamente pela coordenação da unidade em substituição à coordenadora titular Larissa, durante seu período de férias e afastamento por atestado médico.

A reunião teve como objetivo acompanhar os processos de trabalho da equipe, identificar demandas assistenciais, administrativas e estruturais da unidade, além de fortalecer o alinhamento entre os profissionais envolvidos no cuidado aos usuários do serviço.

Durante o encontro, foram apresentados pontos relacionados à organização dos espaços, manutenção da estrutura física e fluxos internos da unidade, destacando-se:

Fluxo de descarte de resíduos alimentares

A equipe relatou que alimentos provenientes da cozinha da unidade estão sendo descartados em lixeira com acesso facilitado, situação que tem possibilitado que alguns usuários do CAPS AD manipulem os resíduos descartados.

O tema foi discutido considerando os impactos relacionados à organização do ambiente terapêutico, segurança alimentar, higiene, preservação da dignidade dos usuários e necessidade de adequação dos processos internos da unidade.

Condições estruturais relacionadas ao abastecimento de água

Foi identificada a necessidade de substituição da caixa d'água da unidade, visando garantir melhores condições de armazenamento e qualidade da água disponibilizada aos usuários e trabalhadores, contribuindo para a segurança sanitária do serviço.



A demanda foi sinalizada para avaliação e encaminhamento junto aos responsáveis pela gestão contratual.

Inconformidades:

Descarte inadequado de resíduos alimentares

Foi identificada a necessidade de revisão do fluxo de descarte dos alimentos provenientes da cozinha, considerando que o descarte em local acessível permite que usuários tenham contato com resíduos alimentares, podendo gerar riscos relacionados à higiene, segurança sanitária e organização do ambiente assistencial.

Referências relacionadas:

Boas práticas de manipulação e gerenciamento de resíduos em serviços de alimentação; Normas sanitárias aplicáveis aos serviços de saúde; Princípios da Política Nacional de Humanização (PNH), relacionados ao cuidado, acolhimento e respeito à pessoa usuária.

Necessidade de adequação da estrutura física – caixa d'água

Foi apontada a necessidade de substituição da caixa d'água da unidade, considerando a importância de garantir condições adequadas de armazenamento e fornecimento de água para usuários e trabalhadores.

Referências relacionadas:

Normas da Vigilância Sanitária aplicáveis às condições estruturais dos serviços de saúde; RDC ANVISA nº 63/2011 – Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde.

Apontamentos:

Coordenador interino - Marcos Aurélio
Coordenador de contrato - Jorge Antônio

O ocorrido referente ao descarte de alimentos foi comunicado ao Coordenador de Contrato, Sr. Jorge Antonio, para ciência e avaliação das providências necessárias junto à unidade. Foi orientada a revisão imediata do fluxo de descarte dos resíduos alimentares, buscando estabelecer uma rotina que impeça o acesso de usuários aos descartes e mantenha condições adequadas de higiene e segurança. Foi reforçada a necessidade de avaliação técnica para substituição da caixa d'água, com objetivo de garantir melhores condições sanitárias e segurança no fornecimento de água. Orientou-se que as demandas identificadas sejam acompanhadas pela gestão local, com definição de responsáveis e prazos para resolução.

Prazo pactuado para alinhamento:



30 dias

Resultados desejados (melhorias):

Adequação do fluxo de descarte de resíduos alimentares, garantindo organização, higiene, segurança e preservação da dignidade dos usuários atendidos. Redução de riscos sanitários relacionados ao manejo inadequado de resíduos. Melhoria das condições estruturais da unidade por meio da substituição da caixa d'água, assegurando qualidade da água ofertada aos usuários e profissionais. Fortalecimento da gestão compartilhada entre equipe assistencial, coordenação da unidade e gestão contratual. Garantia de um ambiente terapêutico seguro, acolhedor e alinhado às diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).





Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Saúde Mental e Psicosocial

Data:	21/07/2026
Contrato/Dispositivo:	Arrail do Cabo/ CAPS I e Casa do Autista
Participantes:	Vanessa Mendonça- Supervisora de Rede de Cuidados, Joane de Oliveira - Supervisora de Rede de Cuidados, Jenefer Coordenadora do CAPS e Bruna Coordenadora de Saúde Mental
Atividades Gerenciais:	Supervisão e reunião de coordenação
Tipo de atividade:	Reunião presencial - instrução, planejamento e gestão

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Avaliação do Processo de Trabalho do CAPS I Nise da Silveira: Realizada visita técnica para acompanhamento das rotinas e fluxos da unidade. Alinhamento do Fluxo de Atendimento com o Pronto Atendimento (PU) de Figueira: A coordenação (Bruna) apresentou a preocupação com a ausência de notificações do PU referentes à entrada de usuários em crise. Para sanar essa lacuna, pactuou-se a criação de um grupo de comunicação instantânea (WhatsApp), aos moldes do fluxo já utilizado com o leito hospitalar. A coordenação de Saúde Mental (Bruna) ficou responsável por alinhar o alinhamento com Olívia e criar o grupo integrando Olívia, o Serviço Social, Jenefer, a supervisão da Rede de Cuidados e a própria Bruna. Mapeamento de Processos via Sistema SEI: Informado pela coordenação que as notificações e demandas relativas a processos de judicialização agora tramitam via Sistema SEI. Acompanhamento de Caso Complexo (Usuário em Acolhimento no Hospital Pinel): Discutido o caso de usuário internado no Hospital Pinel com solicitação de alta pelo Ministério Público. Como a família recusa o recebimento por tratar-se de quadro crônico e o município ainda não dispõe de Residência Terapêutica (RT), Bruna reportou que levará a pauta ao Secretário e que foi solicitada uma reunião entre Saúde Mental e Assistência Social. A Supervisão colocou-se à disposição para articular essa agenda intersetorial. Cronograma de Visitas aos Leitos RPT: Alinhado com a coordenação (Jenefer) que os leitos não devem permanecer sem o devido acompanhamento e visita dos técnicos da unidade. Articulação da Rede e Participação em Fóruns Intersetoriais: Reforçada a importância do alinhamento da equipe na rede e da presença contínua do CAPS nos Fóruns Regionais (Fórum de Álcool e Outras Drogas, na primeira quinta-feira do mês, e Fórum Infantojuvenil, na última quinta-feira do mês). Gestão de Ofícios e Fluxo Administrativo/Jurídico: Pontuado por Jenefer a ocorrência de reiterações desnecessárias de ofícios por parte dos setores jurídico e administrativo do município, solicitando respostas para demandas que já foram formalmente respondidas pela unidade.

Funcionamento do Setor Terapêutico e Demandas de Insumos: Observada a realização de



oficinas e grupos terapêuticos. Contudo, identifica-se a persistência da falta de insumos para a manutenção das atividades e a necessidade de aquisição de uma caixa de som para viabilizar as oficinas de música e dança. Planejamento de Evento Comunitário: Confirmada a realização da Festa Agostina da unidade no mês de agosto.

Inconformidades:

Falha de Comunicação na Rede de Urgência: Ausência de notificação sistemática por parte do PU de Figueira ao CAPS sobre o acolhimento de usuários em crise, em desacordo com as diretrizes de articulação de rede previstas na Portaria de Consolidação GM/MS nº 3/2017 (Rede de Atenção Psicossocial - RAPS).

Descontinuidade Temporária de Acompanhamento Técnico: Identificação de períodos sem a devida visita dos técnicos do CAPS aos leitos em hospital geral, comprometendo a continuidade do cuidado e o PTS (Projeto Terapêutico Singular). Falta recorrente de insumos para oficinas e ausência de equipamentos básicos de som, fragilizando a execução das ações reabilitadoras previstas no modelo de atenção psicossocial.

Incongruência no Trâmite de Documentos: Retrabalho e retransmissão de solicitações formais por parte dos setores jurídico/administrativo para ofícios que já possuem resposta protocolada.

Apontamentos:

Responsáveis Locais: Jenefer (Coordenadora do CAPS) e Bruna (Coordenadora de Saúde Mental).

Orientações e Acordos: Fluxo com PU Figueira: Bruna realizará contato com Olívia para criação do grupo de pactuação via WhatsApp até a próxima semana, incluindo Serviço Social, Jenefer e Supervisão.

Intersetorialidade e Judicialização: Alinhada a realização de reunião conjunta entre Saúde Mental, Assistência Social e Secretaria de Saúde para deliberação sobre o caso do usuário no Hospital Pinel e estratégias municipais de moradia protegida.

Visitas aos Leitos e Fóruns: Jenefer reorganizará a escala técnica da unidade para garantir o cumprimento das visitas periódicas aos leitos e a participação assídua do CAPS nos Fóruns de Saúde Mental (1ª e última quinta-feira do mês).

Fluxo de Ofícios: A Supervisão e a Gestão local alinharão diálogo com os setores administrativo e jurídico para saneamento de dúvidas sobre solicitações já respondidas no SEI.

Prazo pactuado para alinhamento:

30 dias

Resultados desejados (melhorias):



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

Efetivação do Fluxo de Comunicação na Urgência: Notificação imediata dos casos em crise acolhidos no PU de Figueira ao CAPS, garantindo vínculo e matriciamento do cuidado. Garantia da Continuidade Assistencial: Manutenção regular das visitas técnicas aos leitos e presença ativa do dispositivo nos espaços formais de articulação da RAPS (Fóruns). Aprimoramento da Comunicação Intersetorial: Pactuação de estratégias entre Saúde, Assistência Social e Sistema de Justiça para o correto direcionamento de casos crônicos de alta hospitalar. Otimização Processual e Redução de Retrabalho: Regularização e alinhamento dos fluxos de respostas a ofícios via SEI com a gestão central. Fortalecimento das Ações Terapêuticas: Abastecimento contínuo de insumos e provimento de equipamentos de som para o pleno funcionamento das oficinas expressivas e de reabilitação psicossocial do CAPS.





Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Saúde Mental e Psicosocial

Data:	21/07/2026
Contrato/Dispositivo:	Arrail do Cabo/ Caso do Autista
Participantes:	Vanessa Mendonça – Supervisora da Rede de Cuidados Joane de Oliveira – Supervisora da Rede de Cuidados Letícia – Assistente Social da Casa do Autista (representando a gestão local durante a visita)
Atividades Gerenciais:	Supervisão
Tipo de atividade:	Reunião presencial - instrução, planejamento e gestão

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Visita Técnica e Acolhimento: Realizada visita técnica à Casa do Autista com o objetivo de prestar orientação e acompanhamento do processo de trabalho da unidade. A equipe de supervisão foi recebida pela Assistente Social Letícia, tendo em vista que a Coordenadora da unidade, Mônica, estava ausente para realização de exames médicos.

Composição do Quadro de Pessoal: A unidade informou a ampliação da equipe de Fonoaudiologia, que agora conta com três profissionais, sendo duas recentes integrações ao quadro de servidores/técnicos.

Readequação da Infraestrutura Física: Identificada a execução de obras de reforma na sala anteriormente destinada a atividades coletivas, visando a sua subdivisão para a criação de dois novos consultórios de atendimento.

Mapeamento da Estrutura Atual: A unidade conta atualmente com cinco consultórios, um refeitório e uma sala de integração sensorial.

Articulação em Rede e Capacitação Profissional: Fórum da Infância: Reforçada a relevância da participação assídua da equipe no Fórum da Infância e Juventude, que ocorre na última quinta-feira de cada mês no campus da UERJ.

Congresso de Autismo em Niterói: Alinhada a participação da equipe no Congresso de Autismo, a ser realizado nos dias 27 e 28 em Niterói, destacando a importância do aprimoramento técnico e atualização das práticas assistenciais.

Programação de Atividades Comunitárias e Extramuros: Organização da Festa Junina da unidade prevista para ser realizada na próxima terça-feira.

Agendamento de passeio cultural direcionado exclusivamente aos familiares/responsáveis no Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas (Feira de São Cristóvão) para o dia 31 de julho.

Planejamento contínuo da equipe para a realização de novos passeios e atividades externas englobando tanto os usuários quanto seus familiares.

Demandas de Manutenção e Recursos Terapêuticos: Levantamento de necessidades



estruturais e materiais da unidade, destacando-se a demanda de manutenção em quatro aparelhos de ar-condicionado, reparos na sala sensorial e o aguardo no recebimento de materiais pedagógico-artísticos e jogos terapêuticos.

Inconformidades:

Necessidade de Manutenção e Climatização de Ambientes: Presença de quatro aparelhos de ar-condicionado sem o devido funcionamento ou manutenção, bem como pendências de reparos na sala de integração sensorial. Ausência de fornecimento regular de insumos artísticos e jogos terapêuticos para a condução das atividades operacionais da unidade, limitando a plena execução dos planos terapêuticos individuais e de grupo.

Apontamentos:

Responsável Local Interina/Contato no Momento: Letícia (Assistente Social) / Mônica (Coordenadora da Unidade). Orientações e Acordos: Participação em Fóruns e Congressos: Pactuado o alinhamento da escala da equipe para garantir a representação da Casa do Autista no Fórum da Infância (última quinta-feira do mês na UERJ) e a organização dos profissionais para participação no Congresso de Autismo em Niterói (dias 27 e 28). Acompanhamento de Obras e Adequação de Espaço: Orientado que a reestruturação física para novos consultórios preserve horários e espaços adequados para as dinâmicas de grupo e suporte aos familiares. Acompanhamento do Recebimento de Insumos: Alinhado que a coordenação repasse à gestão central a relação dos materiais pedagógicos e jogos terapêuticos essenciais pendentes para a devida celeridade na entrega.

Prazo pactuado para alinhamento:

30 dias

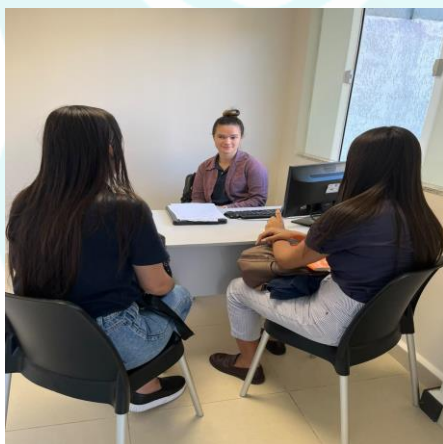
Resultados desejados (melhorias):

Fortalecimento Institucional e Educação Permanente: Presença ativa da equipe nos espaços formais de debate (Fórum da Infância na UERJ) e qualificação técnica por meio da participação no Congresso de Autismo em Niterói. Adequação da Infraestrutura e Climatização: Regularização do funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado e plena manutenção da sala sensorial, garantindo um ambiente adequado e acolhedor aos usuários. Provimento de Recursos Terapêuticos: Abastecimento contínuo de materiais artísticos e recursos pedagógicos/jogos para qualificar as intervenções multiprofissionais. Otimização da Capacidade Assistencial: Conclusão da ampliação dos consultórios e integração efetiva das novas fonoaudiólogas, reduzindo o tempo de espera e ampliando o número de atendimentos.



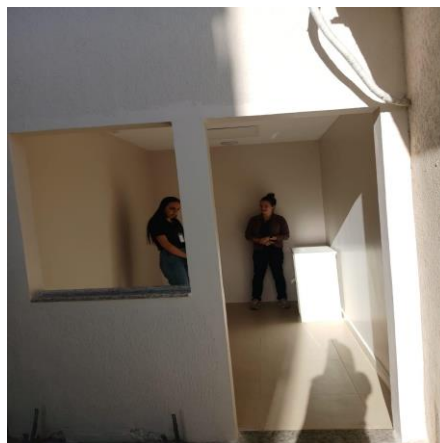
**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

Fortalecimento do Vínculo Comunitário e Familiar: Consolidação das agendas extramuros (passeios e eventos culturais) como ferramenta de inclusão social, fortalecimento do cuidado em rede e suporte às famílias.





**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

www.primaqualitasaude.org

Travessa do Ouvidor, 21 - Sala 503
Centro - Rio de Janeiro/RJ - Cep: 20.040-040
Telefone: 21 20424250
CNPJ: 40.289.134/0001-99



Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Saúde Mental e Psicosocial

Data:	21/07/2026
Contrato/Dispositivo:	Saquarema - Caps AD.
Participantes:	Franciele de Lima - Supervisora de Rede de Cuidados . Marcos Aurélio - Coordenador Interino .
Atividades Gerenciais:	Visita técnica / Reunião presencial - instrução , planejamento e gestão.
Tipo de atividade:	Reunião presencial - instrução, planejamento e gestão, Visita técnica

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Durante o acompanhamento da unidade, foi verificada a realização da troca do bebedouro disponibilizado para uso dos usuários e colaboradores do CAPS AD. Entretanto, após a substituição, foi identificado que a saída de água do equipamento apresenta baixa vazão, comprometendo seu funcionamento adequado e o acesso regular à água. Diante da identificação da baixa vazão de água, foi sinalizada a necessidade de acionamento da equipe de manutenção para avaliação do equipamento e verificação das possíveis causas do problema, com o objetivo de realizar os ajustes ou reparos necessários. Capacitação para melhoria da produção no sistema. Durante a reunião de equipe, os profissionais manifestaram interesse e solicitaram a realização de capacitação relacionada ao registro e lançamento da produção assistencial no sistema utilizado pela unidade. A solicitação tem como objetivo ampliar o conhecimento dos profissionais quanto aos procedimentos, registros e formas adequadas de alimentação do sistema, contribuindo para a qualificação dos dados registrados e para a evolução da produção da unidade. Qualificação dos registros e da produção assistencial. Foi reforçada a importância da realização dos registros de forma correta, completa e padronizada, considerando que a qualidade das informações inseridas no sistema contribui para o acompanhamento dos atendimentos realizados, monitoramento dos indicadores, avaliação da produtividade da equipe e planejamento das ações de saúde mental.

Inconformidades:

Bebedouro recém-substituído apresentando baixa vazão na saída de água, comprometendo o funcionamento adequado do equipamento. Necessidade de avaliação técnica pela equipe de manutenção para identificação e resolução do problema. Necessidade de fortalecimento do conhecimento da equipe quanto aos registros de produção no sistema, considerando a solicitação dos profissionais por capacitação específica. Possível necessidade de padronização dos registros assistenciais e dos procedimentos.



realizados pela equipe, visando reduzir inconsistências e melhorar a qualidade das informações inseridas no sistema.

Apontamentos:

Marcos Aurélio - Coordenador Interino .

Prazo pactuado para alinhamento:

30 dias

Resultados desejados (melhorias):

Regularização do funcionamento do bebedouro, garantindo vazão adequada e acesso contínuo à água para usuários e colaboradores. Atendimento da solicitação de manutenção e resolução do problema identificado no equipamento.

Capacitação da equipe do CAPS AD quanto ao correto preenchimento e lançamento das produções no sistema.

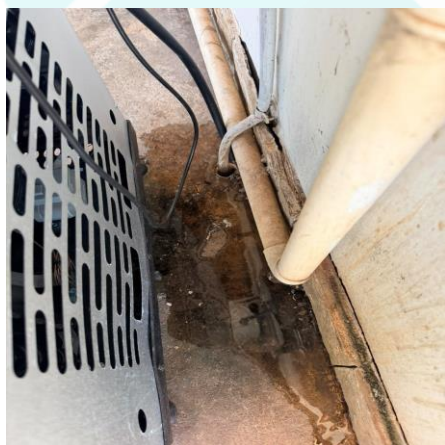
Aumento da qualidade e da consistência dos registros assistenciais realizados pelos profissionais.

Melhoria da produção registrada no sistema, de acordo com as atividades efetivamente desenvolvidas pela equipe.

Redução de inconsistências e perdas de produção decorrentes de registros inadequados ou incompletos.

Maior segurança e confiabilidade das informações utilizadas para monitoramento dos indicadores e avaliação da assistência prestada.

Fortalecimento do processo de educação permanente e qualificação da equipe do CAPS AD.





Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Saúde Mental e Psicosocial

Data: 23/07/2026
Contrato/Dispositivo: Saquarema/ Ambulatório de Saúde Mental
Participantes: Vanessa Mendonça- Supervisora de Rede de Cuidado, Natalia -Coordenadora do Teleatendimento, Lilian- Coordenadora de Saúde Mental, Roseli- Psicóloga e Ingrid- Coordenado do Abulatório
Atividades Gerenciais: Reunião de Coordenação
Tipo de atividade: Reunião presencial - instrução, planejamento e gestão

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Alinhamento do Teleatendimento: Avaliação do dimensionamento da equipe, oferta de vagas e alinhamento do perfil do paciente junto às Estratégias de Saúde da Família (ESF) e à Central de Regulação. Comunicação e Articulação da Rede: Dificuldades técnicas na comunicação telefônica do ambulatório e gargalos no fluxo de comparecimento dos usuários encaminhados pelas ESF. Demanda Assistencial em Psicologia: Identificação do aumento progressivo da fila de espera em Psicologia e proposição de articulação com eMulti e Atenção Primária para qualificação dos encaminhamentos.

Inconformidades:

Instabilidade/dificuldade no funcionamento do telefone da unidade, prejudicando a comunicação com os Pacientes. Necessidade de maior orientação na ponta (ESF) sobre o perfil adequado do paciente para o teleatendimento, conforme diretrizes de regulação. Morosidade e demora no fluxo de chegada dos usuários à unidade após a articulação com as ESF. Crescimento contínuo da fila de espera para atendimento em Psicologia, evidenciando a necessidade de alinhamento sobre os critérios de encaminhamento.

Apontamentos:

Responsável: Nathalia.
Apontamentos e Deliberações:
Alinhamento sobre o serviço de teleatendimento, quantitativo de profissionais envolvidos e oferta de vagas.
Registro informado por Lilian de que o Dr. Luiz tem ido às ESF para orientar os médicos sobre o perfil de paciente indicado para o teleatendimento.



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

Realização de visita posterior à Central de Regulação para conversa direta com o Dr. Luiz e alinhamento do fluxo. Acordada a necessidade de agendar reunião entre a equipe do ambulatório, eMulti e Atenção Primária para compreender a demanda e alinhar os encaminhamentos da

Prazo pactuado para alinhamento:

30 dias

Resultados desejados (melhorias):

Maior alinhamento dos médicos da ponta quanto ao perfil do paciente para teleatendimento, otimizando o uso das vagas. Resolutividade na comunicação telefônica e maior agilidade na chegada dos usuários encaminhados pelas ESF. Compreensão e qualificação dos critérios de encaminhamento para a Psicologia em conjunto com eMulti e Atenção Primária.





Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Saúde Mental e Psicosocial

Data: 23/07/2026
Contrato/Dispositivo: Saquarema/ CAPS AD
Participantes: Vanessa Mendonça, Joane de Oliveira, Franciele Lima-
Supervisoras de Rede de Cuidados e Larissa- Coordenadora
do CAPS AD
Atividades Gerenciais: Supervisão
Tipo de atividade: Reunião online - instrução, planejamento e gestão

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Atividades Gerenciais: Reunião com Coordenação
Tipo de atividade: Reunião presencial - instrução, planejamento e gestão
Tópicos com descrição organizada dos assuntos:
Alinhamento do Setor Terapêutico: Proposta de reorganização do cronograma de atendimento e diretrizes para atualização dos grupos e oficinas terapêuticas do CAPS AD.
Gestão de Apoio Operacional: Registro de futuro desligamento do profissional do controle de acesso e alinhamento quanto à substituição do posto que será realizada pela empresa contratada.

Inconformidades:

Necessidade de adequação e atualização contínua do rol de oficinas e grupos terapêuticos oferecidos, visando garantir o alinhamento do Projeto Terapêutico Singular (PTS) às diretrizes do Modelo de Atenção Psicossocial (Portaria de Consolidação GM/MS no 3/2017).
Necessidade de acompanhamento da transição e substituição do controlador de acesso junto à empresa terceirizada, garantindo a manutenção contínua das atividades de portaria e recepção da unidade.

Apontamentos:

Apresentação da proposta de reorganização do cronograma do setor terapêutico. A coordenadora avaliou a proposta favoravelmente, pactuando a análise detalhada e a apresentação formal aos técnicos na reunião de equipe subsequente.
Orientação à equipe técnica sobre a necessidade de alinhamento e atualização do planejamento das oficinas e grupos.
Tomada de conhecimento quanto ao aviso de desligamento do controlador de acesso,



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

ciente de que a empresa contratada já foi notificada e realizará a devida substituição do profissional.

Prazo pactuado para alinhamento:

30 dias

Resultados desejados (melhorias):

Consolidação e pactuação do novo cronograma do setor terapêutico junto ao corpo técnico da unidade.

Atualização e diversificação da grade de oficinas e grupos terapêuticos ofertados aos Usuários.

Manutenção regular do fluxo de acolhimento e controle de acesso durante a futura Substituição do colaborador terceirizado.



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**



Atividades Desenvolvidas pela Rede de Cuidados: Atenção Saúde Mental e Psicosocial

Data:	27/07/2026
Contrato/Dispositivo:	Saquarema / E-mult - Atenção Primária à Saúde
Participantes:	Joane Oliveira - Supervisora de Rede de Cuidados. Mariana Lattanzi - Supervisora de Rede de Cuidados. Greiciane Sousa - Auxiliar Administrativo. Profissionais integrantes da eMulti de Saquarema.
Atividades Gerenciais:	Capacitação.
Tipo de atividade:	Capacitação e Educação Permanente

Tópicos com descrição organizada dos assuntos:

Foi realizada capacitação conduzida pela equipe de Supervisão da Atenção Primária à Saúde (APS), em conjunto com a equipe de Supervisão de Saúde Mental, destinada à equipe da eMulti de Saquarema, com foco na elaboração e implementação do Projeto Terapêutico Singular (PTS).

Durante a capacitação, foram abordados os seguintes temas:

Projeto Terapêutico Singular (PTS): apresentação dos conceitos, objetivos e etapas para elaboração e implementação do PTS, considerando as necessidades e especificidades de cada usuário acompanhado pela eMulti.
Estudos de caso: apresentação e discussão de casos práticos, contemplando diferentes situações de saúde e necessidades de cuidado.
Dinâmica para elaboração do PTS: realização de atividade prática em grupo, na qual os participantes foram orientados a elaborar um PTS com base nos casos apresentados, considerando a identificação das necessidades dos usuários, definição dos objetivos terapêuticos, planejamento das intervenções, identificação dos profissionais envolvidos e estabelecimento de estratégias de acompanhamento e monitoramento.
PTS no âmbito da Saúde Mental: apresentação do processo de elaboração e acompanhamento do PTS desenvolvido pelos serviços de Saúde Mental do município.
Fluxo de atuação dos CAPS: explanação sobre o fluxo de trabalho e a organização do cuidado realizado pelo CAPS II e CAPS AD.
Articulação em Rede: reforçada a importância da articulação entre a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), a Atenção Primária à Saúde e a eMulti, visando à integralidade do cuidado, à corresponsabilização das equipes e à continuidade da assistência aos usuários.

Inconformidades:

Não foram identificadas inconformidades durante a realização da capacitação. Ressalta-se, contudo, a necessidade de fortalecimento e sistematização da utilização do Projeto



Terapêutico Singular (PTS) pela eMulti, garantindo sua elaboração conforme as necessidades individuais dos usuários e a articulação com os demais pontos da Rede de Atenção à Saúde e da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Recomenda-se que os PTS elaborados sejam registrados e acompanhados pelas equipes responsáveis, com definição de objetivos, ações, profissionais envolvidos e periodicidade de reavaliação, de modo a assegurar a continuidade e a integralidade do cuidado.

Apontamentos:

Responsável local: Equipe da eMulti de Saquarema / Coordenação local. Durante a capacitação, foram repassadas orientações quanto à importância da elaboração e implementação do PTS para os usuários acompanhados pela eMulti, considerando as necessidades identificadas em cada caso. Foi orientada a utilização de estudos de caso e discussão compartilhada entre os profissionais como estratégia para qualificar a construção dos PTS, bem como a necessidade de articulação com a APS, os CAPS e os demais serviços da rede, sempre que necessário. Também foi reforçada a importância do acompanhamento sistemático dos casos, com monitoramento das ações propostas, reavaliação dos objetivos terapêuticos e atualização do PTS conforme a evolução das necessidades dos usuários.

Prazo pactuado para alinhamento:

30 dias

Resultados desejados (melhorias):

Fortalecer a capacidade técnica da equipe da eMulti para elaboração e implementação do Projeto Terapêutico Singular (PTS);
Qualificar o planejamento e a organização do cuidado individualizado aos usuários;
Ampliar a integração e a corresponsabilização entre a eMulti, a APS e os serviços de Saúde Mental;
Garantir a continuidade e a integralidade do cuidado em saúde;
Estimular o acompanhamento e o monitoramento sistemático dos PTS elaborados;
Promover uma assistência baseada nas necessidades individuais dos usuários, com definição compartilhada de objetivos e estratégias terapêuticas.



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**



**PRIMA
QUALITÁ
SAÚDE**

www.primaqualitasaude.org

Travessa do Ouvidor, 21 - Sala 503
Centro - Rio de Janeiro/RJ - Cep: 20.040-040
Telefone: 21 20424250
CNPJ: 40.289.134/0001-99



CONCLUSÃO

O conjunto de ações desenvolvidas ao longo de julho de 2026 evidencia o avanço progressivo na organização das Redes de Atenção à Saúde nos municípios de Santa Maria Madalena, Cachoeiras de Macacu, Arraial do Cabo, São Gonçalo, Saquarema, Cordeiro e Quissamã. A atuação integrada das Coordenações de Rede, apoiada pela inteligência assistencial e pela análise sistemática de indicadores, tem permitido aprimorar o acesso, a continuidade do cuidado e a resolutividade dos serviços, mesmo diante de cenários territoriais e epidemiológicos distintos.

Os resultados consolidados demonstram evolução em áreas estratégicas, como: qualificação de fluxos assistenciais, fortalecimento da Atenção Primária como ordenadora do cuidado, ampliação da comunicação entre pontos da rede, melhorias nos processos de regulação e intensificação das ações voltadas às linhas de urgência, saúde mental, atenção materno-infantil, especializada e reabilitação. Ao mesmo tempo, persistem desafios estruturais que exigem ações coordenadas, especialmente no que se refere à consolidação de processos padronizados, mitigação de barreiras assistenciais em territórios remotos, elevação da qualidade dos registros, redução de retrabalhos e ampliação da capacidade instalada em áreas críticas.

Diante desse cenário, reforça-se a necessidade de planejamento contínuo, pactuação de metas realistas por território, monitoramento sistemático da produção, qualificação permanente das equipes e fortalecimento das estratégias de cuidado centrado no usuário. Os achados deste relatório devem subsidiar decisões imediatas e orientar a priorização de esforços no próximo ciclo de gestão.

Por fim, destaca-se que a cooperação entre gestores, coordenações, equipes assistenciais permanece sendo o principal fator para consolidar uma Rede de Atenção mais resolutiva, eficiente e equânime. O compromisso com a melhoria dos desfechos em saúde, com a eficiência na aplicação dos recursos públicos e com o alinhamento às diretrizes do SUS segue como diretriz central que orienta as próximas etapas de trabalho.

Coordenação de Rede e Cuidado.

Cassandra Soares

Documento assinado digitalmente
gov.br CASSANDRA SOARES DE OLIVEIRA
Data: 02/09/2026 17:05:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Glaucia Capibaribe

Documento assinado digitalmente
gov.br GLAUCIA DE OLIVEIRA PINHEIRO CAPIBARIBE
Data: 02/09/2026 20:14:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ricardo Mangabeira

Documento assinado digitalmente por:
 **RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA**
079.881.457-89
2026-09-02T17:37:15.843167